BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình chăm sóc người bệnh tổng hợp

Bản cập nhật năm 2026 để trình thẩm định chuyên môn

Bộ tài liệu gồm 77 quy trình chăm sóc thuộc 6 nhóm chuyên khoa, hoàn thiện từ bản QTCS 2025 CAP NHAT (TONG HOP).docx. Điều dưỡng và hộ sinh sử dụng tiến trình nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá; phải cá thể hóa theo tình trạng từng người bệnh.

Trạng thái: dự thảo trình thẩm định. Ngày rà soát: 13/10/2026. Chưa có quyết định ban hành, ngày hiệu lực hoặc chữ ký phê duyệt.

Thông tin quản lý	Nội dung xác nhận
Mã và phiên bản	Mã đề xuất QTCS-TH — phiên bản 1.0 trình thẩm định
Biên soạn và thẩm định	……
Phê duyệt và ngày hiệu lực	……

Nguyên tắc sử dụng

Căn cứ tổ chức chăm sóc: Thông tư 31/2021/TT-BYT [1]. QĐ 3023/QĐ-BYT [2] áp dụng đề cương và thể thức cho các quy trình kỹ thuật riêng như tiêm, đặt ống, truyền dịch, hỗ trợ thủ thuật; không là nguồn quy định mọi thao tác lâm sàng và không thay thế tiến trình chăm sóc bệnh lý trong bộ này.

Nhân viên chỉ thực hiện kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn, năng lực đã đánh giá và phân công; thuốc, dịch, xét nghiệm và can thiệp điều trị thực hiện theo y lệnh hoặc phác đồ được phê duyệt. Khi phản vệ, xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT [3], không chờ y lệnh mới triển khai cấp cứu ban đầu.

Chẩn đoán điều dưỡng và mục tiêu trong từng quy trình là gợi ý để lựa chọn từ dữ liệu thực tế, không phải kết luận có sẵn cho mọi người bệnh. Mỗi mục tiêu phải có chỉ số hoặc hành vi quan sát, thời điểm đánh giá và người phụ trách. Ngưỡng sinh hiệu, oxy, dịch, dinh dưỡng và tần suất theo dõi phụ thuộc tuổi, bệnh nền, mức độ nặng và kế hoạch điều trị.

Dấu nguy hiểm xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào: đánh giá ABCDE, gọi bác sĩ hoặc đội cấp cứu theo quy định bệnh viện, xử trí ban đầu trong năng lực và tái đánh giá sau can thiệp. Không đợi hết chu kỳ ghi chép hoặc hết một khoảng thời gian theo dõi mới báo. Không ghi kết quả bình thường khi chưa đo hoặc chưa khám.

Hội đồng chuyên môn và khoa phụ trách cần xác nhận nội dung bệnh lý, danh mục kỹ thuật, phạm vi thực hành và liên kết quy trình đang áp dụng tại Nhật Tân trước ban hành. Hướng dẫn nước ngoài trong danh mục nguồn là căn cứ đối chiếu chuyên môn, không tự trở thành quy định pháp lý của bệnh viện.

Các bước chăm sóc dùng chung

Bước 1 Tiếp nhận và nhận định: định danh ít nhất hai thông tin, kiểm tra dị ứng, y lệnh, bệnh sử, sinh hiệu và nhu cầu ưu tiên; xác định dấu nguy hiểm, phân cấp chăm sóc và nguy cơ ngã, sặc, tì đè, nhiễm khuẩn theo tình trạng.

Bước 2 Chẩn đoán điều dưỡng: xác định vấn đề hiện có hoặc nguy cơ có căn cứ; ghi yếu tố liên quan và dữ liệu hỗ trợ, xếp ưu tiên đe dọa tính mạng trước.

Bước 3 Lập kế hoạch: cùng người bệnh hoặc người chăm sóc xác định mục tiêu, chỉ số theo dõi, thời điểm lượng giá, can thiệp và người phụ trách; đối chiếu y lệnh và khả năng khoa.

Bước 4 Chuẩn bị và thực hiện: giải thích, bảo đảm riêng tư, vệ sinh tay, chuẩn bị phương tiện, kiểm tra an toàn thuốc và kỹ thuật; thực hiện các can thiệp đã chọn và ghi giờ, kết quả.

Bước 5 Theo dõi và xử trí thay đổi: đánh giá đáp ứng, bất lợi và dấu nguy hiểm; báo bác sĩ kịp thời, ghi người nhận thông tin và xử trí, nhận định lại sau mỗi thay đổi quan trọng.

Bước 6 Đánh giá và bàn giao: so sánh từng mục tiêu với kết quả thực tế, ghi đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh cùng lý do; bàn giao vấn đề đang hoạt động, thuốc, dịch, thiết bị, nguy cơ và việc cần tiếp tục bằng SBAR hoặc ISBAR.

Bước 7 Giáo dục và kết thúc: kiểm tra người bệnh nhắc lại hướng dẫn thuốc, chăm sóc, dấu cần khám và lịch tái khám; hoàn tất hồ sơ và thông tin theo dõi sau ra viện theo chỉ định.

Nội dung cập nhật cần thẩm định

Sửa hướng dẫn nguy cơ cao về ngộ độc paracetamol, rắn cắn, bỏng hoặc chấn thương mắt, phản vệ, nuốt sau đột quỵ, phòng tổn thương tì đè, dinh dưỡng và dịch.

Sửa phần rối loạn dạng cơ thể đang mô tả nhầm rối loạn ám ảnh ngoại hình; sửa quy trình sinh giác hút đang chứa chăm sóc khám thai, thay bằng chăm sóc trước, trong và sau sinh hỗ trợ.

Bỏ dữ liệu của ca bệnh cụ thể trong 11 quy trình hồi sức; thay bằng yêu cầu nhận định thực tế. Bổ sung mục tiêu, trình tự thực hiện, dấu báo khẩn, đánh giá và bàn giao.

Giữ 77 mục của bản nền. Hai mục xuất huyết kết mạc có nội dung gần trùng được liên kết, chờ khoa mắt xác nhận có cần hợp nhất danh mục khi ban hành.

Thay các danh mục tham khảo không đủ thông tin xác minh bằng nguồn đối chiếu có đường dẫn. Không tiếp tục khẳng định số quyết định chuyên khoa, tên sách hoặc bài báo chưa kiểm chứng; bản nguồn được giữ để truy nguyên.

Danh mục quy trình

Chăm sóc các bệnh mắt

01 Quy trình chăm sóc viêm loét giác mạc
02 Quy trình chăm sóc bệnh khô mắt
03 Quy trình chăm sóc bệnh chắp
04 Quy trình chăm sóc xuất huyết dưới kết mạc
05 Quy trình chăm sóc hẹp và bít điểm lệ
06 Quy trình chăm sóc liệt dây thần kinh iii
07 Quy trình chăm sóc bệnh viêm giác mạc sợi
08 Quy trình chăm sóc bệnh võng mạc đái tháo đường
09 Quy trình chăm sóc bệnh xuất huyết kết mạc
10 Quy trình chăm sóc bệnh tắc nhánh tĩnh mạch võng mạc
11 Quy trình chăm sóc bệnh viêm kết mạc
12 Quy trình chăm sóc bệnh glaucoma góc đóng cơn cấp
13 Quy trình chăm sóc bệnh đục thủy tinh thể
14 Quy trình chăm sóc chấn thương mắt
15 Quy trình chăm sóc bệnh bỏng mắt
16 Quy trình chăm sóc bệnh mộng thịt

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

17 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ
18 Quy trình chăm sóc bệnh nhân giai đoạn trầm cảm
19 Quy trình chăm sóc người bệnh rối loạn dạng cơ thể
20 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn giấc ngủ
21 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa
22 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn nghi bệnh
23 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn stress sau sang chấn
24 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu
25 Quy trình chăm sóc bệnh nhân bệnh động kinh
26 Quy trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt

Chăm sóc nhi khoa

27 Quy trình chăm sóc bệnh nhân quai bị
28 Chăm sóc người bệnh sởi
29 Quy trình chăm sóc bệnh nhân ngộ độc acetaminophen
30 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rắn cắn

31 Quy trình chăm sóc bệnh nhân viêm tụy

Chăm sóc các bệnh tiêu hóa

32 Quy trình chăm sóc bệnh nhiễm trùng đường mật

33 Quy trình chăm sóc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

34 Quy trình chăm sóc bệnh áp xe gan do vi khuẩn (icd: k75.0)

35 Quy trình chăm sóc bệnh sỏi mật (icd 10: k80, k80.1, k80.2, k80.3, k80.4, k80.5, k80.8)

36 Quy trình chăm sóc bệnh táo bón (icd: k59.0)

37 Quy trình chăm sóc bệnh viêm dạ dày ruột và đại tràng không do nhiễm trùng (icd 10: k52, k52.8, k52.9)

38 Quy trình chăm sóc bệnh viêm dạ dày ruột và đại tràng do nhiễm trùng (icd 10: a09, a09.0)

Chăm sóc sản phụ khoa

39 Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó

40 Chăm sóc bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo

41 Chăm sóc bệnh lạc nội mạc tử cung

42 Chăm sóc sản phụ chuyển dạ đình trệ

43 Quy trình chăm sóc sản phụ chuyển dạ ngôi mông

44 Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn sau đẻ

45 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh

46 Quy trình chăm sóc sinh giác hút

47 Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ

48 Quy trình chăm sóc thai phụ ối vỡ non

49 Chăm sóc thai phụ suy thai

50 Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ

51 Quy trình chăm sóc băng huyết sau sanh

52 Quy trình chăm sóc bệnh hút thai

53 Quy trình chăm sóc các bước tiên lượng cuộc đẻ

54 Quy trình chăm sóc sản phụ mổ lấy thai

55 Quy trình chăm sóc sản phụ dọa sanh non

56 Quy trình chăm sóc đẻ thường ngôi đầu

57 Chăm sóc thai phụ dọa sẩy thai

58 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ sa sinh dục

59 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sẩy thai

60 Quy trình chăm sóc bệnh nhân thai ngoài tử cung

61 Quy trình chăm sóc thai phụ nôn nặng do thai nghén

62 Quy trình chăm sóc người bệnh mổ u nang buồng trứng

63 Quy trình chăm sóc người bệnh u xơ tử cung

64 Quy trình chăm sóc nhau tiền đạo

65 Quy trình chăm sóc vỡ tử cung

66 Quy trình chăm sóc thai phụ nhau bong non

Chăm sóc hồi sức và cấp cứu

67 Quy trình chăm sóc bệnh đau thắt ngực

68 Quy trình chăm sóc bệnh nhịp nhanh trên thất

69 Quy trình chăm sóc bệnh nhồi máu cơ tim cấp

70 Quy trình chăm sóc bệnh nhồi máu não

71 Quy trình chăm sóc bệnh phù phổi cấp

72 Quy trình chăm sóc sốc nhiễm khuẩn

73 Quy trình chăm sóc bệnh sốc phản vệ

74 Quy trình chăm sóc suy thận mạn

75 Quy trình chăm sóc viêm phổi

76 Quy trình chăm sóc bệnh viêm tụy cấp

77 Quy trình chăm sóc xuất huyết não

Danh mục dùng số thứ tự thay cho các số trang cũ của bản nền. Có thể mở ngăn Dẫn hướng của Word để tìm theo tiêu đề; số trang xác định sau khi kiểm tra bản in.

Chăm sóc các bệnh mắt

01 Quy trình chăm sóc viêm loét giác mạc

Mã đề xuất QTCS-01. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bện bao lâu? Nhìn thấy có mờ hơn trước không?

Có bị đau nhức, chói mắt, sọ ánh sáng gì không?

Có bị chảy nước mắt, có ghèn gì không?

Gia đình có tiền sử bệnh về mắt không? Bản thân có tiền sử dị ứng gì không? Đã từng khám hay điều trị bệnh ở mắt chưa?

Quan sát mi mắt có co quắp, kết mạc có cương tụ rìa không?

Phối hợp khám giác mạc và test fluorescein khi có chỉ định, đúng năng lực được phân công; ghi kết quả thực tế, không mặc định Fluo dương tính.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh khó chịu do triệu chứng của bệnh.

Nguy cơ biến chứng của bệnh nếu không tuân thủ điều trị.

Bệnh nhân lo lắng ảnh hưởng của bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm khó chịu cho người bệnh.

Hạn chế nguy cơ biến chứng xảy ra.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện y lệnh thuốc nhỏ mắt, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.

Dặn người bệnh tránh xa các yếu tố dị ứng, vệ sinh mắt sạch sẽ nếu có sử dụng kính áp tròng, lạm đẹp ở vùng mi mắt,…

Dặn bệnh tái khám theo lịch hẹn, theo dõi tình trạng mắt.

2. CHẾ NGUY CƠ BIẾN CHỨNG XẢY RA

Thực hiện thuốc theo y lệnh bác sĩ mắt phù hợp nguyên nhân; kiểm tra dị ứng, thuốc, mắt cần điều trị và đáp ứng. Không tự chọn kháng sinh, kháng nấm hoặc corticosteroid.

Tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc khi chưa có chỉ định.

3. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Tìm hiểu nhũng lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Giải thích cho người bệnh rõ về bệnh, bệnh viêm loét giác mạc nguy hiểm gây sẹo giác mạc giảm thị lực, nhiễm trùng sâu, thủng giác mạc, di lệch mống mắt,… khi phát hiện bệnh cần điều trị sớm và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Hướng dẫn người bệnh vệ sinh mắt, tránh các yếu tố dị ứng, vệ sinh khu vực sống, vệ sinh kính áp tròng (nếu có sử dụng),…

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên mắt cần đi đến cơ sở y tế khám ngay. Khi điều trị cần tuân thủ điều trị của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc hay mua thuốc.

Mang khẩu trang, khính râm khi đi ra ngoài hoặc khi thời tiết hanh khô, nhiều gió.

Vệ sinh mắt, mũi họng, không lấy tay dụi vào mắt trực tiếp.

Ngừng đeo kính áp tròng khi viêm loét giác mạc; chỉ sử dụng lại khi bác sĩ mắt cho phép. Hướng dẫn vệ sinh kính và hộp đúng hướng dẫn sản phẩm.

Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, sợ ánh sáng, giảm thị lực, đục giác mạc hoặc nghi thủng: báo bác sĩ mắt khẩn, bảo vệ mắt và chuẩn bị xử trí chuyên khoa.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân giảm khó chịu ở mắt.

Hạn chế biến chứng xảy ra.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

02 Quy trình chăm sóc bệnh khô mắt

Mã đề xuất QTCS-02. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh bao lâu?

Mắt có cảm giác khô, rát không?

Có nhìn mờ không?

Có đau nhức mắt, mỏi mắt, sợ ánh sáng không?

Hỏi tuổi, công việc, lối sống của người bệnh, có phải sử dụng máy tính, điện thoại thường xuyên không?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ giảm thị lực.

Nguy cơ viêm giác mạc.

Lo lắng về bệnh do ảnh hưởng đến cuộc sống.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Hạn chế giảm thị lực.

Giảm xảy ra nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. HẠN CHẾ GIẢM THỊ LỰC CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ.

Chớp mắt chậm và đều, kiểm tra mắt định kỳ để theo dõi các bệnh lý của mắt kèm theo.

2. GIẢM XẢY RA NGUY CƠ BIẾN CHỨNG CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện các y lệnh của bác sĩ.

Tuân thủ y lệnh điều trị thuốc nhỏ theo toa của bác sĩ.

3. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Bệnh khô mắt có thể điều trị được nếu người bệnh tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ, kiểm tra mắt định kỳ, làm việc văn phòng cần cho mắt nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc trực tiếp với gió bụi và ánh sáng mặt trời.

Giải thích để người bệnh hiểu và có thông tin chính xác để bệnh giảm lo lắng và tuân thủ điều trị.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng theo toa thuốc của bác sĩ.

Hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc để mắt được nghỉ ngơi và phục hồi.

Ăn nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A cho mắt.

Công việc sử dụng máy tính, điện thoại thường xuyên phải cho mắt được nghỉ ngơi, tránh làm việc liên tục gây mỏi mắt.

Đeo kính râm khi ra đường, tránh gió bụi tiếp xúc trực tiếp với mắt và không được dùng tay dụi vào mắt.

Khám định kỳ và sử dụng nước mắt nhân tạo khi có chỉ định của bác sĩ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau, đỏ nhiều hoặc giảm thị lực không giải thích bằng khô mắt: báo bác sĩ để loại trừ tổn thương giác mạc.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hạn chế giảm thị lực cho người bệnh.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Tăng chất lượng cuộc sống.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

03 Quy trình chăm sóc bệnh chắp

Mã đề xuất QTCS-03. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh bao lâu?

Mắt có cảm đau, đỏ không?

Có sưng mi mắt không?

Có gây khó chịu khi nhìn không?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử, vị trí nổi của chắp.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ viêm nhiễm mi mắt.

Lo lắng về bệnh do ảnh hưởng đến cuộc sống.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm nguy cơ viêm nhiễm mi mắt cho người bệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM NGUY CƠ VIÊM NHIỄM MI MẮT CHO NGƯỜI BỆNH

Chườm ấm và vệ sinh bờ mi theo hướng dẫn; bác sĩ đánh giá nhu cầu thuốc, rạch chắp hoặc khảo sát tổn thương tái phát. Điều dưỡng chuẩn bị và hỗ trợ thủ thuật theo phân công.

Không tự ý đắp thuốc, nặn chấp tại nhà, không dùng tay để cố nặn chắp.

Dùng thuốc và nhỏ mắt theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

2. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Giải thích diễn biến và kế hoạch điều trị; báo bác sĩ khi tổn thương tái phát cùng vị trí, kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, không cam kết khỏi hoàn toàn.

Vệ sinh bờ mi, tẩy trang nhẹ nhàng và tránh để mỹ phẩm tiếp xúc trực tiếp với mắt.

Giải thích để người bệnh hiểu và có thông tin chính xác để bệnh giảm lo lắng và tuân thủ điều trị.

3. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng theo toa thuốc của bác sĩ.

Không tự ý nặn chắp tại nhà.

Ăn nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A cho mắt.

Không nên đưa tay dụi, chà mắt vì có thể gây kích ứng mắt và nhiễm khuẩn lây lan.

Đeo kính râm khi ra đường, tránh gió bụi tiếp xúc trực tiếp với mắt.

Ngừng mỹ phẩm vùng mắt khi đang viêm; sử dụng và thay mỹ phẩm theo hướng dẫn sản phẩm, không dùng chung.

Dụng cụ cá nhân sử dụng riêng để giữ vệ sinh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sưng đỏ lan, sốt, đau khi vận nhãn, giảm thị lực hoặc tái phát cùng vị trí: báo bác sĩ; không nặn chắp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

04 Quy trình chăm sóc xuất huyết dưới kết mạc

Mã đề xuất QTCS-04. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh bao lâu?

Mắt có cộm gì không? Thấy mảng hoặc chấm xuất huyết bao lâu?

Có bị chảy nước mắt, có ghèn gì không?

Gia đình có tiền sử bệnh về mắt không? Bản thân có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường gì không? Gần đây có bị ho, táo bón hoặc bị chấn thương ở mắt không? Đã từng khám hay điều trị bệnh ở mắt chưa?

Có đang điều trị thuốc gì không?

Quan sát kết mạc mi mắt 2 bên, để nhận định tình trạng xuất huyết nhiều hay ít, từng mảng hay chấm đỏ li ti.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Người bệnh khó chịu do triệu chứng của bệnh.

Người bệnh lo lắng về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm khó chịu cho người bệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện y lệnh thuốc nhỏ mắt, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.

Dặn người bệnh tuân thủ điều trị các bệnh kèm theo, khi có ho hoặc táo bón cần điều trị, vệ sinh mắt sạch sẽ nếu có sử dụng kính áp tròng, làm đẹp ở vùng mi mắt, …

Dặn bệnh tái khám theo lịch hẹn, theo dõi tình trạng mắt.

2. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Xuất huyết dưới kết mạc thường diễn biến lành tính nhưng cần bác sĩ đánh giá nguyên nhân. Đau mắt, giảm thị lực, chấn thương, tái phát hoặc chảy máu nơi khác cần báo ngay.

Hướng dẫn người bệnh vệ sinh mắt, tránh các yếu tố làm tăng nguy cơ xuất huyết, vệ sinh khu vực sống, vệ sinh kính áp tròng (nếu có sử dụng),…

3. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Theo dõi diễn biến và tái khám theo hẹn; không tự dừng thuốc chống đông hay thuốc đang điều trị bệnh nền.

Mang khẩu trang, kính râm khi đi ra ngoài hoặc khi thời tiết hanh khô, nhiều gió.

Vệ sinh mắt, mũi họng, không lấy tay dụi vào mắt trực tiếp.

Đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt khi có tình trạng mắt đỏ, màng xuất huyết nhiều hơn hoặc dị vật vào mắt, chấn thương mắt.

Tạm ngừng kính áp tròng khi mắt đỏ hoặc kích ứng; sử dụng lại theo hướng dẫn bác sĩ mắt.

Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau hoặc giảm thị lực, chấn thương, xuất huyết tái phát hoặc chảy máu nơi khác: báo bác sĩ đánh giá nguyên nhân.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hạn chế biến chứng xảy ra.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

05 Quy trình chăm sóc hẹp và bít điểm lệ

Mã đề xuất QTCS-05. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Hỏi bệnh có chảy nước mắt sống, có ghèn không?

Có đau, sưng ở góc mắt không?

Mắt viêm nhiễm bao lâu rồi?

Quan sát ghèn, đỏ, sưng đau vùng túi lệ; báo bác sĩ nếu nghi nhiễm trùng. Không ấn ép túi lệ thường quy khi đang sưng đau.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Mắt dơ nhem do chảy nước mắt, đổ ghèn.

Nguy cơ nhiễm trùng mắt và vùng quanh mắt.

Người bệnh thiếu kiến thức về chăm sóc tại nhà.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm triệu chứng và ngăn ngừa nhiễm trùng mắt.

Hướng dẫn bệnh nhân và gia đình tự chăm sóc mắt tại nhà hiệu quả.

Cung cấp kiến thức về bệnh cho bệnh nhân và người nhà.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM TRIỆU CHỨNG VÀ NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG MẮT

Thực hiện y lệnh thuốc nhỏ mắt, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.

Lau sạch ghèn bằng bông gòn thấm nước ấm sạch, lau từ trong ra ngoài, lau riêng từng mắt.

Dặn người bệnh không dụi tay dơ lên mắt, mang kính râm khi đi đường.

Dặn bệnh tái khám theo lịch hẹn, theo dõi tình trạng mắt.

2. HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TỰ CHĂM SÓC MẮT TẠI NHÀ

Chỉ hướng dẫn massage lệ đạo khi bác sĩ xác định đúng chỉ định, đặc biệt tắc lệ đạo bẩm sinh ở trẻ; nhân viên được đào tạo hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra người chăm sóc thực hành. Không áp dụng mặc định cho hẹp điểm lệ ở người lớn.

Lau mắt bằng khan sạch, nước ấm, không dụi tay trực tiếp vào mắt.

Nhỏ thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

3. CUNG CẤP KIẾN THỨC VỀ BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH

Giải thích tình trạng hẹp hoặc bít điểm lệ và kế hoạch điều trị; tiên lượng phụ thuộc nguyên nhân, không cam kết khỏi khi chưa đánh giá chuyên khoa.

Giải thích lợi ích của việc massage điểm lệ.

Dặn người nhà khi phát hiện các dấu hiệu: Sưng đỏ, sốt, mắt chảy nhiều mủ thì đến ngay bệnh viện chuyên khoa Mắt điều trị.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Không tự ý đắp lá hay thuốc gì lên mắt khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng thể trạng mau khỏi bệnh. Không kiêng cử.

Không dụi mắt; vệ sinh mi nhẹ nhàng và sử dụng dung dịch dành cho mắt theo hướng dẫn bác sĩ, không rửa mắt thường quy bằng nước không bảo đảm vệ sinh.

Điều trị sớm giúp tránh biến chứng nặng như áp xe túi lệ, nhiễm khuẩn lan rộng, rò lệ đạo.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sưng đỏ đau vùng túi lệ, sốt hoặc đỏ lan: báo bác sĩ, không ấn ép vùng đang viêm.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Mắt ít chảy nước mát, ghèn, mắt sạch hơn.

Bệnh nhân và gia đình biết cách tự chăm sóc mắt tại nhà.

Người nhà hiểu rõ về bệnh và biết cách phòng ngừa.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy

trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

06 Quy trình chăm sóc liệt dây thần kinh iii

Mã đề xuất QTCS-06. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Mức độ liệt: Sụp mí, mắt lác (lệch ra ngoài, nhìn lên), nhìn đôi (song thị), đồng tử giãn.

Có các triệu chứng đi kèm: Đau đầu, chóng mặt không?

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, chấn thương sọ não, khối u gì không?

Bệnh nhân có giảm thị lực không?

Có điều trị bệnh về mắt ở đau chưa?

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân rối loạn thị giác, nhìn đôi do sụp mi.

Nguy cơ tổn thương mắt do khô mắt.

Người bệnh thiếu kiến thức về chăm sóc tại nhà.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Cải thiện thị lực, nâng cao thẩm mỹ cho người bệnh.

Bảo vệ mắt khỏi tổn thương, tăng cường dinh dưỡng.

Hướng dẫn bệnh nhân và gia đình tự chăm sóc tại nhà hiệu quả.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CẢI THIỆN THỊ LỰC, NÂNG CAO THẨM MỸ CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện y lệnh thuốc nhỏ mắt, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.

Che mắt hoặc xử trí song thị theo hướng dẫn bác sĩ mắt, phù hợp tuổi và nguy cơ nhược thị; không bịt mắt luân phiên mặc định.

Dùng lăng kính trụ giúp bảo tồn hợp thị tránh song thị ở vị trí nguyên phát.

2. BẢO VỆ MẮT KHỎI TỔN THƯƠNG DO KHÔ MẮT

Đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi bụi, gió, ánh sáng mạnh.

Nhỏ nước mắt nhân tạo theo y lệnh của bác sĩ.

Chớp mắt thường xuyên và chậm rãi hơn bình thường để nước mắt phủ đều, đặc biệt khi dùng máy tính.

3. CUNG CẤP KIẾN THỨC VỀ BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH

Giải thích cho người bệnh về tình tạng bệnh, bệnh liệt dây thần kinh III cũng nguy hiểm cần điều trị sớm và theo chỉ định của bác sĩ.

Hướng dẫn bệnh nhân và người nhà các bài tập vận nhãn trong không gian để tăng cường phục hồi chức năng cửa cơ liệt, hỗ trợ cơ liệt phục hồi.

Theo dõi sụp mi, song thị, đồng tử và diễn biến thị lực; áp dụng biện pháp hỗ trợ được bác sĩ mắt hướng dẫn.

Làm sạch mí mắt và lông mi bằng gạc mềm để loại bỏ cặn bẩn, giảm viêm.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mang kính râm khi đi đường, tránh tiếp xúc trực tiếp khói, bụi, gió và ánh sáng mắt trời.

Ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin B, Omega-3 (cá béo, các loại hạt).

Không dụi mắt; vệ sinh mi nhẹ nhàng. Chỉ dùng dung dịch dành cho mắt theo hướng dẫn, không rửa mắt thường quy bằng nước không bảo đảm vệ sinh.

Kiểm soát tốt các bệnh nền: Tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu.

Khám kiểm tra mắt định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Liệt dây III khởi phát mới, đau đầu hoặc đau mắt, đồng tử giãn hay tri giác thay đổi: báo bác sĩ khẩn để đánh giá nguyên nhân thần kinh.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân nhìn rõ hơn.

Bệnh nhân và gia đình biết cách tự chăm sóc mắt tại nhà.

Người nhà hiểu rõ về bệnh và biết cách phòng ngừa.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

07 Quy trình chăm sóc bệnh viêm giác mạc sợi

Mã đề xuất QTCS-07. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh bao lâu?

Có thấy khô mắt nhiều không?

Có sợ ánh sáng, mắt có đỏ, có cộm không?

Đã điều trị ở đâu chưa?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử, mí mắt.

Thực hiện các cận lâm sàng: Các xét nghiệm liên quan, soi đáy mắt, thực hiện test fluorescein.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân cộm, xốn mắt do bong tróc giác mạc.

Bệnh nhân khô mắt.

Bệnh nhân lo lắng về bệnh do thiếu kiến thức.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm cộm, xốn cho người bệnh.

Giảm khô mắt cho người bệnh.

Làm cho người bệnh giảm lo lắng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM CỘM, XỐN CHO NGƯỜI BỆNH

Bóc sợi giác mạc do bác sĩ mắt hoặc người được phân quyền chuyên môn phù hợp thực hiện; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi sau thủ thuật.

Hướng dẫn người bệnh nhỏ thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ nhãn khoa, không tự ý nhỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

2. GIẢM KHÔ MẮT CHO NGƯỜI BỆNH

Đeo kính râm bảo vệ mắt khỏi bụi, gió, ánh sáng mạnh.

Điều trị các yếu tố nguy cơ trực tiếp làm khô mắt.

Nhỏ nước mắt nhân tạo theo y lệnh của bác sĩ.

Chớp mắt thường xuyên và chậm rãi hơn bình thường để nước mắt phủ đều, đặc biệt khi dùng máy tính.

3. CUNG CẤP KIẾN THỨC VỀ BỆNH ĐỂ NGƯỜI BỆNH GIẢM LO LẮNG

Viêm giác mạc sợi là một bệnh vô cùng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có nguy cơ tái phát nhiều lần thậm chí có thể đưa đến nguy cơ mù lòa. Do đó người bệnh cần tuân thủ điều trị và chú ý bệnh để phát hiện bệnh kịp thời.

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Giải thích cho người bệnh rõ về bệnh tật để người bệnh tuân thủ điều trị và kiểm tra mắt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hướng dẫn bệnh sử dụng thuốc và cách chăm sóc mắt tạ nhà.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mang kính râm khi đi đường, tránh tiếp xúc trực tiếp khói, bụi, gió và ánh sáng mắt trời.

Có chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bổ sung them thực phẩm giàu vitamin A: cà rốt, gan bò, bông cải xanh,…

Không dụi mắt; vệ sinh mi nhẹ nhàng và dùng thuốc, dung dịch dành cho mắt đúng hướng dẫn bác sĩ.

Hạn chế sử dụng kính áp tròng. Không sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại,… trong thời gian dài liên tục.

Khám kiểm tra mắt định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, đỏ nhiều hoặc giảm thị lực: báo bác sĩ mắt; không tự bóc sợi giác mạc.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh giảm cộm, xốn và hạn chế bị khô mắt.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

08 Quy trình chăm sóc bệnh võng mạc đái tháo đường

Mã đề xuất QTCS-08. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh đái tháo đường bao lâu?

Mức độ đường huyết gần đây (bao gồm HbA1c, mỡ máu, chức năng thận).

Nhìn mờ nhanh hay mờ dần dần?

Đã điều trị ở đâu chưa?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử, soi góc tiền phòng.

Thực hiện các cận lâm sàng: Các xét nghiệm công thức máu, đường huyết, mỡ máu, soi đáy mắt, chụp OCT võng mạc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nhìn mờ dần do tổn thương võng mạc.

Nguy cơ tăng nhãn áp.

Bệnh nhân lo lắng do sợ bị mù.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm cho người bệnh nhìn rõ hơn.

Phòng ngừa nguy cơ tăng nhãn áp.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. LÀM CHO NGƯỜI BỆNH NHÌN RÕ HƠN

Khuyên người bệnh chấp nhận các phương pháp điều trị của thầy thuốc.

Tư vấn người bệnh kiểm tra mắt định kỳ theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Hướng dẫn người bệnh kiểm soát đường huyết tốt, tuân thủ điều trị của bác sĩ giúp ổn định đường huyết.

2. PHÒNG NGỪA NGUY CƠ TĂNG NHÃN ÁP

Kiểm tra nhãn áp sau mỗi lần khám mắt hoặc khi có triệu chứng nhức mắt, nhìn mờ đột ngột.

Tuân thủ y lệnh điều trị thuốc nhỏ theo toa bác sĩ.

3. GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Giải thích cho người bệnh rõ về bệnh tật để người bệnh tuân thủ điều trị và kiểm tra mắt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hướng dẫn cho người bệnh khi gặp các triệu chứng: đau đầu dữ dội, nôn ói, nhìn mờ đột ngột đến ngay bệnh viện.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc theo toa bác sĩ.

Bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A: cà rốt, gan bò, bông cải xanh,…

Tư vấn cho người bệnh phương pháp điều trị khi bệnh võng mạc tân sinh ảnh hưởng đến thị lực người bệnh: Laser quang đông, tiêm thuốc vào nhãn cầu và điều trị phẫu thuật.

Bệnh có tiền sử đái tháo đường cần kiểm tra mắt định kỳ theo chỉ định của bác sĩ và kiểm tra mắt khi nhìn mờ đột ngột.

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Mất hoặc giảm thị lực đột ngột, ruồi bay tăng, chớp sáng hoặc màn che: báo bác sĩ mắt khẩn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Ghi thị lực thực tế và so sánh với trước can thiệp; đánh giá ổn định hoặc thay đổi, không mặc định thị lực phải hồi phục.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định

3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

09 Quy trình chăm sóc bệnh xuất huyết kết mạc

Mã đề xuất QTCS-09. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Hỏi thời điểm khởi phát xuất huyết, chấn thương, tái phát, bệnh nền và các thuốc đang sử dụng.

Có bị cộm gì không? Thấy mảng hoặc chấm xuất huyết bao lâu?

Có bị chảy nước mắt, có ghèn gì không?

Đã điều trị ở đâu chưa?

Gia đình có tiền sử bệnh về mắt không? Bản thân có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường gì không? Gần đây có bị ho, táo bón hoặc bị chấn thương ở mắt không?

Khám: Quan sát kết mạc mi mắt 2 bên, để nhận định tình trạng xuất huyết nhiều hay ít, từng mảng hay chấm đỏ li ti.

Thực hiện các cận lâm sàng: Các xét nghiệm công thức máu, đường huyết, mỡ máu, soi đáy mắt, chụp OCT võng mạc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh khó chịu do chịu chứng của bệnh.

Bệnh nhân lo lắng về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm khó chịu cho người bệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện y lệnh thuốc nhỏ mắt, thuốc uống theo chỉ định của bác sĩ.

Dặn người bệnh tuân thủ điều trị các bệnh kèm theo, khi có ho hoặc táo bón cần điều trị.

Vệ sinh mắt sạch sẽ nếu có sử dụng kính áp tròng, làm đẹp ở vùng mi mắt.

Dặn bệnh nhân tái khám theo lịch hẹn, theo dõi tình trạng mắt.

Mang kính râm khi đi đường, tránh tiếp xúc trực tiếp khói, bụi, gió, ánh sáng mặt trời….

2. GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Giải thích diễn biến thường lành tính sau khi bác sĩ đánh giá; đau, giảm thị lực, chấn thương hoặc chảy máu nơi khác cần được khám khẩn.

Hướng dẫn cho người bệnh vệ sinh mắt, tránh va đập mạnh làm tăng nguy cơ xuất huyết.

3. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Theo dõi tiến triển và tái khám theo hẹn; không tự ngừng thuốc chống đông hoặc thuốc bệnh nền.

Mang khẩu trang, khính râm khi đi ra ngoài hoặc khi thời tiết hanh khô, nhiều gió.

Bổ sung them thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A: cà rốt, gan bò, bông cải xanh, cam, chanh, đu đủ,….

Vệ sinh mắt, mũi họng, không lấy tay dụi trực tiếp vào mắt.

Đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Mắt khi có tình trạng mắt đỏ, màng xuất huyết nhiều hơn hoặc dị vật vào mắt, chấn thương mắt.

Ngừng kính áp tròng khi mắt đỏ hoặc kích ứng; dùng lại theo hướng dẫn bác sĩ mắt.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Áp dụng tiêu chí an toàn như xuất huyết dưới kết mạc ở quy trình 4; chỉ lựa chọn một kế hoạch chăm sóc cho cùng vấn đề để tránh ghi trùng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân giảm khó chịu.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Hạn chế biến chứng xảy ra.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định

3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

10 Quy trình chăm sóc bệnh tắc nhánh tĩnh mạch võng mạc

Mã đề xuất QTCS-10. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bệnh bao lâu?

Nhìn mờ đã lâu hay mờ đột ngột?

Có bị Glaucom, tăng huyết áp, mỡ máu hay bệnh nào khác không?

Đã điều trị ở đâu chưa?

Hỏi tuổi, hỏi tiền sử sử dụng thuốc lá, rượu bia, lối sống của người bệnh?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử.

Thực hiện các cận lâm sàng: Các xét nghiệm liên quan, chụp OCT võng mạc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ mất thị lực.

Nguy cơ phù hoàng điểm, xuất huyết dịch kính.

Lo lắng về bệnh tại mắt và các bệnh toàn thân kèm theo.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Hạn chế giảm thị lực.

Giảm xảy ra nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh và tư vấn các bệnh kèm theo.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. HẠN CHẾ GIẢM THỊ LỰC

Chuẩn bị và hỗ trợ bác sĩ mắt thực hiện tiêm nội nhãn khi được chỉ định; kiểm tra người bệnh, mắt can thiệp, thuốc và vô khuẩn, theo dõi đau, giảm thị lực sau thủ thuật.

Tư vấn người bệnh kiểm tra mắt định kỳ theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Hướng dẫn người bệnh nhỏ thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ nhãn khoa, không tự ý nhỏ thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

2. GIẢM XẢY RA NGUY CƠ BIẾN CHỨNG CHO NGƯỜI BỆNH

Thực hiện y lệnh của bác sĩ.

Tuân thủ y lệnh điều trị thuốc nhỏ theo toa bác sĩ.

3. GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Giải thích tiên lượng thị lực phụ thuộc tổn thương và đáp ứng điều trị; không dùng tỷ lệ hồi phục chưa được kiểm chứng để cam kết kết quả.

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc.

Hỏi thêm tiền sử bệnh trước đây để tư vấn bệnh kiểm tra bệnh toàn thân.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc theo toa của bác sĩ.

Dặn bệnh nhân cần tuân thủ điều trị nghiêm ngặt do bệnh có thể dẫn đến nguy cơ mù lòa rất cao.

Bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C, vitamin A: cà rốt, gan bò, bông cải xanh, cam, chanh, đu đủ,….

Kiểm soát huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu định kỳ. Nếu đối tượng là phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản có sử dụng thuốc tránh thai cần báo với bác sĩ, đôi khi đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tắc tĩnh mạch võng mạc.

Hẹn khám mắt theo lịch bác sĩ xác định dựa trên bệnh mắt, bệnh toàn thân và nguy cơ từng người bệnh.

Ngưng sử dụng thuốc lá, rượu bia có thể giảm nguy cơ bệnh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Giảm thị lực mới, đau hoặc đỏ nhiều, nhất là sau tiêm nội nhãn: báo bác sĩ mắt khẩn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hạn chế giảm thị lực cho người bệnh.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

11 Quy trình chăm sóc bệnh viêm kết mạc

Mã đề xuất QTCS-11. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Hỏi chi tiết và ghi lại đày đủ tính chất, dặc điểm của bệnh:

Bị đau từ bao giờ?

Đau nhức như thế nào?

Có nhiều dử mắt (tiết tố) không, tính chất của tiết tố mắt?

Có nhìn mờ không?

Đã được xử trí gì chưa?

Khám: Quan sát mi, kết mạc nhãn cầu, kết mạc mi và giác mạc.

Thực hiện xét nghiệm: Lấy dịch tiết tố để soi tươi và nuôi cấy, làm kháng sinh đồ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau rát, cộm xốn trong mắt do kết mạc phù nề liên quan đến nhiễm khuẩn.

Ngứa mắt dữ dội do dị ứng liên quan đến thời tiết.

Lo lắng do sợ bị mù.

Nguy cơ lây nhiễm do thiếu hiểu biết kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm đau rát, cộm trong mắt.

Làm giảm ngứa mắt.

Giảm lo lắng cho người bệnh.

Giáo dục cho người bệnh cách đề phòng lây bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. LÀM GIẢM ĐAU RÁT, CỘM TRONG MẮT

Làm sạch dịch tiết ở mi bằng vật tư phù hợp, mỗi mắt dùng riêng; rửa mắt hoặc nhỏ thuốc theo chỉ định, không áp dụng lịch rửa mỗi 30 phút thường quy.

Chườm ấm mắt cho người bệnh.

Tra dung dịch kháng sinh như: ciprofloxacin 0,3%, Tobrex,…ngày 4-6 lần.

Tra mỡ kháng sinh buổi tối: Tetracyclin 1% hoặc Oflovid.

Thực hiện y lệnh thuốc uống theo toa bác sĩ.

2. LÀM GIẢM NGỨA MẮT

Tra dung dịch/mỡ Cloroxit H 1% ngày 1-2 lần.

Phụ giúp bác sĩ tiêm hydrocortisone hậu nhãn cầu cho bệnh nhân bị viêm kết mạc mùa xuân.

Thực hiện y lệnh thuốc: Kháng histamin, vitamin C,…

3. GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Động viên an ủi người bệnh.

Nói rõ cho người bệnh biết bệnh không làm giảm khả năng nhìn (Nếu chưa có biến chứng).

Đo thị lực cho người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh, người nhà biết cách theo dõi bệnh, cần thiết phải khám và điều trị chuyên khoa sớm, không được tự chữa bệnh để phòng biến chứng.

4. GIÁO DỤC CHO NGƯỜI BỆNH CÁCH ĐỀ PHÒNG LÂY BỆNH

Giải thích cho người bệnh hiểu đây là bệnh dễ lây thành dịch.

Hướng dẫn cho người bệnh dùng đồ riêng: chậu, khăn,…

Hướng dẫn người bệnh không được băng mắt.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau mắt, giảm thị lực, sợ ánh sáng, sưng lan hoặc người đeo kính áp tròng: báo bác sĩ để đánh giá tổn thương giác mạc.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh đỡ đau rát, cộm mắt.

Tiết tố giảm dần.

Hết lo lắng, người bệnh yên tâm thực hiện thuốc đúng y lệnh.

Không nhìn mờ: Kết quả đo thị lực bình thường.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

12 Quy trình chăm sóc bệnh glaucoma góc đóng cơn cấp

Mã đề xuất QTCS-12. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Người điều dưỡng hỏi chị tiết và ghi lại đầy đủ tính chất của bệnh glaucoma:

Người bệnh đã mắc bệnh glaucoma bao lâu?

Người bệnh cảm thấy hơi khó chịu hay rất khó chịu?

Đau nhức mắt như thế nào, có đau đầu không?

Nhìn mờ nhanh hay dần dần, nhìn vào nguồn sáng có quầng xanh, đỏ không?

Nôn hay buồn nôn?

Đã được xử trí gì chưa?

Trong gia đình có ai bị glaucoma không?

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau nhức mắt, đau đầu do tăng nhãn áp.

Nhìn mờ nhanh do giác mạc phù.

Lo lắng, sợ hãi bị mù.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm đau nhức mắt, đau đầu và giúp cho người bệnh nhìn rõ hơn.

Làm giảm lo lắng, sợ hãi cho người bệnh.

Hướng dẫn cho người bệnh những kiến thức của bệnh để phòng chống nguy cơ gây mù lòa.

Chăm sóc và theo dõi người bệnh trước, sau phẫu thuật.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. LÀM GIẢM ĐAU NHỨC MẮT, ĐAU ĐẦU VÀ GIÚP NGƯỜI BỆNH NHÌN RÕ HƠN

Đo thị lực, nhãn áp.

Tra dung dịch pilocarpine 1%.

Thực hiện y lệnh (trước mổ): uống thuốc hạ nhãn áp: acetazolamide; uống thuốc giảm đau paracetamol,…

Trợ giúp thấy thuốc phẫu thuật tạo lỗ rò cho thủy dịch lưu thông.

Thực hiện y lệnh thuốc sau mổ: kháng sinh, an thần, vitamin,…

2. GIẢM LO LẮNG, SỢ HÃI CHO NGƯỜI BỆNH

Duy trì bầu không khí yên tĩnh, trật tự tránh căng thẳng quá mức, giận dữ.

Động viên, an ủi người bệnh và làm cho người bệnh tin tưởng vào các phương pháp điều trị.

Uống thuốc an thần (theo y lệnh).

3. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI BỆNH NHỮNG KIẾN THỨC CỦA BỆNH ĐỂ PHÒNG CHỐNG NGUY CƠ GÂY MÙ LÒA

Giới thiệu cho người bệnh và người nhà triệu chứng của bệnh và những nguy hiểm của bệnh nếu như đến cơ sở y tế muộn để người bệnh đến khám sớm.

Trong gia đình có người đã bị glaucoma thì người khác khi thấy mắt nhức phải đi kiểm tra ngay.

Phải kiểm tra định kỳ theo chỉ định của thầy thuốc nhãn khoa với những người bệnh đã mổ một mắt hoặc hai mắt.

Khám và đo nhãn áp hang loạt cho những người trên 35 tuổi ở các xí nghiệp, cơ quan để phát hiện sớm bệnh glaucoma.

4. CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH TRƯỚC, SAU MỔ

Trước mổ:

Chăm sóc cấp 3, ăn bình thường.

Cho người bệnh uống thuốc tiền mê: seduxen theo y lệnh (tối trước mổ).

Cắt lông mi, bơm rửa lệ đạo trước mổ 30 phút.

Tiêm tê cạnh nhãn cầu trước mổ 15 phút (theo y lệnh).

Theo dõi nhãn áp ngày 2 lần báo cáo thầy thuốc.

Sau mổ:

Ngày đầu: Chăm sóc cấp I, ăn lỏng, tránh nhai, tránh táo bón,…

Những ngày sau: Theo dõi tiền phòng nông hay sâu, có máu, mủ hoặc chất tiết không. Vết mổ có kín không. Nếu bệnh nhân nôn cho người bệnh nằm nghiêng một bên, nếu nôn nhiều cần báo cáo thầy thuốc. Theo dõi viêm màng bồ đào. Phụ giúp thầy thuốc thay bang hang ngày. Theo dõi xem người bệnh còn các triệu chứng cơ năng không.

Khi ra viện: Thử thị lực, đo nhãn áp cho người bệnh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Glaucoma góc đóng cơn cấp là tình trạng cần khám mắt khẩn; không để tư vấn hoặc xét nghiệm không cấp thiết trì hoãn điều trị.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh đã giảm đau và giảm khó chịu.

Yên tâm, tin tưởng và thực hiện y lệnh điều trị.

Nhìn rõ hơn sau khi điều trị phẫu thuật.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

13 Quy trình chăm sóc bệnh đục thủy tinh thể

Mã đề xuất QTCS-13. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Thời gian bị bao lâu?

Nhìn mờ nhanh hay mờ dần?

Có đau nhức không?

Đã điều trị chưa?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, giác mạc, đồng tử.

Thực hiện các xét nghiệm: Công thức máu, máu chảy, máu đông, HIV, siêu âm võng mạc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nhìn mờ dần do thủy tinh thể đục.

Lo lắng sợ bị mù.

Nguy cơ chấn thương (trước phẫu thuật).

Biến chứng sau phẫu thuật do người bệnh vận động.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm cho người bệnh nhìn rõ hơn.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

Phòng ngừa chấn thương.

Chăm sóc và theo dõi người bệnh trước, sau phẫu thuật.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. LÀM GIẢM CHO BỆNH NHÂN NHÌN RÕ HƠN

Khuyên người bệnh chấp nhận các phương pháp điều trị của người thầy thuốc.

Trợ giúp bác sĩ phẫu thuật lấy thủy tinh thể đục.

2. LÀM GIẢM LO LẮNG, SỢ HÃI CHO NGƯỜI BỆNH

Tìm hiểu những lo lắng của người bệnh. Khuyến khích họ thổ lộ để làm giảm lo sợ.

Giải thích cho người bệnh rõ về bệnh tật để người bệnh đồng ý phẫu thuật.

Hướng dẫn cho người bệnh thuốc sử dụng trước phẫu thuật, chế độ ăn chuẩn bị thể lực.

3. PHÒNG NGỪA CHẤN THƯƠNG (TRƯỚC PHẪU THUẬT)

Giải thích cho người bệnh những thay đổi xảy ra khi đục nhân mắt tiến triển làm giảm thị lực. Người bệnh cần phải đi khám định kỳ và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Dặn dò người bệnh cẩn thận khi đi lại một mình (dễ bị vấp ngã). Nếu mắt mờ nhiều cần trợ giúp của người điều dưỡng hoặc người nhà.

4. TRÁNH ĐƯỢC CÁC BIẾN CHỨNG (SAU PHẪU THUẬT)

Phòng nhiễm trùng hậu phẫu bằng cách sử dụng các dụng cụ vô khuẩn khi thay băng (bông, gạc) và kháng sinh tại chỗ.

Thực hiện y lệnh: kháng sinh, corticoid, giảm đau, an thần.

5. CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH TRƯỚC, SAU MỔ

Trước mổ:

Chăm sóc cấp 3, ăn bình thường.

Cho người bệnh uống thuốc tiền mê: seduxen theo y lệnh (tối trước mổ).

Cắt lông mi, bơm rửa lệ đạo trước mổ 30 phút.

Tiêm tê cạnh nhãn cầu trước mổ 15 phút (theo y lệnh).

Theo dõi nhãn áp ngày 2 lần báo cáo thầy thuốc.

Sau mổ:

Ngày đầu: Chăm sóc cấp I, ăn lỏng trong 1 đén 2 ngày đầu.

Đề phòng căng chỉ khâu bằng cách tránh các nguyên nhân gây căng ép như gập người ho, hắt hơi.

Người bệnh ngồi dậy từ từ và vận động một cách thận trọng.

Nếu nôn: cho người bệnh nằm nghiêng một bên, nếu nôn nhiều cần báo ngay thầy thuốc.

Theo dõi tiền phòng: Bóng hơi tiền phòng có di động tốt không, tiền phòng có máu, mủ không, có dịch rỉ viêm không?

Theo dõi vết mổ co kín không?

Theo dõi giác mạc có phù không?

Phụ giúp thầy thuốc thay băng hang ngày cho người bệnh.

Khi người bệnh ra viện: thử thị lực, nhãn áp.

Trong trường hợp người bệnh phẫu thuật lấy thủy tinh thể nhưng không đặt được thể thủy tinh nhân tạo thì trước khi ra viện người điều dưỡng cần thử kính cho người bệnh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sau mổ: đau tăng, đỏ nhiều, giảm thị lực hoặc tiết dịch bất thường phải báo bác sĩ mắt ngay; bảo vệ mắt, không dụi.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh nhìn rõ hơn.

Hết lo lắng về bệnh tật.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

14 Quy trình chăm sóc chấn thương mắt

Mã đề xuất QTCS-14. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Bị tác nhân gì gây đụng giập hay xuyên thủng?

Thời gian bao lâu?

Đau nhức như thế nào?

Nhìn mờ nhiều hay ít?

Đã được xử trí chưa?

Khám: Mi mắt, kết mạc, giác mạc, mống mắt, đồng tử, tiền phòng, thủy tinh thể.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau nhức mắt sau khi bị chấn thương.

Tụ máu, chảy máu mắt do tổn thương đụng giập và vết thương xuyên thủng.

Lo lắng lo sợ bị chảy nhiều máu hoặc bị phù.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm đau nhức mắt.

Cầm máu (những vết thương xuyên thủng).

Làm tiêu máu (những chấn thương đụng giập).

Giảm lo lắng cho người bệnh.

Giáo dục cho người bệnh cách đề phòng chấn thương.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. NHANH CHÓNG LÀM GIẢM ĐAU NHỨC MẮT

Giảm đau theo y lệnh; không tự nhỏ thuốc tê khi chưa đánh giá tổn thương nhãn cầu.

Chỉ đo nhãn áp khi bác sĩ đã loại trừ tổn thương nhãn cầu hở và có chỉ định; báo kết quả bất thường ngay.

Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh của bác sĩ.

2. CẦM MÁU NHỮNG VẾT THƯƠNG XUYÊN THỦNG

Nếu nghi vết thương xuyên hoặc vỡ nhãn cầu: không rửa, không ấn ép, không lấy dị vật cắm vào mắt; đặt tấm che cứng bảo vệ và báo bác sĩ mắt khẩn.

Chuẩn bị và hỗ trợ gây tê khi bác sĩ chỉ định và người thực hiện đủ phạm vi chuyên môn; không tự gây tê vết thương mắt.

Trợ giúp bác sĩ khâu vết thương cầm máu.

Thực hiện y lệnh thuốc: Kháng sinh, giảm phù nề.

3. LÀM TIÊU MÁU (CHẤN THƯƠNG ĐỤNG GIẬP GÂY XUẤT HUYẾT TIỀN PHÒNG)

Bảo vệ mắt bị thương bằng tấm che cứng khi nghi nhãn cầu hở; tránh băng ép, không băng kín hai mắt thường quy.

Khi nghi nhãn cầu hở hoặc cần phẫu thuật, tạm ngừng ăn uống và báo bác sĩ để hướng dẫn gây mê; không cho ăn lỏng mặc định.

Thực hiện chế độ chăm sóc cấp I.

Chuẩn bị can thiệp chuyên khoa theo chỉ định; không đưa tiêm hyase cạnh nhãn cầu thành chăm sóc thường quy.

4. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Động viên an ủi người bệnh.

Xử trí kịp thời, đúng phương pháp theo từng loại chấn thương.

Thực hiện thuốc an thần cho người bệnh khi có chỉ định của thầy thuốc.

5. GIÁO DỤC CHO NGƯỜI BỆNH CÁCH ĐỂ PHÒNG CHẤN THƯƠNG

Làm cho người bệnh hiểu rõ tác hại của chấn thương.

Biết cách tự cứu khi bị chấn thương và cần đến ngay cơ sở chuyên khoa điều trị.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Nghi xuyên hoặc vỡ nhãn cầu: che cứng, không ấn, không đo nhãn áp, không lấy dị vật cắm sâu; giữ an toàn và chuyển khám mắt khẩn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh đỡ đau nhức.

Vết khâu liền.

Máu tiêu dần.

Hết lo lắng.

Nhìn rõ dần.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [4] Royal Children’s Hospital Acute eye injury, [5] NSW Agency for Clinical Innovation Adult ocular emergency care. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

15 Quy trình chăm sóc bệnh bỏng mắt

Mã đề xuất QTCS-15. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Hỏi chi tiết và ghi lại đầy đủ tính chất, đặc điểm của bỏng mắt:

Bị tác nhân gì, do hóa chất, do nhiệt?

Thời gian bao lâu?

Đau rát như thế nào?

Đã được xử trí chưa?

Khám:

Quan sát:

Mi mắt: phù nề đỏ, nốt phỏng nước, có vết loét do tổn thương cơ.

Kết mạc: trắng nhợt hoặc hoại tử.

Đo thị lực: giảm hoặc mất tùy theo mức độ tổn thương.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau rát mắt sau khi bị bỏng do hóa chất hay do nhiệt.

Chói cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng do kết mạc, giác mạc phù nề.

Lo lắng sợ bị mù.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm đau rát.

Giảm chói cộm, sợ ánh sáng.

Giảm lo lắng cho người bệnh.

Giáo dục cho người bệnh cách đề phòng bỏng mắt.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. NHANH CHÓNG LÀM GIẢM ĐAU NHỨC MẮT

Bỏng hóa chất: bắt đầu tưới rửa ngay bằng nước sạch sẵn có hoặc NaCl 0,9%, tránh dòng chảy sang mắt lành; đồng thời gọi hỗ trợ và bác sĩ mắt. Không trì hoãn để tìm thuốc hoặc làm xét nghiệm.

Thuốc tê tại mắt chỉ sử dụng theo chỉ định hoặc phác đồ đã được phê duyệt và đúng năng lực; không làm chậm tưới rửa.

Không dùng acid, kiềm hoặc dung dịch trung hòa hóa chất. Tiếp tục tưới rửa; phối hợp nhân viên được đào tạo kiểm tra pH và đánh giá tổn thương theo quy trình bỏng hóa chất của bệnh viện.

Sau khử nhiễm và thăm khám, thực hiện thuốc tại mắt theo y lệnh bác sĩ; không bôi thuốc trước khi hoàn tất tưới rửa.

Thực hiện y lệnh thuốc: Kháng sinh, giảm đau, chống phù nề.

2. GIẢM CHÓI CỘM, SỢ ÁNH SÁNG

Bảo vệ mắt theo đánh giá bác sĩ; không băng che làm chậm tưới rửa hoặc gây áp lực lên nhãn cầu.

Cho người bệnh đeo kính râm.

Điều trị và chăm sóc tích cực các tổn thương do bỏng.

3. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Động viên, an ủi, gần gũi làm cho người bệnh an tâm, tin tưởng vào phương pháp điều trị.

Đo thị lực cho người bệnh để đánh giá mức độ tiến triển của bệnh.

4. HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI BỆNH CÁCH ĐỀ PHÒNG BỎNG MẮT

Truyền thông cho mọ người biết được những tính chất nguy hiểm của bỏng mắt.

Trong lao động phải có kính bảo hộ (thợ gò, hàn, mộc,…).

Trong các phòng thí nghiệm, kho hóa chất phải có vòi nước sạch để rửa mắt.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Bỏng hóa chất: tưới rửa ngay, gọi hỗ trợ đồng thời; không trung hòa và không chờ hoàn tất hồ sơ mới xử trí.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh đỡ đau rát, đỡ chói cộm, đỡ chảy nước mắt.

Người bệnh hết lo lắng và nhìn rõ hơn.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [4] Royal Children’s Hospital Acute eye injury, [5] NSW Agency for Clinical Innovation Adult ocular emergency care. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

16 Quy trình chăm sóc bệnh mộng thịt

Mã đề xuất QTCS-16. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Bị đau, đỏ mắt khi nào, từ bao giờ?

Có xốn, cộm gì không?

Có chảy nước mắt không?

Có nhìn mờ không?

Có điều trị thuốc gì chưa?

Khám: Quan sát mi mắt, kết mạc, có cương tụ không? Phân loại mộng thịt.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau rát, cộm xốn trong mắt do mộng thịt kích thích.

Chảy nước mắt do tiếp xúc với bụi, gió.

Người bệnh lo lắng do sợ bị mù.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm giảm đau rát, cộm xốn trong mắt.

Làm giảm chảy nước mắt.

Giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. LÀM GIẢM ĐAU RÁT, CỘM TRONG MẮT

Vệ sinh mi và dịch tiết bằng vật tư phù hợp; nhỏ thuốc hoặc rửa mắt chỉ theo chỉ định, không dùng lịch rửa nhiều lần cho mọi người bệnh.

Tra mỡ Tetracyclin hoặc Oflovid nếu mắt cộm nhiều và đỏ.

2. LÀM GIẢM CHẢY NƯỚC MẮT

Nhỏ kháng sinh tại mắt, nếu chảy nước mắt nhiều do viêm, kích thích.

Có thể nhỏ các loại nước mắt nhân tạo chống khô và kích thích mắt.

Cho bệnh nhân mang kính râm, tránh tiếp xúc ánh sáng và gió bụi.

Thực hiện y lệnh thuốc kháng histamin, vitamin C,…

3. LÀM GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Động viên, an ủi, nói rõ cho bệnh nhân không làm giảm khả năng nhìn.

Đo thị lực cho người bệnh, hướng dẫn người bệnh và người nhà cách theo dõi tiến triển của bệnh, không được tự chữa bệnh.

Giải thích cho người bệnh có thể khỏi nếu phẫu thuật.

4. GIÁO DỤC NGƯỜI BỆNH VÀ PHÒNG BỆNH

Giải thích cho người bệnh nguyên nhân gây bệnh là do tiếp xúc môi trường ô nhiễm, ánh nắng mặt trời, gió, bụi,…

Hướng dẫn người bệnh khi đi ngoài trời nên mang kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi, khói, ánh nắng mặt trời.

Ăn, uống thức ăn có chứa nhiều vitamin A: cà rốt, cà chua, gan bò,…

Dặn dò người bệnh tuân thủ điều trị của bác sĩ, phẫu thuật khi có chỉ định của bác sĩ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, giảm thị lực hoặc vết mổ đỏ, tiết dịch: báo bác sĩ, kiểm tra sử dụng thuốc và bảo vệ mắt.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh hết đau rát, cộm tại mắt.

Hết chảy nước mắt.

An tâm điều trị theo chuyên khoa.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

17 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ

Mã đề xuất QTCS-17. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Có triệu chứng hay quên, nhìn thấy ma quỹ không?

- Có khó ngủ không? Ăn uống có ngon miệng?

- Các thay đổi về nhân cách: Bệnh nhân trở nên thu mình lại, trở nên bủn xỉn, hoài nghi, ghen tuông vô lý, trẻ con hóa, ăn mặc cẩu thả, có khuynh hướng cóp nhặt bẩn thỉu…

- Rối loạn hành vi: Kích động về đêm, rối loạn hành vi ăn uống và bài tiết…

- Có triệu chứng lú lẫn, kích động, ngã,…

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tự chủ không.

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không.

- Xét nghiệm máu:

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, máu lắng, xét nghiệm nước tiểu.

Sinh hóa: Xét nghiệm chức năng gan, thận, điện giải đồ, glucose, HbA1c, canxi, phosphate máu, vitamin B12, folate, hormon tuyến giáp, mỡ máu, cholinesterase máu.

Chẩn đoán hình ảnh: CT sọ não, MRI sọ não, SPECT, PET, fMRI … hỗ trợ chẩn đoán, loại trừ các bệnh lý mạch máu não và tổn thương choán chỗ khác. Siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim phổi phát hiện các bệnh đồng diễn hoặc biến chứng.

Thăm dò chức năng: Điện não đồ, lưu huyết não, ECG, siêu âm Doppler xuyên sọ…

Một số xét nghiệm chuyên biệt: huyết thanh chẩn đoán giang mai, xét nghiệm tự kháng thể (kháng thể kháng phospholipid, kháng thể kháng đông Lupus, kháng thể kháng nhân,…), HIV, gen test, amyloid-PET…

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Rối loạn nhận thức liên quan đến sa sút trí tuệ.

2. Lo âu hoặc căng thẳng.

3. Khó khăn trong việc giao tiếp.

4. Suy giảm khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Cải thiện nhận thức.

- Giảm lo âu và căng thẳng.

- Hỗ trợ giao tiếp.

- Duy trì hoặc cải thiện khả năng sinh hoạt hàng ngày.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CẢI THIỆN NHẬN THỨC

Tạo môi trường an toàn và hỗ trợ, sử dụng các kỹ thuật giúp bệnh nhân nhớ thông tin hoặc khuyến khích bệnh nhân sử dụng các công cụ hỗ trợ trí nhớ.

2. LO ÂU VÀ CĂNG THẲNG

Cung cấp môi trường yên tĩnh, tạo sự ổn định trong thói quen và giao tiếp bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.

3. HỖ TRỢ GIAO TIẾP

Giúp bệnh nhân diễn đạt nhu cầu của mình thông qua ngôn ngữ hình thể, sử dụng các công cụ như hình ảnh hoặc thẻ để giúp bệnh nhân giao tiếp hiệu quả.

4. DUY TRÌ KHẢ NĂNG SINH HOẠT HẰNG NGÀY

Cung cấp sự hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, giúp bệnh nhân duy trì sự độc lập trong khả năng chăm sóc bản thân càng lâu càng tốt.

5. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Người bệnh và người chăm sóc cần hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng và tiến trình phát triển của bệnh. Việc này giúp giảm bớt sự lo lắng và chuẩn bị cho những thay đổi trong cuộc sống.

- Các lựa chọn điều trị hiện có, bao gồm thuốc và các phương pháp hỗ trợ, như trị liệu tâm lý, vật lý trị liệu, hoặc các chương trình phục hồi chức năng trí tuệ.

- Cung cấp thông tin về những loại thực phẩm tốt cho não bộ, như những thực phẩm giàu Omega-3, vitamin E và các chất chống oxy hóa. Cần tránh các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn.

- Khuyến khích bệnh nhân thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, như đi bộ hoặc tập yoga, giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.

- Tạo môi trường giúp bệnh nhân ngủ ngon và đủ giấc. Giấc ngủ kém có thể làm tăng sự rối loạn trí nhớ và tâm trạng.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Lú lẫn thay đổi cấp, bỏ ăn uống, té ngã hoặc hành vi gây nguy hiểm: đánh giá nguyên nhân thực thể và gọi bác sĩ; không xem mọi lú lẫn là tiến triển sa sút trí tuệ.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Theo dõi sự tiến triển của bệnh, đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp.

- Đảm bảo rằng bệnh nhân không gặp nguy hiểm về an toàn, chẳng hạn như ngã, bỏ quên các đồ vật quan trọng, hoặc gặp vấn đề trong việc sử dụng các thiết bị trong nhà.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

18 Quy trình chăm sóc bệnh nhân giai đoạn trầm cảm

Mã đề xuất QTCS-18. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Lịch sử bệnh lý: Tìm hiểu về tiền sử bệnh trầm cảm, các triệu chứng đã xuất hiện, mức độ nghiêm trọng và các yếu tố tác động (stress, gia đình, công việc…).

- Triệu chứng hiện tại: Đánh giá mức độ trầm cảm của bệnh nhân thông qua các câu hỏi và bảng kiểm đánh giá (như Bảng kiểm tra trầm cảm Beck - BDI hoặc Hamilton Depression Rating Scale - HDRS).

- Rủi ro tự tử: Xác định mức độ nguy cơ tự tử của bệnh nhân và thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời nếu cần.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tự chủ không.

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không.

- Xét nghiệm máu:

Các xét nghiệm thường quy.

- Xét nghiệm máu: Công thức máu, sinh hóa.

- Xét nghiệm hocmon tuyến giáp.

- Xét nghiệm vi sinh: viêm gan B, C; HIV….

- Điện não đồ, điện tim đồ, lưu huyết não, đo đa ký giấc ngủ, CT scanner sọ não, MRI sọ não…..

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Rối loạn giấc ngủ liên quan triệu chứng trầm cảm và các yếu tố thực tế được nhận định.

2. Lo âu hoặc căng thẳng.

3. Ăn uống không ngon.

4. Cơ thể luôn mệt mỏi do ăn uống kém.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Cải thiện giấc ngủ.

- Giảm lo âu và căng thẳng.

- Giúp ăn uống ngon miệng.

- Hết triệu chứng mệt mỏi.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ

- Duy trì lịch trình ngủ cố định: Đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

- Tránh thức khuya và ngủ muộn: Cố gắng không thức quá khuya, và tạo thói quen ngủ đủ giấc.

- Tạo môi trường ngủ thoải mái: Đảm bảo phòng ngủ yên tĩnh, tối và có nhiệt độ phù hợp.

- Thư giãn trước khi ngủ:

Thiền hoặc hít thở sâu: Cố gắng thư giãn tâm trí bằng các bài tập thở hoặc thiền.

Tắm nước ấm: Một bồn tắm nước ấm giúp thư giãn cơ thể và dễ đi vào giấc ngủ.

Nghe nhạc nhẹ hoặc âm thanh thư giãn: Nhạc nhẹ nhàng có thể giúp bạn thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

- Hạn chế thói quen có thể gây mất ngủ:

Tránh sử dụng caffeine: Tránh cà phê, trà hoặc các thức uống chứa caffeine ít nhất 6 giờ trước khi ngủ.

Hạn chế sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử: Ánh sáng xanh từ màn hình có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, nên tránh sử dụng điện thoại, máy tính bảng, hoặc máy tính gần giờ ngủ.

Hỗ trợ giấc ngủ bằng biện pháp không dùng thuốc:

Giữ lịch ngủ phù hợp, giảm tiếng ồn và ánh sáng, hạn chế caffeine; chọn cách thư giãn người bệnh chấp nhận.

Không tự khuyên dùng thảo dược, melatonin hoặc thực phẩm bổ sung; phối hợp bác sĩ và dược sĩ khi có nhu cầu, kiểm tra tương tác.

- Tập thể dục đều đặn: Tập thể dục vào buổi sáng hoặc ban ngày sẽ giúp cơ thể mệt mỏi và dễ ngủ hơn vào buổi tối. Tuy nhiên, tránh tập thể dục quá gần giờ ngủ.

2. LO ÂU VÀ CĂNG THẲNG

- Tâm sự với người tin cậy: Nói về cảm xúc của bạn với người thân, bạn bè hoặc một chuyên gia có thể giúp bạn giảm bớt nỗi lo.

- Điều trị bằng liệu pháp tâm lý: Các liệu pháp như CBT (Cognitive Behavioral Therapy) có thể giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và hành động, giảm lo âu và trầm cảm.

- Sử dụng thuốc (nếu cần thiết): Thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc lo âu có thể được bác sĩ kê đơn để giúp giảm triệu chứng.

- Chăm sóc bản thân: Đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tham gia các hoạt động giúp thư giãn như thiền hoặc tập thể dục.

3. GIÚP ĂN UỐNG NGON MIỆNG

- Ăn những món dễ tiêu và hấp dẫn:

Chế biến món ăn đơn giản: Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng để nấu nướng, hãy thử các món ăn dễ làm như cháo, súp, salad, hoặc các món ăn dễ nuốt.

Chọn món ăn có màu sắc tươi sáng: Món ăn đẹp mắt có thể kích thích cảm giác thèm ăn, như rau củ quả màu sắc tươi sáng hoặc trái cây.

- Chia nhỏ bữa ăn: Nếu bạn cảm thấy khó ăn một bữa lớn, hãy thử chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp bạn không cảm thấy áp lực và vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

- Tăng cường thực phẩm giàu Omega-3 và vitamin:

Khuyến khích khẩu phần cân đối và theo dõi lượng ăn thực tế; hỗ trợ dinh dưỡng khi có chỉ định.

Bổ sung vitamin hoặc dưỡng chất theo đánh giá và y lệnh; không coi thực phẩm bổ sung là thay thế điều trị trầm cảm.

- Uống đủ nước: Cảm giác mệt mỏi và thiếu năng lượng có thể làm bạn quên uống nước, nhưng việc giữ cơ thể đủ nước sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và cải thiện tâm trạng. Hãy thử uống nước ấm hoặc các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà gừng để giúp thư giãn.

- Ăn món ăn yêu thích: Thỉnh thoảng ăn món ăn yêu thích dù không cảm thấy thèm ăn cũng có thể giúp tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Điều này cũng giúp bạn cảm nhận được niềm vui trong việc ăn uống.

- Tạo thói quen ăn uống: Nếu có thể, hãy cố gắng tạo ra một thói quen ăn uống đều đặn, ví dụ như ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Điều này giúp cơ thể bạn có cảm giác quen thuộc và ổn định hơn.

4. HẾT TRIỆU CHỨNG MỆT MỎI

- Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn: Cố gắng duy trì một thói quen sinh hoạt lành mạnh, bao gồm giấc ngủ đủ, ăn uống đúng bữa và tập thể dục nhẹ nhàng.

- Giảm stress: Các kỹ thuật giảm stress như thiền, yoga, hoặc những bài tập thở sâu có thể giúp duy trì năng lượng tích cực và giảm nguy cơ trầm cảm tái phát.

- Chăm sóc sức khỏe tinh thần: Tiếp tục theo dõi cảm xúc của bạn, và nếu cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu lo âu hay trầm cảm nào trở lại, đừng ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý.

- Giao tiếp và kết nối xã hội: Duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực, tham gia các hoạt động nhóm hoặc chia sẻ cảm xúc với người thân cũng giúp cải thiện tinh thần và giảm cảm giác cô đơn.

5. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Chăm sóc sức khỏe tinh thần: Hãy duy trì thói quen thư giãn, giảm căng thẳng như thiền, yoga, hoặc các bài tập thở sâu.

- Xây dựng mối quan hệ xã hội tích cực: Tạo và duy trì các mối quan hệ với bạn bè, gia đình để không cảm thấy cô đơn.

- Tập thể dục đều đặn: Các hoạt động thể chất giúp giải phóng endorphins, làm giảm căng thẳng và giúp tinh thần thoải mái hơn.

- Ngủ đủ giấc: Một giấc ngủ chất lượng rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ý định, kế hoạch hoặc hành vi tự sát: báo bác sĩ ngay, giám sát theo mức nguy cơ, hạn chế phương tiện tự hại, không để một mình khi nguy cơ cấp; bàn giao rõ người chịu trách nhiệm.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân khỏe, không còn cảm giác mệt mỏi, ăn uống ngon miệng.

- Sinh hoạt, lao động trở lại bình thường.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

19 Quy trình chăm sóc người bệnh rối loạn dạng cơ thể

Mã đề xuất QTCS-19. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Hỏi triệu chứng cơ thể gây khó chịu, thời điểm khởi phát, mức độ và ảnh hưởng sinh hoạt, giấc ngủ, học tập hoặc công việc.

Ghi những lo lắng về triệu chứng, hành vi kiểm tra sức khỏe, tìm kiếm khám nhiều lần và nhu cầu hỗ trợ.

Khai thác bệnh thực thể, thuốc, xét nghiệm và điều trị trước đây; không kết luận triệu chứng là tưởng tượng chỉ vì đã có chẩn đoán tâm thần.

Đánh giá lo âu, trầm cảm, yếu tố căng thẳng và nguy cơ tự hại khi phù hợp.

Nhận định chức năng xã hội và hỗ trợ gia đình; tôn trọng mô tả triệu chứng của người bệnh.

Báo bác sĩ khi có dấu bất thường mới, đau ngực, khó thở, ngất, yếu liệt hoặc diễn biến không phù hợp; chẩn đoán thuộc bác sĩ.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nđộ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt...

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không.

Xét nghiệm theo chỉ định sau khám; không tự yêu cầu lặp lại xét nghiệm chỉ để trấn an.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Khó chịu hoặc đau liên quan triệu chứng cơ thể thực tế được nhận định.

2. Lo âu về sức khỏe và ảnh hưởng chức năng sinh hoạt.

3. Nhu cầu tăng kỹ năng tự chăm sóc và đối phó căng thẳng.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm mức khó chịu, giúp người bệnh thực hiện hoạt động phù hợp khả năng.

Giảm lo âu và duy trì một kế hoạch theo dõi nhất quán với nhóm điều trị.

Người bệnh hiểu cách dùng thuốc, lịch tái khám và dấu hiệu cần báo ngay.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. HỖ TRỢ TRIỆU CHỨNG VÀ GIẢM LO ÂU

Lắng nghe, xác nhận sự khó chịu và giải thích kế hoạch khám, chăm sóc; không tranh luận rằng người bệnh không có bệnh.

Theo dõi tác dụng và bất lợi của thuốc được bác sĩ chỉ định; phối hợp điều trị bệnh thực thể nếu có.

2. HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VÀ THEO DÕI NHẤT QUÁN

Cùng người bệnh chọn mục tiêu sinh hoạt nhỏ, thực tế; theo dõi mức đau, giấc ngủ và khả năng hoạt động.

Khuyến khích tăng dần hoạt động theo khả năng, không ép vượt mức dung nạp.

Phối hợp một kế hoạch theo dõi thống nhất với bác sĩ; chuyển khám khi có dấu mới, tránh nhiều hướng dẫn mâu thuẫn.

3. PHỐI HỢP HỖ TRỢ TÂM LÝ

Hướng dẫn thở, thư giãn và cách ghi triệu chứng khi phù hợp; hỗ trợ người bệnh nhận biết liên hệ giữa căng thẳng và mức khó chịu.

Giới thiệu chuyên viên tâm lý hoặc bác sĩ chuyên khoa khi có chỉ định; điều dưỡng không tự triển khai liệu pháp chuyên sâu ngoài năng lực.

Theo dõi an toàn và mức hợp tác, cùng gia đình hỗ trợ sinh hoạt phù hợp.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Giải thích đây là kế hoạch phối hợp chăm sóc cơ thể và tâm lý; triệu chứng cơ thể vẫn cần được đánh giá khi thay đổi.

Hướng dẫn thuốc và lịch tái khám theo kế hoạch, không tự tăng liều hoặc đổi thuốc.

Yêu cầu người bệnh nhắc lại dấu nguy hiểm, nơi tái khám và biện pháp tự chăm sóc đã thống nhất.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Triệu chứng cơ thể mới hoặc nặng lên cần đánh giá thực thể; không bỏ qua dấu nguy hiểm vì đã có chẩn đoán tâm thần.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

So sánh mức khó chịu và khả năng sinh hoạt với mục tiêu đã đặt.

Ghi xu hướng lo âu, giấc ngủ, đáp ứng và bất lợi sau can thiệp.

Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch theo dõi và giáo dục; báo bác sĩ nếu có biểu hiện mới hoặc không cải thiện.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [6] WHO Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD 11 mental behavioural and neurodevelopmental disorders 2024. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

20 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn giấc ngủ

Mã đề xuất QTCS-20. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Khó ngủ hoặc duy trì giấc ngủ: Bệnh nhân có gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại được, ngủ ngày được bao nhiêu tiếng, giấc ngủ có sâu hay không.

- Mệt mỏi và thiếu năng lượng vào ban ngày: Bệnh có cảm giác buồn ngủ, mệt mỏi kéo dài trong suốt cả ngày, gây ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày.

- Khó thở khi ngủ: Bệnh nhân có cảm giác khó thở hoặc ngạt thở không?

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, EEG, xét nghiệm cơ bản.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Rối loạn giấc ngủ.

2. Lo âu về giấc ngủ.

3. Mệt mỏi, suy nhược vào ban ngày.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Cải thiện giấc ngủ.

- Giảm lo âu về giấc ngủ.

- Giảm các triệu chứng mệt mõi vào ban ngày.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

- Khuyến khích thói quen ngủ lành mạnh: Tư vấn bệnh nhân về việc duy trì một lịch trình ngủ đều đặn, ngủ và thức vào cùng một giờ mỗi ngày, bao gồm cả vào cuối tuần.

- Thực hiện các kỹ thuật thư giãn: Hướng dẫn bệnh nhân áp dụng các phương pháp thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như hít thở sâu, thiền, hoặc nghe nhạc nhẹ.

- Tạo môi trường yên tĩnh, thoải mái: Khuyến khích bệnh nhân tạo một không gian ngủ yên tĩnh, tối và thoải mái để giảm thiểu các yếu tố gây gián đoạn giấc ngủ. Điều này bao gồm việc sử dụng rèm cửa tối màu, hạn chế ánh sáng và tiếng ồn.

- Chăm sóc giường ngủ: Khuyến khích bệnh nhân sử dụng đệm và gối êm ái, thích hợp với cơ thể để tạo cảm giác thoải mái khi nằm ngủ.

2. GIẢM LO ÂU VỀ GIẤC NGỦ

- Tránh làm việc hoặc lo lắng khi nằm trên giường.

- Giảm lo âu bằng nhận thức: Khuyến khích bệnh nhân thay đổi những suy nghĩ lo lắng về việc không thể ngủ, giúp họ học cách chấp nhận rằng một đêm không ngủ tốt không có nghĩa là sẽ xảy ra những vấn đề nghiêm trọng.

- Tư vấn cho bệnh nhân rằng một đêm mất ngủ không có nghĩa là sẽ gây hại lâu dài cho sức khỏe. Việc lo lắng về việc không ngủ sẽ làm tăng thêm căng thẳng, làm giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

3. GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG MỆT MỎI VÀO BAN NGÀY

- Ăn nhẹ vào buổi tối: Nếu cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, việc ăn một bữa tối nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa có thể giúp cơ thể không cảm thấy nặng nề hoặc khó chịu khi ngủ. Tránh ăn thực phẩm có hàm lượng caffein hoặc đường cao trước khi đi ngủ.

- Uống nước đầy đủ: Đảm bảo cơ thể đủ nước trong suốt cả ngày. Mất nước có thể khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nên hạn chế uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ để tránh thức giấc nhiều lần vào ban đêm.

- Bổ sung thực phẩm giúp cải thiện giấc ngủ: Một số thực phẩm như chuối, hạnh nhân, sữa ấm có thể giúp thư giãn và dễ ngủ hơn, từ đó làm giảm cảm giác mệt mỏi.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Giải quyết các vấn đề về giấc ngủ: Tư vấn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và đưa ra các phương pháp để cải thiện giấc ngủ, giúp bệnh nhân không còn lo lắng về việc không ngủ được.

- Khuyến khích kỹ thuật tư duy tích cực: Hướng dẫn bệnh nhân thay đổi tư duy tiêu cực về giấc ngủ và giảm lo âu, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi đi ngủ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ngủ gà bất thường, ngừng thở khi ngủ, kích động hoặc mất ngủ kèm ý định tự hại: báo bác sĩ, kiểm tra thuốc và bệnh kèm.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh có giấc ngủ sâu, ngủ từ 6- 8 giờ đêm.

- Khỏe, không cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

21 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu lan tỏa

Mã đề xuất QTCS-21. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Bệnh nhân có thường xuyên lo lắng về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, dù là những vấn đề nhỏ nhặt và cảm thấy khó kiểm soát được lo âu của mình.

- Người bệnh có cảm thấy luôn căng thẳng, mệt mỏi dù không làm việc quá nhiều.

- Lo âu có thể gây khó khăn trong việc ngủ, khiến người bệnh thức giấc giữa đêm hoặc không thể chìm vào giấc ngủ.

- Người bệnh có thể cảm thấy khó tập trung vào công việc hoặc các hoạt động hàng ngày, vì lo âu làm giảm khả năng tập trung.

- Thường xuyên cảm thấy bồn chồn, run rẩy, đổ mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn hoặc nhịp tim nhanh.

- Người bệnh có thể cảm thấy căng cơ, đặc biệt là ở vai, cổ hoặc đầu.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, EEG, xét nghiệm cơ bản.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Lo âu quá mức và kéo dài.

2. Suy giảm khả năng tập trung.

3. Rối loạn giấc ngủ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Giảm mức độ lo âu.

- Cải thiện khả năng tập trung.

- Cải thiện giấc ngủ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM MỨC ĐỘ LO ÂU

- Khuyến khích bệnh nhân chia sẻ cảm xúc và lo âu.

- Dạy kỹ thuật thư giãn (hít thở sâu, thiền, yoga).

- Cung cấp thông tin về bệnh lý để giảm sự lo lắng do thiếu thông tin.

- Tạo môi trường an toàn, thoải mái cho bệnh nhân.

2. CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TẬP TRUNG

- Cung cấp môi trường yên tĩnh, không có sự xao lãng.

- Khuyến khích bệnh nhân làm các công việc nhỏ, dễ thực hiện trước để lấy lại tự tin.

- Thực hiện các bài tập giúp tăng cường khả năng tập trung.

3. CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

- Tạo thói quen đi ngủ cố định vào một giờ nhất định.

- Khuyến khích bệnh nhân thư giãn trước khi đi ngủ, tránh những tác nhân gây căng thẳng.

- Đảm bảo môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Giới thiệu cho người thân về rối loạn lo âu: Người thân có thể giúp đỡ bệnh nhân bằng cách hiểu rõ về tình trạng của họ và cung cấp sự hỗ trợ cảm xúc.

- Khuyến khích bệnh nhân tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần: Đôi khi, bệnh nhân có thể cảm thấy xấu hổ hoặc không muốn chia sẻ về vấn đề lo âu. Việc tạo ra một môi trường không phán xét và hỗ trợ là rất quan trọng.

- Khi lo âu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày: Nếu lo âu bắt đầu ảnh hưởng đến công việc, học tập, các mối quan hệ hoặc chất lượng cuộc sống, bệnh nhân nên tìm kiếm sự tư vấn từ bác sĩ hoặc nhà trị liệu.

- Nếu các triệu chứng không cải thiện: Nếu các triệu chứng không giảm đi hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, việc thay đổi phương pháp điều trị hoặc điều chỉnh thuốc có thể cần thiết.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau ngực, khó thở, ngất hoặc biểu hiện mới cần được đánh giá thực thể; không mặc định đó là cơn lo âu.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân yên tâm điều trị, giảm các triệu chứng lo âu.

- Ngủ ngon và sâu giấc.

- Lao động sinh hoạt bình thường, giảm các lần nhập viện điều trị.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

22 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn nghi bệnh

Mã đề xuất QTCS-22. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Người bệnh luôn lo sợ mình mắc bệnh nặng, dù cho các kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường.

- Họ có thể tra cứu thông tin về bệnh trên internet, tham khảo sách vở, hoặc thậm chí thăm khám bác sĩ nhiều lần.

- Người bệnh cảm thấy cơ thể có những triệu chứng mà không thể giải thích được, và họ lo lắng đó là dấu hiệu của bệnh nặng.

- Dù có kết quả khám sức khỏe tốt, người bệnh vẫn có cảm giác rằng các bác sĩ đã bỏ sót hoặc chưa chẩn đoán đúng bệnh.

- Sự lo âu về sức khỏe chiếm ưu thế trong cuộc sống và khiến người bệnh không thể tập trung vào công việc hay các mối quan hệ khác.

- Họ có thể tự chẩn đoán mình mắc bệnh qua những triệu chứng nhỏ và đôi khi sử dụng các phương pháp điều trị không được chứng minh khoa học.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, xét nghiệm cơ bản.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Lo lắng, căng thẳng kéo dài.

2. Cảm giác sợ hãi hoặc nghi ngờ về sức khỏe của mình.

3. Cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau ngực hoặc khó thở mà không có nguyên nhân.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Giảm lo lắng, căng thẳng kéo dài.

- Cải thiện cảm giác sợ hãi hoặc nghi ngờ về sức khỏe của mình.

- Cải thiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau ngực hoặc khó thở mà không có nguyên nhân.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM LO LẮNG, CĂNG THẲNG

- Khuyến khích bệnh nhân chia sẻ cảm xúc và lo âu.

- Dạy kỹ thuật thư giãn (hít thở sâu, thiền, yoga).

- Cung cấp thông tin về bệnh lý để giảm sự lo lắng do thiếu thông tin.

- Tạo môi trường an toàn, thoải mái cho bệnh nhân.

- Nếu bạn cảm thấy lo âu hoặc nghi ngờ mắc bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của mình, hãy cân nhắc việc gặp một bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia trị liệu. Họ có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân và xây dựng kế hoạch điều trị hiệu quả.

2. CẢI THIỆN CẢM GIÁC SỢ HÃI HOẶC NGHI NGỜ BỆNH CỦA MÌNH

- Khi cảm giác lo âu hay sợ hãi xuất hiện, hãy cố gắng làm điều gì đó khác để chuyển hướng sự chú ý của mình. Tập thể dục, tham gia vào sở thích yêu thích, gặp gỡ bạn bè, hoặc thực hiện các công việc hàng ngày có thể giúp bạn quên đi những lo lắng về sức khỏe.

- Chia sẻ cảm xúc của bạn với người thân, bạn bè hoặc một chuyên gia tâm lý có thể giúp bạn giảm bớt sự lo âu và cảm giác cô đơn. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe một người khác có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

3. CẢI THIỆN CẢM GIÁC MỆT MỎI ĐAU ĐẦU...

- Nếu bạn bị đau đầu căng cơ, việc massage nhẹ nhàng vùng đầu, cổ hoặc vai có thể giúp giảm bớt căng thẳng và đau nhức. Bạn có thể thử tự massage hoặc đến một chuyên gia trị liệu để giảm mệt mỏi và đau đầu.

- Nếu bạn phải làm việc nhiều giờ liên tục, đặc biệt là làm việc trước màn hình máy tính, hãy đảm bảo bạn có những khoảng nghỉ ngắn trong suốt ngày. Mỗi 20 phút, hãy nghỉ ngơi khoảng 1-2 phút để mắt và cơ thể được thư giãn. Điều này sẽ giúp giảm căng thẳng mắt và đau đầu.

- Nếu cơn đau đầu rất khó chịu, bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol hoặc ibuprofen. Tuy nhiên, chỉ nên dùng thuốc khi thật sự cần thiết và theo hướng dẫn của bác sĩ.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Dùng thuốc (nếu cần): Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc giảm lo âu hoặc trầm cảm. Cung cấp cho bệnh nhân thông tin về các loại thuốc này và hướng dẫn cách sử dụng chúng đúng cách.

- Theo dõi sức khỏe định kỳ: Khuyến khích bệnh nhân đi khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe, giúp giảm bớt nỗi lo và cung cấp thông tin khoa học về tình trạng sức khỏe thực sự của họ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Không phủ nhận triệu chứng; dấu mới hoặc nặng lên được đánh giá như người bệnh khác, thống nhất kế hoạch với bác sĩ.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân yên tâm điều trị, giảm các triệu chứng lo âu.

- Ngủ ngon và sâu giấc.

- Lao động, sinh hoạt bình thường, giảm dần các triệu chứng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

23 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn stress sau sang chấn

Mã đề xuất QTCS-23. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Trải qua lại sự kiện đau thương, có thể xảy ra đột ngột mà không có cảnh báo.
- NB thấy mình đang sống lại những cảm xúc hoặc hình ảnh từ sự kiện đó.
- Các cơn ác mộng về sự kiện chấn thương.
- NB rối loạn giấc ngủ, thức giấc thường xuyên hoặc cảm giác lo âu khi ngủ.
- NB cảm thấy buồn bã, thất vọng, hoặc không còn hy vọng.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.
- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.
- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.
- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?
- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?
- Xét nghiệm máu: đo ECG, xét nghiệm cơ bản.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Bệnh nhân cảm giác lo sợ, căng thẳng và khó kiểm soát cảm xúc.

2. Bệnh nhân gặp khó khăn trong việc ngủ, dễ thức giấc giữa đêm, hoặc gặp ác mộng liên quan đến sự kiện chấn thương.

3. Bệnh nhân có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, cảm thấy tội lỗi hoặc vô dụng, hoặc mất niềm tin vào thế giới xung quanh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Giảm cảm giác lo sợ, căng thẳng.
- Cải thiện giấc ngủ cho người bệnh.
- Cải thiện các suy nghĩ tiêu cực.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM CẢM GIÁC LO SỢ, CĂNG THẲNG

- Khuyến khích bệnh nhân chia sẻ cảm xúc và lo âu.

- Dạy kỹ thuật thư giãn (hít thở sâu, thiền, yoga).

- Khuyến kích người bệnh vẽ, viết nhật ký, hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo khác giúp giải tỏa cảm xúc và giảm căng thẳng.

- Tạo môi trường an toàn, thoải mái cho bệnh nhân.

2. CẢI THIỆN GIẤC NGỦ CHO NGƯỜI BỆNH

- Tạo thói quen đi ngủ cố định vào một giờ nhất định.

- Khuyến khích bệnh nhân thư giãn trước khi đi ngủ, tránh những tác nhân gây căng thẳng.

- Đảm bảo môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái.

- Ga gối nên giặt sạch sẽ thường xuyên.

3. CẢI THIỆN CÁC SUY NGHĨ TIÊU CỰC

- Hãy nghĩ về những điều tích cực mà bạn đã trải qua và những thành tựu mà bạn đã đạt được. Điều này giúp giảm cảm giác tiêu cực và giúp bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân.

- Xem xét những bằng chứng thực tế để xem suy nghĩ của bạn có đúng không. Điều này giúp giảm mức độ tiêu cực và mở rộng cách nhìn nhận vấn đề.

- Nếu bạn cảm thấy tội lỗi hay trách móc bản thân về sự kiện sang chấn, hãy học cách tha thứ cho chính mình. Đây là bước quan trọng trong việc giảm bớt cảm giác tiêu cực và xây dựng lại sự tự tin.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Người bệnh thường cảm thấy lo âu, bất an hoặc không kiểm soát được các tình huống. Việc duy trì một môi trường yên bình, an toàn và ổn định sẽ giúp họ cảm thấy ít bị căng thẳng hơn.

- Tránh kích thích người bệnh bằng những hình ảnh, âm thanh hoặc môi trường có thể làm họ cảm thấy sợ hãi hoặc nhớ lại sự kiện sang chấn.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Tự hại, mất khả năng kiểm soát hoặc phản ứng kích động: giữ môi trường an toàn, báo bác sĩ; không buộc kể lại sang chấn khi người bệnh chưa sẵn sàng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu

hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân yên tâm điều trị, giảm các triệu chứng lo âu.

- Ngủ ngon và sâu giấc.

- Lao động sinh hoạt bình thường.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

24 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu

Mã đề xuất QTCS-24. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Bệnh nhân có thường uống rượu, uống ngày bao nhiêu ml, uống rượu gì?

- Có run tay chân không?

- Có nói nhãm không? Ngủ được không?

- Ăn uống được không?

- Có các rối loạn hành vi không?

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Thần kinh: có tỉnh táo không, trả lời có đúng các câu hỏi?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, EEG, xét nghiệm cơ bản, siêu âm bụng, X-quang phổi.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Bệnh nhân có hành vi sử dụng rượu không kiểm soát.

2. Bệnh nhân thiếu kiến thức về tác hại của rượu đối với sức khỏe.

3. Mất ngủ, ngủ không sâu giấc.

4. Thiếu hụt dinh dưỡng do ăn kém.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Giảm thiểu hoặc ngừng sử dụng rượu.

- Cung cấp kiến thức về tác hại của rượu.

- Cải thiện giấc ngủ.

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM THIỂU HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG RƯỢU

- Dạy bệnh nhân các kỹ thuật thư giãn như thở sâu, thiền, yoga để giảm bớt căng thẳng, lo âu, những yếu tố có thể làm tăng cơn thèm rượu.

- Khuyến khích bệnh nhân tham gia các hoạt động khác để phân tâm khỏi suy nghĩ về rượu như thể dục, học một kỹ năng mới, hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

- Dùng thuốc giúp ngừng sử dụng rượu bằng cách gây ra các phản ứng khó chịu (như buồn nôn, nôn mửa) khi bệnh nhân uống rượu, giúp họ tránh xa việc sử dụng.

2. CUNG CẤP KIẾN THỨC VỀ TÁC HẠI CỦA RƯỢU

- Giới thiệu cho bệnh nhân về những tác hại của việc sử dụng rượu kéo dài, chẳng hạn như xơ gan, bệnh tim mạch, các vấn đề tâm lý (trầm cảm, lo âu), và các vấn đề xã hội (gia đình, công việc, mối quan hệ).

- Nhấn mạnh các lợi ích về sức khỏe như cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, cải thiện khả năng làm việc và duy trì các mối quan hệ lành mạnh.

3. CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

- Tạo thói quen đi ngủ cố định vào một giờ nhất định.

- Khuyến khích bệnh nhân thư giãn trước khi đi ngủ, tránh những tác nhân gây căng thẳng.

- Đảm bảo môi trường ngủ yên tĩnh, thoải mái.

4. CẢI THIỆN DINH DƯỠNG

- Cung cấp Vitamin B (đặc biệt là B1): thiếu B1 gây rối loạn thần kinh nghiêm trọng.

- Cung cấp Vitamin C: Cần thiết cho hệ miễn dịch và giúp cơ thể hồi phục.

Đánh giá nguy cơ thiếu dinh dưỡng và thiamine; thực hiện thiamine, điện giải theo y lệnh. Không bổ sung magnesi, kẽm thường quy khi chưa có đánh giá.

- Người nghiện rượu thường có chế độ ăn thiếu protein. Việc cung cấp đủ protein giúp hỗ trợ cơ thể tái tạo mô và duy trì sức khỏe cơ bắp. Các nguồn protein tốt bao gồm: thịt nạc, cá, trứng, đậu hạt và các sản phẩm từ sữa.

5. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Khuyến khích bệnh nhân tạo một không gian sống không có rượu, tránh xa các tình huống dễ gây cám dỗ để uống lại.

- Tham gia vào các hoạt động cộng đồng: Việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng có thể giúp bệnh nhân xây dựng lại mối quan hệ xã hội tích cực và giảm cảm giác cô đơn.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Hỏi giờ uống rượu cuối và tiền sử cai nặng; run, vã mồ hôi, tăng hoạt thần kinh tự chủ, ảo giác, co giật hoặc lú lẫn cần báo khẩn. Dùng thang đánh giá cai rượu khi đã được đào tạo và theo phác đồ.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân yên tâm điều trị, giảm hoặc ngừng hẳn việc uống rượu.

- Ngủ ngon và sâu giấc.

- Ăn uống ngon miệng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

25 Quy trình chăm sóc bệnh nhân bệnh động kinh

Mã đề xuất QTCS-25. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Có mất ý thức tạm thời không?

- Có co giật cơ thể (giật một phần hoặc toàn bộ cơ thể) không?

- Nhìn chằm chằm vào khoảng không?

- Mất kiểm soát cơ thể (té ngã, cứng đờ hoặc co giật mạnh).

- Rối loạn giác quan (nghe thấy âm thanh lạ, nhìn thấy ánh sáng chớp hoặc ảo giác).

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Thần kinh: có tỉnh táo không, trả lời có đúng các câu hỏi?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, EEG, xét nghiệm cơ bản, siêu âm bụng, X-quang phổi.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Nguy cơ chấn thương liên quan đến co giật không kiểm soát.

2. Lo lắng, sợ hãi liên quan đến bệnh mãn tính và cơn động kinh không kiểm soát.

3. Thiếu kiến thức về bệnh và cách chăm sóc bản thân.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Đảm bảo an toàn khi co giật.

- Làm giảm cảm giác lo lắng, sợ hải.

- Bổ sung kiến thức cho bệnh nhân.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI CO GIẬT

- Cho thở oxy nếu cần thiết.

- Đảm bảo không gian an toàn khi lên cơn, tránh té ngã.

Bảo vệ đầu, dọn vật nguy hiểm, theo dõi thời gian cơn; khi có thể đặt nằm nghiêng an toàn, không cố xoay hoặc ghì giữ trong lúc co giật.

- Không kìm giữ bệnh nhân hoặc đưa vật vào miệng.

- Thực hiện thuốc chống co giật theo y lệnh.

2. LÀM GIẢM CẢM GIÁC LO LẮNG, SỢ HẢI

- Giải thích rõ về bệnh, giúp bệnh nhân hiểu cách kiểm soát bệnh.

- Động viên tinh thần, hỗ trợ tâm lý.

- Hướng dẫn gia đình cách giúp đỡ bệnh nhân.

3. BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO BỆNH NHÂN

- Hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc đúng cách.

- Giải thích về các yếu tố kích thích cơn (thiếu ngủ, căng thẳng, rượu bia...).

- Dạy người thân cách sơ cứu khi bệnh nhân lên cơn.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Dùng thuốc đúng liều, đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ.

- Không tự ý ngưng thuốc ngay cả khi đã lâu không có cơn.

Nếu quên liều, làm theo hướng dẫn của thuốc hoặc hỏi bác sĩ, dược sĩ; không tự uống gấp đôi.

- Tái khám định kỳ để điều chỉnh thuốc nếu cần.

- Một số thuốc có thể gây buồn ngủ, mệt mỏi, tăng cân...

- Nếu có dấu hiệu bất thường (phát ban, chóng mặt nhiều, rối loạn tâm trạng...), cần báo bác sĩ ngay.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ghi giờ bắt đầu cơn; co giật từ 5 phút hoặc tái diễn không hồi phục cần cấp cứu ngay. Không ghì giữ, không nhét vật vào miệng, không cho uống khi chưa tỉnh và nuốt an toàn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân có uống thuốc đúng liều, đúng giờ.

- Bệnh được an toàn trong cơn co giật.

- Tần suất co giật ít lại hoặc mất hẳn.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [7] NICE NG217 Treating status epilepticus repeated or cluster seizures and prolonged seizures. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

26 Quy trình chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt

Mã đề xuất QTCS-26. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Bệnh nhân bị hoang tưởng, tin rằng có người đang theo dõi, muốn làm hại mình.

- Bệnh bị ảo giác nghe thấy tiếng nói trong đầu, có thể là tiếng ra lệnh, đe dọa hoặc bình luận về bản thân.

- Bệnh bị rối loạn tư duy, nói năng lộn xộn, câu chuyện không có mạch lạc, tư duy rời rạc, khó hiểu, đôi khi nói những câu vô nghĩa.

- Cử động bất thường, đứng hoặc ngồi bất động trong thời gian dài, hành vi kỳ quặc, không có mục đích rõ ràng.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

- Tuần hoàn: nhịp tim có nhanh, có đều không.

- Hô hấp có thở nhanh, thở gấp không.

- Tiêu tiểu có tiểu gắt buốt không?

- Tiêu hóa: có ăn uống ngon miệng không?

- Thần kinh: có tỉnh táo không, trả lời có đúng các câu hỏi?

- Xét nghiệm máu: đo ECG, EEG, xét nghiệm cơ bản, siêu âm bụng, X-quang phổi.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Rối loạn tri giác liên quan đến ảo giác.

2. Rối loạn tư duy liên quan đến hoang tưởng.

3. Rối loạn hành vi liên quan đến kích động hoặc hành vi kỳ quái.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Giảm các triệu chứng ảo giác.

- Giảm các triệu chứng hoang tưởng.

- Giảm các hành vi kích động.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG ẢO GIÁC

- Trấn an bệnh nhân, tránh tranh cãi về ảo giác.

- Hướng dẫn bệnh nhân nhận biết và kiểm soát ảo giác.

- Sử dụng thuốc an thần theo chỉ định bác sĩ.

2. LÀM GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG HOANG TƯỞNG

- Không tranh cãi hay bác bỏ hoang tưởng của bệnh nhân.

- Hướng dẫn bệnh nhân tập trung vào thực tế.

- Giữ môi trường an toàn, tránh kích động.

3. GIẢM CÁC HÀNH VI KÍCH ĐỘNG

- Đảm bảo môi trường an toàn, loại bỏ vật nguy hiểm.

- Sử dụng phương pháp giảm căng thẳng như hít thở sâu, âm nhạc.

- Hỗ trợ thuốc an thần nếu cần.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Dùng thuốc đúng cách:

+ Uống thuốc đúng liều, đúng giờ, không tự ý ngừng thuốc.

+ Nếu có tác dụng phụ (tăng cân, mệt mỏi, cứng cơ...), cần báo bác sĩ để điều chỉnh.

- Tái khám định kỳ:

+ Kiểm tra sức khỏe tâm thần thường xuyên để đánh giá hiệu quả điều trị.

+ Điều chỉnh thuốc khi cần thiết, tránh để bệnh tái phát.

- Phát hiện dấu hiệu tái phát sớm:

Tái phát thường có dấu hiệu như: + Mất ngủ, lo lắng, căng thẳng tăng lên.

+ Trở nên ít nói, tránh giao tiếp.

+ Hoang tưởng, ảo giác xuất hiện trở lại.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ảo thanh sai khiến, tự hại hoặc đe dọa người khác: báo bác sĩ, giảm kích thích và giám sát an toàn; biện pháp hạn chế chỉ theo chỉ định và quy định bệnh viện.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân có uống thuốc đúng liều, đúng giờ.

- Bệnh giảm hoặc mất triệu chứng ảo giác, hoang tưởng, kích động.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Chăm sóc nhi khoa

27 Quy trình chăm sóc bệnh nhân quai bị

Mã đề xuất QTCS-27. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Có sốt? Mấy ngày? Nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu?

- Tình trạng chủng ngừa?

- Tri giác, hô hấp?

- Đã điều trị thuốc gì chưa?

- Sưng hàm? 1 bên hay 2 bên? Đau tuyến mang tai khi nhai hoặc uống thức uống chua? Xuất hiện khi nào?

- Tình trạng vùng bìu?

- Dịch tễ: Xung quanh nơi ở có người bệnh quai bị?

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Tổng trạng: chiều cao, cân nặng.

- Dấu hiệu sinh tồn:

+ Nhiệt độ: Sốt nhẹ nhiệt độ 37,50C đến 38,50C, sốt vừa 38,50C đến 390C, sốt cao 390C đến 400C, sốt rất cao trên 400C.

+ Tình trạng hô hấp: Điếm nhịp thở, kiểu thở, xác định khó thở thanh quản, tình trạng tím tái, mức độ tăng tiết, ho, khàn giọng, mất giọng,…

Đo mạch, huyết áp và đánh giá tưới máu thực tế; tần suất theo mức độ nặng và y lệnh, tăng theo dõi ngay khi bất ổn, không áp dụng 30 phút/lần cho mọi trẻ.

- Tình trạng thần kinh: Mệt mỏi, bứt rứt, vật vả, liệt,…

- Tuyến mang tai: sưng, bờ thường không rõ, da trên tuyến không đỏ, không nóng, ấn vào đàn hồi, có thể có kèm sưng tuyến dưới hàm và dưới lưỡi.

- Xét nghiệm máu:

+ Công thức máu: bạch cầu bình thường hoặc giảm, tỷ lệ lympho tăng.

+ Amylase máu tăng 90% các trường hợp.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

3.1. Sốt do siêu vi.

3.2. Nguy cơ co giật do sốt cao.

3.3. Nguy cơ mất nước do sốt.

3.4. Nguy cơ xảy ra các biến chứng.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

- Phát hiện sớm tình trạng co giật do sốt cao.

- Bù nước, điện giải.

- Phát hiện sớm biến chứng.

- Cung cấp kiến thức.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. SỐT DO SIÊU VI

Mục tiêu chăm sóc: Duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

- Thực hiện thuốc hạ sốt theo y lệnh.

- Uống thêm nước.

- Hướng dẫn lau mát cho bé.

- Mặc quần áo mỏng, ở phòng thoáng mát.

- Theo dõi nhiệt độ của bé sau 30 phút dùng thuốc, sau mỗi giờ nếu bé chưa hạ sốt, lặp lại thuốc hạ sốt sau 4 giờ nếu bé vẫn còn sốt.

2. NGUY CƠ CO GIẬT DO SỐT CAO

Mục tiêu chăm sóc: Phát hiện sớm tình trạng co giật do sốt cao.

- Theo dõi sát sinh hiệu của bé.

- Hướng dẫn người nhà cách theo dõi nhiệt độ, cách lau mát cho bé.

- Khai thác tiền sử co giật của bé.

3. NGUY CƠ MẤT NƯỚC DO SỐT

Mục tiêu chăm sóc: Bù nước, điện giải.

- Thực hiện truyền dịch theo y lệnh (nếu cần).

- Cho bé uống thêm nước (nước trái cây, nước dừa tươi, dung dịch mặn ngọt....).

- Theo dõi dấu mất nước.

- Tăng cường dinh dưỡng cho bé (tăng số lần bú, ăn của bé...).

4. NGUY CƠ XẢY RA CÁC BIẾN CHỨNG

Mục tiêu: Phát hiện sớm biến chứng.

- Theo dõi tình trạng da của trẻ.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tri giác, tình trạng hô hấp,...

- Đắp ấm vùng tuyến mang tai để giảm đau.

- Mặc quần lót nâng tinh hoàn để giảm căng và đau nhức.

- Chăm sóc răng miệng: Tránh bội nhiễm và giúp BN ăn ngon miệng.

- Vệ sinh mắt, vệ sinh thân thể hàng ngày.

- Cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, giàu năng lượng, tránh ăn thức ăn lạnh, nóng, chua quá làm bệnh nhân đau và khó chịu.

5. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Giải thích cho bệnh nhân hiểu sự nguy hiểm của bệnh, các biến chứng có thể xảy ra để gia đình phối hợp với thầy thuốc trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

- Hướng dẫn gia đình cách chế biến thức ăn, cách theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm, cách phòng biến chứng.

- Trẻ phải nằm cách ly.

- Hướng dẫn người nhà xử lý chất thải đúng nơi quy định.

- Người chăm sóc trẻ phải rửa tay sạch trước khi chăm sóc trẻ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, đau đầu nhiều, cổ cứng, thay đổi tri giác, đau bụng hoặc sưng đau tinh hoàn: báo bác sĩ đánh giá biến chứng; cách ly theo đường lây và quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Nhiệt độ ổn định.

- Không có dấu hiệu mất nước.

- Không thấy xảy ra biến chứng.

- Ăn uống khá.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

28 Chăm sóc người bệnh sởi

Mã đề xuất QTCS-28. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Mệt mỏi, ngủ li bì hay quấy khóc?

- Sốt cao, sốt ngày thứ mấy?

- Có ho, khó thở? Có đau họng, đau tai?

- Tình trạng đi ngoài?

- Tiền sử dịch tễ: Xung quanh có ai mắc bệnh này?

- Tiền sử bệnh, hoàn cảnh kinh tế, tâm lý người bệnh.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG

* Đo dấu hiệu sinh tồn, SpO2.

- Nhiệt độ: Thường sốt >380C.

- Mạch bình thường hoặc hơn nhanh.

- Huyết áp bình thường hoặc hơi tăng ở giai đoạn sốc.

- Nhịp thở: Quan sát kiểu thở.

* Hô hấp: Đếm nhịp thở, quan sát kiểu thở, tím môi và đầu chi, đo SpO2.

Lưu ý trường hợp có biến chứng suy hô hấp, có kèm theo các triệu chứng sau: thở nhanh, thở rít, rút lõm lồng ngực, ho khò khè, tím tái môi và đầu chi. SpO2 <92%.

* Tuần hoàn (có biểu hiện sốc):

- Mạch nhanh theo tuổi hoặc khó bắt.

- Huyết áp giai đoạn đầu có thể tăng.

- Giai đoạn suy hô hấp nặng có sốc huyết áp tụt hoặc không đo được.

* Tiêu hóa: Tính chất, số lượng, màu sắc của phân, đánh giá dấu hiệu mất nước nếu người bệnh đại tiện phân lỏng nhiều lần.

* Tiết niệu: Số lượng và màu sắc nước tiểu 24h.

* Da và niêm mạc:

- Quan sát thứ tự phát ban, vị trí ban, màu sắc ban.

- Mắt đỏ, chảy nước mắt, có thể sưng nề mi mắt, viêm kết mạc mắt.

* Các biểu hiện thường gặp:

- Phát ban đỏ theo trình tự: Chân tóc, đầu, mặt, cổ, thân mình, tứ chi.

- Mắt đỏ, chảy nước mắt, có thể sưng nề mi mắt, viêm kết mạc mắt.

3. CÁC XÉT NGHIỆM, CẬN LÂM SÀNG

- Huyết thanh chẩn đoán sởi, X-quang phổi, công thức máu, sinh hóa, nước tiểu.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

4.1. Tăng thân nhiệt, nhức đầu, mệt mỏi do nhiễm virus.

4.2. Đỏ mắt do viêm kết mạc.

4.3. Nguy cơ suy hô hấp do viêm xuất tiết làm tắc nghẽn đường hô hấp.

4.4. Nguy cơ mất nước do tiêu chảy.

4.5. Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng do mệt mỏi, chán ăn, đau họng, rối loại tiêu hóa.

4.6. Gia đình và hướng bệnh thiếu kiên thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. TĂNG THÂN NHIỆT DO NHIỄM VIRUS

Mục tiêu: Duy trì nhiệt độ ở mức độ ổn định.

Áp dụng phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa lây truyền qua không khí cho người bệnh nghi hoặc xác định sởi; bố trí cách ly phù hợp, nhân viên sử dụng phương tiện bảo vệ hô hấp theo quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Cho người bệnh nằm phòng thoáng, nới rộng quần áo.

Theo dõi nhiệt độ và mức khó chịu, mặc thoáng, dùng thuốc hạ sốt đúng cân nặng theo y lệnh; không lau mát hoặc chườm thường quy chỉ dựa trên một ngưỡng nhiệt độ.

- Thực hiện thuốc hạ sốt, giảm đau theo y lệnh.

- Đo nhiệt độ 4 lần/ngày và khi sốt.

- Trường hợp sốt cao cần kiểm tra lại nhiệt độ 1-2h/lần.

Hỗ trợ bú và ăn uống phù hợp tuổi, bù dịch theo mức mất nước và y lệnh; dùng dung dịch bù nước đúng pha khi được chỉ định, không thay bằng nước hoa quả.

2. ĐỎ MẮT DO VIÊM KẾT MẠC

Mục tiêu: giảm đỏ mắt.

- Thực hiện nhỏ thuốc mắt cho người bệnh theo y lệnh.

3. NGUY CƠ SUY HÔ HẤP DO VIÊM XUẤT TIẾT LÀM TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP

Mục tiêu: phát hiện sớm biến chứng.

- Đếm nhịp thở, quan sát kiểu thở nếu có tăng tiết: vệ sinh mũi, hút đờm dãi.

- Nếu người bệnh có biểu hiện khó thở: Đo SpO2 và cho thở Oxy.

- Vệ sinh mũi họng: Xúc miệng họng bằng dung dịch Natriclorid, rửa mũi.

- Thực hiện thuốc theo y lệnh.

- Theo dõi tình trạng hô hấp.

4. NGUY CƠ THIẾU HỤT DINH DƯỠNG

Mục tiêu: đảm bảo đủ dinh dưỡng.

- Cho người bệnh ăn thức ăn nhẹ, đảm bảo dinh dưỡng, ăn theo khẩu vị, chia nhỏ bữa trong ngày (trẻ nhỏ ăn chế độ ăn bình thường theo lứa tuổi).

- Thực hiện y lệnh, bù dịch bằng đường uống/truyền tĩnh mạch theo y lệnh.

- Bổ sung Vitatmin A.

- Theo dõi tình trạng ăn uống, tình trạng đi ngoài của người bệnh.

5. NGUY CƠ MẤT NƯỚC DO TIÊU LỎNG

Mục tiêu: phát hiện nguy cơ.

- Động viên người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, nước ORS.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, nước tiểu, đại tiện, cân bằng dịch vào ra.

- Bù dịch bằng đường uống/truyền tĩnh mạch theo y lệnh.

- Vệ sinh răng miệng, mũi họng.

- Vệ sinh tay trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh sởi.

- Xử lý chất thải, khử khuẩn buồng bệnh, phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

6. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc với người lành trong trong thời kỳ bị bệnh để tránh lây lan cho cộng đồng.

- Hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh, cách phòng tránh lây nhiễm: đeo khẩu trang khi tiếp xúc, vệ sinh tay, vệ sinh đồ dùng, vệ sinh đồ chơi cho trẻ.

- Hướng dẫn cách theo dõi và phát hiện các dấu hiệu biến chứng, báo cho NVYT để xử lý sớm kịp thời.

- Hướng dẫn người nhà cách chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh.

- Tư vấn, hướng dẫn tiêm phòng vaccin.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, co giật, li bì, không uống được hoặc mất nước: báo bác sĩ khẩn, hỗ trợ ABCDE; duy trì phòng ngừa lây truyền qua không khí.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Người bệnh hết sốt.

- Ban trên da bay hết để lại rát thâm trên da, mắt không đỏ.

- Ăn uống ngon miệng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [8] CDC Interim infection prevention and control recommendations for measles in healthcare settings. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

29 Quy trình chăm sóc bệnh nhân ngộ độc acetaminophen

Mã đề xuất QTCS-29. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Hỏi bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân:

+ Xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

+ Số lượng, thời gian, hoàn cảnh.

+ Lý do ngộ độc: tự tử, uống lầm.

- Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi ngộ độc có mắc các bệnh lý gan?

- Triệu chứng của biểu hiện ngộ độc: đau bụng, nôn ói, tiêu, tiêu chảy…

- Tiền sử dị ứng thuốc và thức ăn? Tiền sử gia đình?

- Các loại vắc xin đã tiêm chủng?

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Tổng trạng: chiều cao, cân nặng.

- Dấu hiệu sinh tồn:

+ Nhiệt độ: Sốt nhẹ nhiệt độ 37,50C đến 38,50C, sốt vừa 38,50C đến 390C, sốt cao 390C đến 400C, sốt rất cao trên 400C.

+ Tình trạng hô hấp: Điếm nhịp thở, kiểu thở, xác định khó thở thanh quản, tình trạng tím tái, mức độ tăng tiết, ho, ….

Đo mạch, huyết áp và đánh giá tưới máu thực tế; tần suất theo mức độ nặng và y lệnh, tăng theo dõi ngay khi bất ổn, không áp dụng 30 phút/lần cho mọi trẻ.

- Trước 24 giờ: biếng ăn, nôn ói, đau bụng, li bì, mệt.

- Sau 24 – 72 giờ: nôn ói, tăng men gan, kéo dài PT, tổn thương thận, tổn thương tụy.

- Từ 72 – 96 giờ: hoại tử tế bào gan, suy gan, vàng da, bệnh não - gan, rối loạn đông máu, xuất huyết, suy thận cấp, suy đa tạng, có thể đưa đến tử vong.

- Từ ngày thứ 4 đến 2 tuần: suy gan tiến triển hoặc hồi phục.

Cận lâm sàng:

- Thường quy: Công thức máu, điện giải đồ, ure, creatin, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm bụng.

- Đặc hiệu:

Lấy mẫu định lượng paracetamol và xét nghiệm gan theo y lệnh, ghi chính xác giờ uống và giờ lấy mẫu; thời điểm xét nghiệm phụ thuộc dạng thuốc và kiểu quá liều.

+ AST, ALT, bilirubine, albumin (thường thay đổi sau ngộ độc 24 – 36 giờ vì thế cần lặp lại xét nghiệm chức năng gan sau 24 giờ nhập viện).

+ Đường huyết, chức năng đông máu, NH3, khí máu.

Bác sĩ diễn giải nồng độ theo thời gian và đơn vị trên biểu đồ Rumack–Matthew khi phù hợp; không áp dụng máy móc cho uống nhiều lần, không rõ giờ uống hoặc dạng giải phóng kéo dài.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Nguy cơ tổn thương gan do ngộ độc paracetamol.

2. Nguy cơ hôn mê, co giật, suy hô hấp do liên quan đến chất độc.

3. Nguy cơ mất dịch – rối loạn điện giải do nôn ói, đau bụng và tiêu chảy.

4. Nguy cơ rối loạn tâm thần do các yếu tố sang chấn tinh thần.

5. Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng do ăn uống kém.

6. Người nhà lo lắng về tình trạng bệnh của bé.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Ngăn ngừa biến chứng.

2. Đảm bảo hô hấp.

3. Duy trì cân bằn dịch - điện giải.

4. Đảm bảo tâm lý cho trẻ.

5. Đảm bảo dinh dưỡng.

6. Giảm lo lắng cho người nhà bé.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. NGUY CƠ TỔN THƯƠNG GAN DO NGỘ ĐỘ PARACETAMOL

Mục tiêu chăm sóc: phát hiện sớm độc tính và triển khai điều trị giải độc kịp thời.

Không gây nôn khi ngộ độc paracetamol.

Không rửa dạ dày thường quy; biện pháp khử nhiễm chỉ thực hiện khi bác sĩ chuyên môn chống độc chỉ định và bảo đảm an toàn đường thở.

Than hoạt có vai trò hạn chế, chỉ dùng theo chỉ định bác sĩ chống độc; không thực hiện tự động sau rửa dạ dày.

Thực hiện acetylcysteine kịp thời theo y lệnh; nếu dùng than hoạt, phối hợp bác sĩ xác định đường dùng và thời điểm giải độc, không trì hoãn điều trị.

Lọc máu chỉ thực hiện khi có chỉ định chuyên khoa chống độc hoặc thận; không coi suy thận cấp là chỉ định tự động để loại paracetamol.

2. NGUY CƠ HÔN MÊ, CO GIẬT,SUY HÔ HẤP DO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT ĐỘC

Mục tiêu chăm sóc: Phát hiện sớm biến chứng, đảm bảo hô hấp.

- Kiểm tra men gan và chức năng gan hàng ngày.

- Theo dõi các dấu hiệu suy gan, suy thận hoặc các biểu hiện khác như đau hạ sườn, thay đổi ý thức.

- Thường xuyên theo dõi điện giải, đông máu và các dấu hiệu lâm sàng.

- Cho bệnh nhân thở oxy (nếu cần).

- Theo dõi sát sinh hiệu: nhiệt độ nhịp thở, SpO2. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: huyết áp, mạch, SpO2 để phát hiện sớm dấu hiệu suy hô hấp.

- Giữ đường thở thông thoáng, cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 – 450C.

- Nếu bệnh nhân khó thở → báo bác sĩ ngay.

3. NGUY CƠ MẤT DỊCH, RỐI LỌAN ĐIỆN GIẢI DO NÔN ÓI, ĐAU BỤNG VÀ TIÊU CHẢY

Mục tiêu chăm sóc: Duy trì cân bằng dịch và điện giải.

- Truyền dịch theo y lệnh.

- Theo dõi lượng dịch ra – lượng dịch vào của bệnh nhân.

Ghi nước tiểu thực tế theo thời gian, mL/kg/giờ và xu hướng; đối chiếu mục tiêu theo tuổi, cân nặng và y lệnh.

- Theo dõi màu sắc, số lượng, tính chất dịch nôn và tính chất phân của trẻ.

4. NGUY CƠ RỐI LOẠN TÂM THẦN DO CÁC YẾU TỐ SANG CHẤN TINH THẦN CHO TRẺ

Mục tiêu: Điều chỉnh lại các yếu tố tâm lý cho trẻ.

Trong giai đoạn cấp, hỗ trợ nghỉ ngơi và theo dõi; vận động tăng dần khi ổn định theo đánh giá điều trị.

- Phụ huynh thường xuyên quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi vị thành niên.

- Thái độ hợp lý của gia đình khi trẻ có tâm sự nên thể hiện vừa đủ để hỗ trợ, nhưng không thái quá. không tạo áp lực cho trẻ.

5. NGUY CƠ THIẾU HỤT DINH DƯỠNG DO ĂN UỐNG KÉM

Mục tiêu: Đảm bảo dinh dưỡng.

- Thực hiện truyền dịch nếu có y lệnh.

- Nên cho trẻ ăn thức ăn mềm lỏng, dễ tiêu (cháo, sữa, súp…), ăn chậm, nhai kỹ.

- Chia thức ăn ra nhiều bữa nhỏ.

- Cho bé uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, không nên ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh.không uống nước ngọt có gas.

- Cho trè ăn theo nhu cầu.

6. NGƯỜI NHÀ LO LẮNG VỀ TÌNH TRẠNG BỆNH CỦA BÉ

Mục tiêu: Giảm lo lắng cho người nhà.

- Giải thích tình trạng bệnh với người nhà để người nhà yên tâm điều trị.

Lập kế hoạch trở lại học tập, sinh hoạt khi ổn định; đánh giá tâm lý và an toàn nếu uống thuốc có chủ ý.

- Ăn uống điều độ, chú ý không để trẻ ăn quá no hay quá đói.

- Hướng dẫn người nhà biết cách phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bé.

- Dùng thuốc đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ và tái khám đúng hẹn.

7. GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ CÁCH PHÒNG NGỪA

Không tự điều trị kéo dài hoặc dùng nhiều chế phẩm cùng chứa paracetamol; hỏi nhân viên y tế khi triệu chứng kéo dài hoặc nghi quá liều.

- Tuân thủ hướng dẫn: Chỉ sử dụng Paracetamol đúng theo liều quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

- Không tự ý thay đổi liều lượng thuốc khi chưa có ý kiến từ bác sĩ điều trị.

- Không tự ý kết hợp sử dụng từ 2 loại thuốc trở lên, để tránh quá liều hoặc tương tác thuốc, tránh kết hợp các sản phẩm chứa Paracetamol lại với nhau.

- Bảo quản thuốc nơi an toàn, giữ thuốc xa tầm tay trẻ em.

- Luôn đọc kỹ nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc.

- Không dùng Paracetamol nếu trẻ uống đồ uống có cồn.

Dùng paracetamol đúng liều, khoảng cách và tổng liều theo tuổi, cân nặng, dạng thuốc và hướng dẫn sản phẩm hoặc y lệnh.

- Giáo dục hành vi cho trẻ và cha mẹ: dạy trẻ rằng thuốc hạ sốt không phải kẹo, chỉ uống khi ốm và theo chỉ dẫn.

- Phụ huynh cần quan tâm đến phát triển tâm sinh lý của trẻ vị thành niên thường xuyên, bên cạnh không chỉ học tập mà còn sinh hoạt hằng ngày, các mối quan hệ của trẻ.

- Nhà trường nên phối hợp với các chuyên gia tâm lý học đường để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, kịp thời phát hiện các vấn đề tâm lý và hỗ trợ trẻ.

- Phụ huynh không nên quá tạo áp lực cho trẻ, cần khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, thư giãn phù hợp.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Không có triệu chứng ban đầu không loại trừ độc tính. Báo ngay giờ uống, lượng, dạng thuốc, cân nặng và kết quả; không chờ vàng da mới triển khai giải độc theo y lệnh.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Bệnh nhân tỉnh.
- Hô hấp, huyết áp ổn định.
- Cải thiện và hết các dấu hiệu ngộ độc.
- Không còn nôn,tiêu chảy, đau bụng.
- Bệnh nhân ăn uống được và dung nạp tốt.
- Không xuất hiện biến chứng.
- Bệnh nhân hiểu và tuân thủ chế độ điều trị.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [9] Royal Children’s Hospital Paracetamol poisoning, [10] Royal Children’s Hospital Poisoning initial management. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

30 Quy trình chăm sóc bệnh nhân rắn cắn

Mã đề xuất QTCS-30. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Ghi hoàn cảnh, giờ bị cắn và mô tả hoặc ảnh con rắn nếu đã có an toàn; không yêu cầu bắt, giết hoặc mang rắn sống đến bệnh viện.

Các dấu hiệu lâm sàng xuất hiện sau khi rắn cắn: đau, phù, hoại tử, xuất huyết tại chỗ; nói khó, liệt hô hấp.

Thời điểm rắn cắn.

Cách sơ cứu.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Tổng trạng: chiều cao, cân nặng.

- Dấu hiệu sinh tồn:

+ Nhiệt độ: Sốt nhẹ nhiệt độ 37,50C đến 38,50C, sốt vừa 38,50C đến 390C, sốt cao 390C đến 400C, sốt rất cao trên 400C.

+ Tình trạng hô hấp: Điếm nhịp thở, kiểu thở, xác định khó thở thanh quản, tình trạng tím tái, mức độ tăng tiết, ho, ….

Đo mạch, huyết áp và đánh giá tưới máu thực tế; tần suất theo mức độ nặng và y lệnh, tăng theo dõi ngay khi bất ổn, không áp dụng 30 phút/lần cho mọi trẻ.

- Tình trạng thần kinh: Mệt mỏi, bứt rứt, vật vả, liệt,…

- Da niêm: xuất huyết da, da niêm nhợt.

- Khám vết cắn: dấu răng, phù nề, hoại tử, xuất huyết.

Cận lâm sàng:

Công thức máu: bạch cầu, Hematocrit, tiểu cầu.

Thực hiện xét nghiệm đông máu theo y lệnh; rối loạn đông máu là dấu hiệu cần đánh giá khẩn. Bác sĩ phối hợp biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và thông tin loài để chỉ định kháng nọc, không suy đoán loại trừ một loài chỉ từ xét nghiệm.

Chức năng gan thận, điện giải đồ.

Khí máu nếu có suy hô hấp.

X-quang phổi khi có suy hô hấp để chẩn đoán phân biệt.

Tổng phân tích nước tiểu.

Bảng 1. Chẩn đoán rắn cắn dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng

Bảng 2. Phân độ nặng rắn độc cắn

Bảng tham khảo nhận diện dấu nhiễm độc, không thay kết luận của bác sĩ. Dấu có thể không điển hình hoặc xuất hiện muộn; không dùng bảng để loại trừ nguy cơ.

Loại rắn	Dấu hiệu tại chỗ	Dấu hiệu toàn thân	Xét nghiệm
Hổ đất	Đau, phù Hoại tử lan rộng	Có thể xuất hiện sớm hoặc muộn: Tê, nói, nuốt khó Sùi bọt mép Liệt cơ hô hấp	
Cạp nong Cạp nia	Đau tại chỗ Ít / Không hoại tử	Liệt cơ hô hấp có thể xuất hiện muộn	
Hổ mèo	Đau tại chỗ Hoại tử	Lừ đừ, liệt cơ hô hấp Co giật	Đông máu Myoglobin niệu
Chàm quạp	Đau Hoại tử lan rộng Chảy máu không cầm Bóng nước có máu	Bầm máu Xuất huyết DIC	Đông máu
Rắn lục	Có thể có phù, bầm máu, chảy máu tại chỗ; mức độ thay đổi	Có thể có xuất huyết toàn thân và rối loạn đông máu	Đông máu
Rắn biển	Đau ± sưng	Có thể gặp: Mệt, đau cơ, liệt cơ hô hấp, suy thận	

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bảng tham khảo nhận diện dấu nhiễm độc, không thay kết luận của bác sĩ. Dấu có thể không điển hình hoặc xuất hiện muộn; không dùng bảng để loại trừ nguy cơ.

Dấu hiệu	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Dấu hiệu tại chỗ	Phù, đỏ, bầm máu khu trú tại vết cắn	Phù, đỏ, bầm máu lan chậm	Phù, đỏ, bầm máu lan rộng nhanh
Dấu hiệu toàn thân	Không	Có (lừ đừ, dấu hiệu nhiễm độc) Cần đánh giá khẩn và theo dõi, không coi là an toàn	Dấu hiệu nguy hiểm cấp cứu (Sốc, suy hô hấp, rối loạn tri giác, yếu liệt cơ)

Dấu hiệu	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Rối loạn đông máu	Không	RLĐM nhẹ Không dấu hiệu xuất huyết toàn thân	RLĐM nặng Xuất huyết toàn thân (Ói, tiểu máu, XH não)

1. Nguy cơ suy hô hấp liên quan đến độc tố thần kinh từ nọc rắn.

2. Đau cấp tính liên quan đến tổn thương mô tại vị trí cắn.

3. Nguy cơ rối loạn đông máu/sốc liên quan đến độc tố tan máu.

4. Nguy cơ nhiễm trùng vết thương liên quan đến tổn thương da- mô mềm.

5. Lo lắng liên quan đến tình trạng bệnh cấp cứu đột ngột.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Duy trì đường thở - hô hấp – tuần hoàn.

2. Giảm đau hạn chế biến chứng hoại tử.

3. Theo dõi tiến triển và chuẩn bị cho truyền huyết thanh kháng nọc.

4. Giảm nguy cơ nhiễm trùng vết thương.

5. Hỗ trợ tâm lý.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. NGUY CƠ SUY HÔ HẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC TỐ THẦN KINH TỪ NỌC RẮN

Mục tiêu chăm sóc: Duy trì đường thở - hô hấp – tuần hoàn.

- Đặt đường truyền tĩnh mạch lớn.

- Chuẩn bị phương tiện đặt nội khí quản nếu suy hô hấp.

- Cung cấp oxy khi SpO2 < 94%.

2. ĐAU CẤP TÍNH LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG MÔ TẠI VỊ TRÍ CẮN

Mục tiêu chăm sóc: Giảm đau hạn chế biến chứng hoại tử.

- Giảm đau (paracetamol, tránh Non-Saids nếu rối loạn đông máu).

- Kháng sinh nếu có nhiễm trùng.

- Truyền dịch tùy tình trạng.

3. NGUY CƠ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU/ SỐC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘC TỐ TAN MÁU

Mục tiêu chăm sóc: Theo dõi tiến triển và phát hiện biến chứng.

- Thực hiện truyền dịch, truyền kháng nọc theo y lệnh (nếu cần).

Chuẩn bị phương tiện xử trí phản vệ và kiểm tra hướng dẫn của huyết thanh đang sử dụng với bác sĩ. WHO không khuyến cáo test da thường quy vì không dự báo đáng tin cậy phản ứng; không dùng kết quả test để xem truyền kháng nọc là an toàn.

- Theo dõi sát trong 30 phút đầu: mạch, huyết áp, mề đay, khó thở.

- Theo dõi dấu hiệu xuất huyết: chảy máu chân răng, bầm tím,...

- Xét nghiệm đông máu (PT, aPTT, fibrinogen).

- Theo dõi nước tiểu: màu nâu, ít → nghi tiêu cơ vân.

4. NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG VẾT THƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG DA - MÔ MỀM

Mục tiêu: Phát hiện sớm biến chứng.

- Rửa bằng Nacl 0,9% sát khuẩn povidone.

- Không cắt lọc sớm nếu chưa có chỉ định.

- Theo dõi sưng nề mỗi 30 – 60 phút, đo chu vi chi.

- Thay băng hằng ngày hoặc khi cần.

5. LO LẮNG LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG CẤP CỨU ĐỘT NGỘT

Mục tiêu: Phát hiện sớm biến chứng.

- Giải thích tình trạng bệnh, quy trình điều trị.

- Hướng dẫn gia đình hỗ trợ tinh thần.

6. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Sơ cứu rắn cắn: giữ bình tĩnh, bất động người bệnh và chi bị cắn, tháo trang sức, chuyển viện ngay. Không garô, chích rạch, hút nọc, đắp lá hoặc chườm đá. Băng ép bất động chỉ cân nhắc khi phù hợp loại nọc chủ yếu gây độc thần kinh, không gây tổn thương tại chỗ, do người được đào tạo thực hiện; không áp dụng mặc định khi chưa biết loài.

Những điều nên làm:

1. Giữ bình tĩnh và trấn an: trấn an bệnh nhân, hạn chế cử động để làm chậm nọc độc lan truyền

2. Bất động chi: dùng nẹp cố định chi bị cắn, đặt thấp hơn tim.

3. Rửa vết cắn: Rửa nhẹ nhàng bằng xà phòng và nước sạch.

4. Băng ép: dùng băng thun băng chặt từ dưới lên trên chi bị cắn. Trừ rắn lục không được băng ép.

5. Tháo trang sức.

6. Vận chuyển: Đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, mô tả đặc điểm con rắn nếu có thể.

Những điều không nên làm:

1. Không rạch/ hút: tuyệt đối không rạch, nặn, chích hay dùng miệng hút nọc độc.

2. Không đắp lá/ thuốc: không đắp bất kỳ loại lá cây, thuốc nào lên vết thường.

4. Không dùng chất kích thích.

5. Không mất thời gian: không chờ đợi hay tìm thầy lang, hãy đến bệnh viện ngay.

Tại sao cần xử trí đúng:

1. Bỏ lỡ "giờ vàng" có thể gây hoại tử, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

2. Việc xử lý sai có thể khiến nọc độc lan nhanh hơn, làm tình trạng bệnh nhân nặng thêm.

Lưu ý: Bất kỳ trường hợp bị rắn cắn nào cũng cần được theo dõi và điều trị tại bệnh viện để được tiêm phòng uốn ván và sử dụng huyết thanh kháng nọc.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó nuốt, yếu cơ, khó thở, chảy máu, phù lan nhanh, tụt huyết áp hoặc thiểu niệu: gọi cấp cứu, chuẩn bị hỗ trợ hô hấp và kháng nọc theo chỉ định; theo dõi phản vệ khi truyền.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung "chăm sóc tốt". Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- SpO2 duy trì > 94%, không khó thở, không yếu liệt tiến triển.

- Đau giảm ≤ 3/10.

- Sưng nề không lan hoặc giảm dần.

- Không có chảy máu bất thường, xét nghiệm đông máu cải thiện.

- Vết thương sạch, khô, không mủ.

- Người bệnh bình tĩnh, hiểu bệnh và hợp tác điều trị.

- Mục tiêu chăm sóc đạt được.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [11] WHO Guidelines for the management of

snakebites second edition 2016, [12] WHO Snakebite envenoming questions and answers. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

31 Quy trình chăm sóc bệnh nhân viêm tụy

Mã đề xuất QTCS-31. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Đau bụng: đau thường xảy ra bất ngờ, đau tăng dần và có thể đau dữ dội vài giờ sau, thường khu trú vùng thượng vị, quanh rốn, ¼ bụng trên phải, đau có thể lan ra sau lưng, đau tăng lên sau khi ăn. Tư thế giảm đau: nằm nghiêng, mông và gối gập vào bụng hoặc ngồi thẳng lưng.

Ói: xảy ra trong đa số các trường hợp (70%) và ói vẫn không làm giảm đau, nếu không tìm được nguyên nhân gây ói cần nghĩ đến viêm tuỵ.

Cần chú ý đến những bệnh lý, thuốc đang dung có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm tuỵ cấp.

2. KHÁM CÁC HỆ THỐNG CƠ THỂ

- Tổng trạng: chiều cao, cân nặng.

- Dấu hiệu sinh tồn:

+ Nhiệt độ: Sốt nhẹ nhiệt độ 37,50C đến 38,50C, sốt vừa 38,50C đến 390C, sốt cao 390C đến 400C, sốt rất cao trên 400C.

+ Tình trạng hô hấp: Điếm nhịp thở, kiểu thở, xác định khó thở thanh quản, tình trạng tím tái, mức độ tăng tiết, ho, ….

Đo mạch, huyết áp và đánh giá tưới máu thực tế; tần suất theo mức độ nặng và y lệnh, tăng theo dõi ngay khi bất ổn, không áp dụng 30 phút/lần cho mọi trẻ.

- Ấn đau vùng thượng vị, có thể lan ra sau lưng.

- Nhu động ruột giảm hoặc liệt ruột.

- Vàng da nhẹ có thể xảy ra trong viêm tuỵ tự phát, nhưng vàng da nặng hoặc trung bình gợi ý viêm tuỵ do sỏi túi mật.

- Tìm dấu hiệu viêm tuỵ cấp nặng:

+ Vẻ mặt nhiễm độc, nhiễm khuẩn.

+ Dấu mất nước.

+ Dấu hiệu sốc.

+ Suy hô hấp.

+ Da nổi màu xanh tím vùng quanh rốn (dấu Cullen) hoặc da nổi màu xanh tím vùng hông (dấu Grey Turner) trong viêm tuỵ thể xuất huyết.

+ Tràn dịch màng phổi.

Cận lâm sàng:

- Công thức máu: Hct tăng, có thể giảm do xuất huyết, bạch cầu tăng.

- Amylase máu: thường tăng trên 3 lần trị số bình thường tối đa và tồn tại trong 3-5 ngày, tuy nhiên mức độ tăng có thể không tương ứng với mức độ nặng của bệnh. Khoảng 10-15% trường hợp viêm tuỵ cấp có thể bình thường lúc khởi đầu.

- Amylase nước tiểu tăng và tồn tại hơn 2 tuần, có giá trị khi amylase máu tăng chưa đến 3 lần.

- Lipase máu tăng gấp 3 lần bình thường có độ đặc hiệu hơn amylase máu, nên đo lipase máu trong trường hợp nghi ngờ viêm tuỵ mà amylase máu bình thường. Lipase máu tăng từ giờ thứ 6 khi bắt đầu triệu chứng, đạt đỉnh vào giờ thứ 24-30 và tăng kéo dài hơn 1 tuần.

- Ion đồ, đường huyết, Triglycerid, LDH, ure, creatinine, chức năng gan.

- Khí máu trong trường hợp bệnh nặng.

- Siêu âm bụng: có vai trò lớn trong chẩn đoán và theo dõi bệnh. Siêu âm có thể thấy tuyến tuỵ lớn, phù nề, bờ không rõ, giảm mật độ echo, có thể có dịch hoặc áp-xe. Khoảng 20% trường hợp viêm tuỵ cấp có thể bình thường dưới siêu âm lúc khởi đầu.

- Cấy máu: Khi nghi ngờ nhiễm trùng hoặc có hoại tử tuỵ.

- Các xét nghiệm tìm nguyên nhân khác.

- X-quang bụng không chuẩn bị: khi cần loại trừ tắc ruột, thủng ruột.

- CT scanner: trong trường hợp có chấn thương bụng hoặc để đánh giá độ nặng, biến chứng.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Đau bụng cấp liên quan đến viêm tụy.

2. Nguy cơ mất dịch – rối loạn điện giải do nôn và viêm.

3. Nguy cơ nhiễm trùng (nếu hoại tử tụy, đặt catheter, nằm kéo dài).

4. Nguy cơ thiếu dinh dưỡng liên quan giảm dung nạp đường tiêu hóa.

5. Nguy cơ suy hô hấp (trong viêm tụy nặng).

6. Lo lắng liên quan đến tình trạng bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Giảm đau cho bệnh nhân.

2. Duy trì cân bằng dịch - điện giải.

3. Ngăn ngừa biến chứng (nhiễm trùng, suy hô hấp, sốc).

4. Cải thiện dinh dưỡng và chức năng tiêu hóa.

5. Bảo đảm bệnh nhân hiểu và tuân thủ điều trị.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. ĐAU BỤNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM TỤY

Mục tiêu chăm sóc: Giảm đau cho bệnh nhân.

- Đánh giá đau theo thang điểm (NRS 0 – 10) mỗi 2 – 4 giờ.

- Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh.

- Hướng dẫn tư giảm đau: hơi ngồi gập người.

2. NGUY CƠ MẤT DỊCH – RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI DO NÔN VÀ VIÊM

Mục tiêu chăm sóc: Duy trì cân bằng dịch – điện giải.

- Theo dõi lượng dịch ra – lượng dịch vào của bệnh nhân.

Ghi lượng nước tiểu theo giờ và mL/kg/giờ, đối chiếu tuổi và mục tiêu điều trị; báo giảm tưới máu hoặc thiểu niệu.

- Kịp thời báo bác sĩ khi giảm nước tiểu, phù, rối loạn nhịp tim.

3. NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG

Mục tiêu chăm sóc: Theo dõi tiến triển và phát hiện biến chứng.

- Quan sát dấu hiệu nhiễm trùng: sốt, rét run, bạch cầu tăng.

- Theo dõi chướng bụng, phân, dấu hiệu liệt ruột.

- Theo dõi dấu hiệu suy thận: thiểu niệu, creatinin tăng.

- Vận động sớm khi bệnh ổn để giảm nguy cơ huyết khối.

4. HỖ TRỢ DINH DƯỠNG PHÙ HỢP DUNG NẠP

Mục tiêu: Cải thiện dinh dưỡng và chức năng tiêu hóa.

Phối hợp bác sĩ cho ăn đường miệng hoặc đường ruột sớm khi ổn định và không có chống chỉ định; chỉ nhịn ăn khi có lý do lâm sàng cụ thể, theo dõi và đánh giá lại.

- Truyền dịch tĩnh mạch: theo dõi tốc độ, vị trí đặt, nguy cơ phù.

- Thoe dõi nôn ói.

- Khi cho ăn lại:

+ Bắt đầu bằng cháo loãng – súp – ít mỡ.

+ Chia nhỏ bữa ăn (5 – 6 bữa).

+ Theo dõi dung nạp ăn.

5. NGUY CƠ SUY HÔ HẤP

Mục tiêu: Phát hiện sớm biến chứng.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: huyết áp, mạch, SpO2 để phát hiện sốc hoặc suy hô hấp.

- Giữ đường thở thông thoáng, cho bệnh nhân nằm đầu cao 30 – 450C.

- Nếu bệnh nhân khó thở → báo bác sĩ ngay.

6. LO LẮNG LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG BỆNH

Mục tiêu: Đảm bảo bệnh nhân hiểu và tuân thủ điều trị.

- Trấn an bệnh nhân, giải thích tiến trình bệnh – hướng điều trị.

- Dặn bệnh nhân:

+ Tránh thức ăn nhiều dầu mỡ.

+ Uống đủ nước khi được phép ăn uống.

+ Theo dõi đau, sốt, khó thở.

7. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn chế độ ăn:

Nên ăn:

1. Protein nạc: thịt gà, cá, trứng, đậu,…

2. Rau củ và trái cây: rau xanh, việt quất, dưa chuột, cà chua bi,…

3. Ngũ cốc nguyên hạt: tốt cho tiêu hóa.

4. Sữa và sản phẩm từ sữa: sữa ít béo, sữa hạt (hạnh nhân, đậu nành).

5. Thực phẩm dễ tiêu hóa: cháo trắng, súp, thức ăn mềm, ít gia vị.

Nên tránh:

1. Chất béo: đồ chiên rán, mỡ động vật, thực phẩm nhiều dầu mỡ.

2. Rượu và thuốc lá: tuyệt đối kiêng.

3. Đồ ngọt và đường đơn: kẹo, đồ uống nhiều calo (làm tăng triglyceride).

4. Thực phẩm có tính axit: trái cây chua.

5. Thịt đỏ: hạn chế tối đa.

Thay đổi lối sống, sinh hoạt:

1. Uống đủ nước: giúp hỗ trợ tiêu hóa.

2. Ăn ít và chia nhỏ bữa: giúp tuyến tụy dễ hấp thu hơn.

3. Tập thể dục: duy trì 3 – 4 lần/ tuần, mỗi lần 45 – 60 phút.

4. Theo dõi tăng trưởng bằng cân nặng, chiều cao và biểu đồ theo tuổi, giới; không dùng ngưỡng BMI người lớn cho trẻ.

5. Quản lý bệnh nền: kiểm soát tốt đái tháo đường, mỡ máu.

6. Nghỉ ngơi: giai đoạn đầu cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh căng thẳng, thức khuya.

7. Khám định kỳ: 3 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, bụng chướng, nôn dai dẳng, giảm tưới máu hoặc giảm nước tiểu: báo bác sĩ, đánh giá dịch và biến chứng; kế hoạch ăn được đánh giá lại theo dung nạp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

- Mức độ đau giảm.

- Dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- Không còn nôn, bụng mềm hơn.

Cân bằng dịch và lượng nước tiểu đáp ứng mục tiêu theo tuổi, cân nặng và tình trạng bệnh.

- Bệnh nhân ăn uống được và dung nạp tốt.

- Không xuất hiện biến chứng.

- Bệnh nhân hiểu và tuân thủ chế độ điều trị.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [13] NASPGHAN Management of acute pancreatitis in the pediatric population clinical report 2018. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Chăm sóc các bệnh tiêu hóa

32 Quy trình chăm sóc bệnh nhiễm trùng đường mật

Mã đề xuất QTCS-32. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? Đau có lan không?

Bệnh nhân có sốt không? Tính chất, tần suất cơn sốt? Nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Có vàng da, vàng mắt không? Xuất hiện từ khi nào?

Có rối loạn về đại tiện không (Tiêu chảy, táo bón) tính chất, số lượng, màu sắc phân?

Có nôn, buồn nôn không? Số lần nôn và chất nôn?

Bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh lý gây tắc nghẽn đường mật như: sỏi mật, giun chui ống mật..

Bệnh nhân có triệu chứng rối loạn tri giác, chậm chạp, lú lẫn không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Quan sát da niêm, tri giác.

Đánh giá tính chất cơn đau, tình trạng đại tiểu tiện của bệnh nhân.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: Siêu âm, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân đau bụng (đau hạ sườn phải) do nhiễm trùng đường mật.

Tăng thân nhiệt do nhiễm trùng.

Da niêm vàng do tình trạng tắc nghẽn đường mật.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: Sốc nhiễm khuẩn (mạch nhanh, huyết áp tụt, rối loạn ý thức), suy đa cơ quan,…

Dinh dưỡng kém do thay đổi thói quen ăn uống, đường tiêu hóa kém hấp thu.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm tình trạng đau bụng cho bệnh nhân.

Hạ sốt cho bệnh nhân.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU BỤNG CHO BỆNH NHÂN

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi với tức thể giảm đau thích hợp.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Động viên, an ủi, công tác tư tưởng giúp bệnh nhân giảm đau.

Lượng giá vị trí, tính chất cơn đau.

HẠ SỐT CHO BỆNH NHÂN

Theo dõi nhiệt độ và mức khó chịu, giữ quần áo và phòng phù hợp; dùng thuốc hạ sốt theo y lệnh, không lau mát tích cực thường quy.

Thực hiện y lệnh thuốc hạ sốt, dặn người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

Cho người bệnh nằm phòng thoáng mát.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng, thể trạng xấu hơn (sốt cao, tụt HA, đau bụng tăng dần, bụng chướng do sốc nhiễm khuẩn, viêm màng bụng).

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tri giác.

Theo dõi tình trạng đau bụng.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Hướng dẫn người bệnh ăn nhẹ, dễ tiêu (súp, nước hoa quả,..)

Thức ăn đủ dinh dưỡng, đủ calo nhiều glucid, protid và vitamin, ít mỡ.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá.

Lượng dịch ăn, uống và truyền được cá thể hóa theo mất dịch, chức năng tim thận và y lệnh; ghi cân bằng vào ra.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: đau bụng, sốt, màu sắc da niêm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Hướng dẫn bệnh nhân chế đô ăn uống hợp lý, tránh stress, căng thẳng.

Tránh làm việc quá sức.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sốt kèm vàng da, đau bụng, tụt huyết áp hoặc tri giác thay đổi: báo bác sĩ khẩn, chuẩn bị hồi sức và kiểm soát nguồn nhiễm theo chỉ định.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Các triệu chứng đau bụng, sốt, vàng da, rối loạn tiêu hoá thuyên giảm dần.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

33 Quy trình chăm sóc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Mã đề xuất QTCS-33. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Thói quen ăn uống như thế nào? Có hay bị đầy hơi, chậm tiêu?

Gần đây có cảm giác mệt mỏi, uể oải, tay chân yếu sức không?

Có uống rượu bia không?

Gần đây có tăng cân không?

Người bệnh có mắc các bệnh mãn tính (thừa cân, đái tháo đường, tăng mỡ máu) trước đó không? Có đang uống thuốc gì không (amiodarone, corticosteroids,…)?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tổng trạng.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: siêu âm, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân khó chịu, uể oải do tình trạng bệnh.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: tăng men gan, xơ gan.

Dinh dưỡng kém do thay đổi thói quen ăn uống.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm mệt mỏi, khó chịu cho bệnh nhân.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Thay đổi lối sống, giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM MỆT MỎI, KHÓ CHỊU CHO BỆNH NHÂN

Hướng dẫn bệnh nhân nghỉ ngơi.

Cho bệnh ăn chế độ ăn hợp lý: ăn mềm, dễ tiêu, cữ dầu mỡ chua cay.

Nghỉ ngơi phòng thoáng mát, sạch sẽ.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn.

Theo dõi kết quả siêu âm định kỳ, tình trang mệt mỏi, đau bụng, chán ăn, buồn nôn, chướng bụng,...

Theo dõi cân nặng.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học.

Ưu tiên thực phẩm ít dầu mỡ, ít đường, nhiều rau xanh và hoa quả, đồng thời hạn chế rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn giảm 25% lượng calo hàng ngày (người bình thường trung bình khoảng 2500 calo/ ngày), tránh sử dụng acid béo đa và đường fructose có trong thức ăn nhanh và nước giải khát, tăng lượng acid báo không bão hoà có Omega 3, Omega 6.

THAY ĐỔI LỐI SỐNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Giảm cân nặng bằng chế độ ăn giảm calo kết hợp tăng cường hoạt động thể lực có thể làm giảm men gan và cải thiện tình trạng nhiễm mỡ gan trên siêu âm.

Tập thể dục mức độ trung bình, 3 – 4 lần/tuần, đạt được tăng nhịp tim khoảng 60 – 75% mức tối đa theo tuổi.

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Hướng dẫn bệnh nhân ché đô ăn uống hợp lý, tránh stress, căng thẳng.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Vàng da mới, nôn máu, bụng tăng nhanh hoặc tri giác thay đổi: báo bác sĩ; phối hợp dinh dưỡng và quản lý chuyển hóa theo tình trạng, không tự dùng thuốc hoặc thảo dược bổ gan.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Đánh giá lại hiệu quả của thay đổi lối sống sau 6 tháng, nếu vẫn chưa đạt hiệu quả, có thể áp dụng thêm các biện pháp khác như dùng thuốc.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm, siêu âm, X-quang, đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

34 Quy trình chăm sóc bệnh áp xe gan do vi khuẩn (icd: k75.0)

Mã đề xuất QTCS-34. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? Đau có lan không?

Bệnh nhân có sốt không? Tính chất, tần suất cơn sốt? Nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? Có rét run không?

Có vàng da, vàng mắt không? Xuất hiện từ khi nào?

Có rối loạn về đại tiện không? Có mệt mỏi chán ăn không?

Bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến đường mật, có các bệnh lý mãn tính không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tính chất cơn đau, tình trạng đại tiểu tiện của bệnh nhân.

Đánh giá màu sắc da niêm.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: Siêu âm, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân đau bụng do ổ áp xe gan.

Tăng thân nhiệt do nhiễm trùng từ ổ áp xe gan.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: Sốc nhiễm khuẩn (mạch nhanh, huyết áp tụt, rối loạn ý thức), suy đa cơ quan,…

Dinh dưỡng kém do thay đổi thói quen ăn uống, đường tiêu hóa kém hấp thu.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm tình trạng đau bụng cho bệnh nhân.

Hạ sốt cho bệnh nhân.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU BỤNG CHO BỆNH NHÂN

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi với tức thể giảm đau thích hợp.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Động viên, an ủi, công tác tư tưởng giúp bệnh nhân giảm đau.

Lượng giá vị trí, tính chất cơn đau.

HẠ SỐT CHO BỆNH NHÂN

Theo dõi nhiệt độ và mức khó chịu, giữ quần áo và phòng phù hợp; dùng thuốc hạ sốt theo y lệnh, không lau mát tích cực thường quy.

Thực hiện y lệnh thuốc hạ sốt, dặn người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

Cho người bệnh nằm phòng thoáng mát.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng, thể trạng xấu hơn (sốt cao, tụt HA, đau bụng tăng dần, bụng chướng do sốc nhiễm khuẩn, viêm màng bụng).

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tri giác.

Theo dõi tình trạng đau bụng.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Hướng dẫn người bệnh ăn nhẹ, dễ tiêu (súp, nước hoa quả,..).

Thức ăn đủ dinh dưỡng, đủ calo nhiều glucid, protid và vitamin, ít mỡ.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá.

Cá thể hóa lượng dịch theo mất dịch, khả năng uống, tim thận và y lệnh, không quy định 1,5–2,5 lít cho mọi người bệnh.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: đau bụng, sốt, màu sắc da niêm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Hướng dẫn bệnh nhân ché đô ăn uống hợp lý, tránh stress, căng thẳng.

Tránh làm việc quá sức.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sốt rét run, đau tăng, tụt huyết áp hoặc đau lan, bụng cứng: báo bác sĩ, chuẩn bị kháng sinh và can thiệp kiểm soát nguồn nhiễm theo chỉ định.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Các triệu chứng đau bụng, sốt, vàng da,rối loạn tiêu hoá thuyên giảm dần.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

35 Quy trình chăm sóc bệnh sỏi mật (icd 10: k80, k80.1, k80.2, k80.3, k80.4, k80.5, k80.8)

Mã đề xuất QTCS-35. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? Đau có lan không?

Bệnh nhân có nôn ói hoặc buồn nôn không? Có chán ăn không?

Có vàng da, vàng mắt không? Xuất hiện từ khi nào?

Bệnh nhân có sốt không? Tính chất, tần suất cơn sốt? Nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? Có rét run không?

Bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến đường mật, có các bệnh lý mãn tính không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tính chất cơn đau, vị trí và tần suất cơn đau.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa.

Đánh giá màu sắc da niêm.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: Siêu âm, xét nghiệm, CT-Scan.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân đau bụng do tình trạng viêm và tắc nghẽn đường mật.

Giảm thể tích dịch do nôn ói.

Tăng thân nhiệt, choáng do nhiễm trùng.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: Sốc nhiễm khuẩn, viêm túi mật hoại tử, thấm mật phúc mạc, áp xe dưới cơ hoành, rò mật tiêu hóa,…

Chán ăn, dinh dưỡng kém do giảm dịch mật xuống ruột.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm tình trạng đau bụng cho bệnh nhân.

Giảm nôn ói.

Hạ sốt.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU BỤNG CHO BỆNH NHÂN

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi với tức thể giảm đau thích hợp.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Động viên, an ủi, công tác tư tưởng giúp bệnh nhân giảm đau.

Lượng giá vị trí, tính chất cơn đau.

GIẢM NÔN ÓI CHO BỆNH NHÂN

Đánh giá tình trạng mất nước, DHST.

Theo dõi lượng nước xuất nhập, điện giải đồ.

Thực hiện thuốc, bù nước và điện giải theo y lệnh.

HẠ SỐT CHO BỆNH NHÂN

Theo dõi nhiệt độ và mức khó chịu, giữ quần áo và phòng phù hợp; dùng thuốc hạ sốt theo y lệnh, không lau mát tích cực thường quy.

Thực hiện y lệnh thuốc hạ sốt, dặn người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn, duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.

Cho người bệnh nằm phòng thoáng mát.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng, thể trạng xấu hơn, sốc nhiễm khuẩn.

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tri giác.

Theo dõi tình trạng đau bụng, đau bụng tăng dần, đau không thuyên giảm.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Hướng dẫn người bệnh ăn nhẹ, dễ tiêu, kiêng mỡ, uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận.

Tuân thủ chế độ ăn giảm mỡ động vật, tăng cường dầu thực vật, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: đau bụng, sốt, màu sắc da niêm.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Hướng dẫn bệnh nhân ché đô ăn uống hợp lý.

Tránh làm việc quá sức.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau kéo dài hoặc tăng, sốt, vàng da, nôn nhiều: báo bác sĩ để đánh giá tắc mật, nhiễm trùng hoặc viêm tụy.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Các triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hoá, sốt thuyên giảm dần.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

36 Quy trình chăm sóc bệnh táo bón (icd: k59.0)

Mã đề xuất QTCS-36. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? đau có lan không?

Có rối loạn về đại tiện không? Số lần đi tiêu, tần suất như thế nào? Tính chất phân như thế nào?

Thói quen ăn uống, chế độ ăn hằng ngày như thế nào? Uống bao nhiêu lít nước/ngày? Khẩu phần ăn có chưa chất xơ không?

Đầy hơi, chướng bụng không? Sau mỗi lần đi tiêu có chảy máu hậu môn không?

Bệnh nhân có đang mắc các bệnh mãn tính, ung thư không? Có đang sử dụng thuốc gì gân đây không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

Có thường hay stress?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tình trang chướng bụng, đi tiêu, tính chất phân, tần suất đi tiêu.

Quan sát tính chất cơn đau.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: Nội soi đai trực tràng, siêu âm, X-quang, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Táo bón thói quen sinh hoạt, chế độ ăn hăng ngày.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: tắc ruột, trĩ, nứt hậu môn,…

Dinh dưỡng kém do thay đổi thói quen ăn uống, đường tiêu hóa kém hấp thu.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiế kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm táo bón.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM TÁO BÓN

Hướng dẫn bệnh nhân vận động nhẹ nhàng tại giường, tránh nằm lâu.

Sử dụng thuốc nhuận tràng theo y lệnh.

Cho bệnh ăn chế độ ăn hợp lý: uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, chế độ ăn nhiều chất xơ, trái cây, thức ăn dễ tiêu.

Dặn người bệnh đi đại tiện ngay, tránh để lâu, tập đi tiêu đúng giờ, đều đặn.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.

Theo dõi tình trạng đau bụng, chướng bụng, bí trung đai tiện.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn.

Theo dõi tình trạng đại tiện của bệnh nhân.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG- THAY ĐỔI THÓI QUEN ĂN UỐNG

Uống đủ theo nhu cầu và chỉ định, tăng chất xơ phù hợp; điều chỉnh khi có hạn chế dịch do bệnh tim, thận.

Tăng cường chất xơ vào khẩu phần ăn hằng ngày, các trái cây như chuối, đu đu, thanh long, các loại rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá…

Giảm các loại thịt mỡ, sữa, phô mai và thực phẩm chế biến sẵn.

Đảm bảo vệ sinh trong chế biến thức ăn, không ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn sống.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, táo bón…

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Hướng dẫn bệnh nhân ché đô ăn uống hợp lý, tránh stress, căng thẳng.

Tránh làm việc quá sức.

Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Không nhịn đại tiện, tập đi vệ sinh đúng giờ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, bụng chướng, bí trung đại tiện, nôn hoặc phân máu: báo bác sĩ; không tự dùng thuốc nhuận tràng hay thụt tháo khi nghi tắc hoặc thủng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Cải thiện được tình trạng táo bón.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

37 Quy trình chăm sóc bệnh viêm dạ dày ruột và đại tràng không do nhiễm trùng (icd 10: k52, k52.8, k52.9)

Mã đề xuất QTCS-37. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? Đau có lan không?

Bệnh nhân có đột ngột tiêu phân lỏng không (có hoặc không có máu và chất nhầy)? Tần suất như thế nào?

Bệnh nhân có rối loạn tiêu hoá (biếng ăn, buồn nôn, nôn ói) không?

Bệnh nhân có uống nước háo hức không?

Bệnh nhân có sốt không? Tính chất và tần suất cơn sốt như thế nào?

Bệnh nhân có mắc các bệnh mãn tính không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tình trang chướng bụng, đi tiêu, tính chất phân, tần suất đi tiêu.

Quan sát tính chất cơn đau.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: siêu âm, X-quang, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Tiêu phân lỏng nhiều lần.

Đau quặn bụng do tăng nhu động ruột.

Dinh dưỡng kém đáp ứng do nôn ói và buồn nôn nhiều.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: sốc giảm thể tích, trụy mạch, suy thận thiểu niệu.

Người nhà và bệnh nhân lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm tiêu lỏng và giảm đau bụng.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM TRIỆU CHỨNG TIÊU PHÂN LỎNG VÀ ĐAU QUẶN BỤNG

Ghi số lần và tính chất phân, đánh giá mất nước; bù nước và điện giải bằng dung dịch phù hợp theo chỉ định, không thay bằng nước ngọt hoặc nước ép.

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi với tức thể giảm đau thích hợp.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Động viên, an ủi, công tác tư tưởng giúp bệnh nhân giảm đau.

Lượng giá vị trí, tính chất cơn đau.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.

Theo dõi tình trạng, số lần đi tiêu lỏng, theo dõi và đánh giá kịp thời dấu hiệu mất nước.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn.

Theo dõi tình trạng đại tiện của bệnh nhân.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Bù dịch theo mức mất nước và chỉ định, dùng dung dịch bù nước đúng hướng dẫn khi phù hợp; không áp dụng mức tối thiểu 2 lít cho mọi người bệnh.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá..

Giảm các loại thịt mỡ, sữa, phô mai và thực phẩm chế biến sẵn.

Đảm bảo vệ sinh trong chế biến thức ăn, không ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn sống.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: tiêu lỏng nhiều, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, rối loạn ý thức.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Không uống được, mất nước, đau khu trú hoặc tăng, phân máu, tụt huyết áp: báo bác sĩ; theo dõi lại nguyên nhân và dịch điện giải.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Số lần tiêu lỏng, đau và tình trạng mất nước cải thiện; đánh giá theo nguyên nhân không nhiễm trùng đã xác định.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

38 Quy trình chăm sóc bệnh viêm dạ dày ruột và đại tràng do nhiễm trùng (icd 10: a09, a09.0)

Mã đề xuất QTCS-38. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có đột ngột tiêu phân lỏng không (có hoặc không có máu và chất nhầy)? Tần suất như thế nào?

Bệnh nhân có đau bụng không? Vị trí và tính chất đau? đau có lan không?

Bệnh nhân có rối loạn tiêu hoá (biếng ăn, buồn nôn, nôn ói) không?

Bệnh nhân có uống nước háo hức không?

Bệnh nhân có sốt không? Tính chất và tần suất cơn sốt như thế nào?

Bệnh nhân có mắc các bệnh mãn tính không?

Bệnh nhân có các triệu chứng trên từ khi nào?

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đánh giá tình trang chướng bụng, đi tiêu, tính chất phân, tần suất đi tiêu.

Khám và đánh giá dấu hiệu mất nước.

Quan sát tính chất cơn đau.

Đo dấu hiệu sinh tồn.

Xem xét kết quả cận lâm sàng: siêu âm, X-quang, xét nghiệm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Tiêu phân lỏng nhiều lần do nhiễm trùng.

Đau quặn bụng do tăng nhu động ruột.

Dinh dưỡng kém đáp ứng do nôn ói và buồn nôn nhiều.

Nguy cơ xảy ra các biến chứng: Sốc giảm thể tích. Rối loạn điện giải: hạ kali, tăng natri máu, Suy thận cấp, hoại tử ống thận, xuất huyết tiêu hóa. Rối loạn hấp thu, suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn huyết.

Người nhà và người bệnh lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm tiêu lỏng và giảm đau bụng.

Ngăn ngừa và phát hiện sớm biến chứng.

Đảm bảo đủ chế độ dinh dưỡng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM TRIỆU CHỨNG TIÊU PHÂN LỎNG VÀ ĐAU QUẶN BỤNG

Theo dõi số lần và tính chất phân, dặn bệnh nhân uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, bổ sung điện giải.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm triệu chứng.

Cho người bệnh nằm nghỉ ngơi với tức thể giảm đau thích hợp.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Động viên, an ủi, công tác tư tưởng giúp bệnh nhân giảm đau.

Lượng giá vị trí, tính chất cơn đau.

NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN SỚM BIẾN CHỨNG

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu nặng.

Theo dõi tình trạng , số lần đi tiêu lỏng, theo dõi và đánh giá kịp thời dấu hiệu mất nước.

Theo dõi tri giác, dấu hiệu sinh tồn.

Theo dõi tình trạng đại tiện của bệnh nhân.

ĐẢM BẢO ĐỦ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG

Bù nước điện giải theo chỉ định và tình trạng mất nước; không áp dụng tối thiểu 2 lít hoặc nước hoa quả cho mọi người bệnh.

Ăn hạn chế dầu mỡ, chua cay. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá…

Giảm các loại thịt mỡ, sữa, phô mai và thực phẩm chế biến sẵn.

Đảm bảo vệ sinh trong chế biến thức ăn, không ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn sống.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cung cấp cho bệnh nhân một số kiến thức về bệnh.

Hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh: tiêu lỏng nhiều, đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, rối loạn ý thức.

Hướng dẫn cho bệnh nhân phát hiện sớm các biến chứng.

Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm:

Ăn chín - uống nước đã đun sôi.

Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Cải thiện hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

Điều trị dự phòng khi ở trong vùng có dịch.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Mất nước, li bì, phân máu, sốt kèm giảm tưới máu: báo bác sĩ; phòng ngừa lây nhiễm phù hợp tác nhân và bù dịch theo chỉ định.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cần đánh giá các vấn đề sau:

Cải thiện được tình trạng nhiễm trùng.

Các y lệnh về điều trị, chăm sóc được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, tránh các tác nhân gây bệnh.

Người nhà hiểu và thực hiện tốt các hướng dẫn chăm sóc, biết các phòng bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Chăm sóc sản phụ khoa

39 Chăm sóc thai phụ trong trường hợp đẻ khó

Mã đề xuất QTCS-39. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại khoa hiện có của thai phụ.

Tiền sử thai phụ có đẻ khó không?

Nhận định tình trạng dinh dưỡng, nghỉ ngơi.

Quan sát tổng trạng chung: màu sắc da, niêm mạc.

Dáng vóc, khung chậu của thai phụ.

2. KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Các khối u tiền đạo, tình trạng chít hẹp âm đạo có không?

Ước lượng trọng lượng thai qua khám ngoài hoặc qua siêu âm (nếu có).

Đánh giá xem thai có cấu trúc bất thường không?

Số lượng thai.

Nhận định ngôi thế, kiểu thế và sự tiến triển của ngôi thai.

Nhận định sự tiến triển về độ lọt của ngôi thai.

Nhận định sự tiến triển về độ mở cổ tử cung.

Nhận định tình trạng rau tiền đạo nếu có.

Đánh giá tính chất của dây rốn: Dài hay ngắn, có rốn quấn cổ hay không?

Đánh giá tiếng tim thai.

Đánh giá sự thay đổi của màu sắc và nước ối.

Đánh giá cường độ và trương lực của cơn co tử cung.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau do cơn go mạnh và dữ dội.

Chăm sóc cá nhân kém do nằm suốt quá trình sinh đẻ.

Mệt mỏi do kiệt sức lúc sinh đẻ.

Khó ngủ do lo lắng về quá trình sinh đẻ.

Sốt do nhiễm trùng ối.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

- Trước một trường hợp đẻ khó, người điều dưỡng cần phải lập kế hoạch chăm sóc những vấn đề sau.

1. CHĂM SÓC CƠ BẢN

Chăm sóc về chế độ nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng của thai phụ.

Vấn đề vệ sinh.

2. THỰC HIỆN Y LỆNH

Thực hiện các loại thuốc được chỉ định.

Thực hiện đầy đủ các y lệnh bổ sung cho chẩn đoán.

3. LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI

Tình trạng sức khỏe và bệnh lý của thai phụ.

Quan sát toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn của thai.

Tình trạng của thai: đánh giá qua nhịp tim thai, monitor.

Ngôi thai và độ lọt của ngôi thai.

Sự tiến triển của cổ tử cung.

Cơn co tử cung.

Đầu ối và màu sắc nước ối.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CHĂM SÓC CƠ BẢN

Cần động viên tinh thần cho thai phụ giúp thai phụ hiểu được đau bụng đẻ là như thế nào, để thai phụ biết và hợp tác với hộ sinh.

Hướng dẫn chế độ ăn uống: ăn loãng, những thức ăn dễ tiêu hóa, những trường hợp đẻ khó có thể phải mổ lấy thai do vậy hướng dẫn bệnh nhân không nên ăn.

Hướng dẫn vệ sinh bộ phận ngoài mỗi khi đi tiêu tiểu.

2. THỰC HIỆN Y LỆNH

Thực hiện đầy đủ theo y lệnh các loại thuốc thai phụ cần dùng đúng giờ, đúng liều lượng.

Có thể lập 01 đường truyền tĩnh mạch.

Thực hiện nhanh chống đầy đủ các cận lâm sàng, monitoring 30 phút.

3. TRẤN AN THAI PHỤ

Theo dõi đánh giá tình trạng sức khỏe và bệnh lý của thai phụ: quan sát vẻ mặt, tinh thần, lấy dấu hiệu sinh tồn và cách thở của thai phụ.

Đối với từng sản phụ có những biểu hiện bệnh lý riêng thì sẽ có những cách chăm sóc khác nhau.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trấn an và giải thích cho thai phụ biết về việc sanh khó, để thai phụ an tâm điều trị.

Hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi.

Hướng dẫn chế độ ăn uống.

Hương dẫn vệ sinh cá nhân.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Tiến triển đình trệ, dấu suy thai, chảy máu hoặc đau bất thường: báo bác sĩ sản khoa, chuẩn bị xử trí và hồi sức mẹ, trẻ; không tự tăng thuốc tăng co.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sau khi nhận định, lập kế hoạch chăm sóc và chăm sóc thai phụ đạt được kết quả tốt:

Thai phụ yên tâm tin tưởng vào chuyên môn và làm theo những hướng dẫn của nữ hộ sinh.

Tình trạng sức khỏe của thai phụ được cải thiện và hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

40 Chăm sóc bệnh nhân hội chứng tiết dịch âm đạo

Mã đề xuất QTCS-40. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC BỆNH SỬ VÀ TIỀN SỬ

Khí hư: chất tiết từ âm đạo có số lượng ít hoặc nhiều, loãng hoặc đặc, màu trong hoặc đục hay màu vàng, có mùi hôi hoặc không hôi.

Ngoài ra, còn có các triệu chứng khác đi kèm như: ngứa vùng âm hộ, âm đạo đặc biệt do nhiễm nấm men Candida; có cảm giác bỏng rát vùng âm hộ, âm đạo; viêm sưng âm hộ, đau khi giao hợp và có thể kèm theo đi tiểu khó.

Có thể viêm sưng hoặc abces tuyến Bartholin.

Cần khai thác các thông tin có liên quan như: triệu chứng hiện tại, thời gian xuất hiện triệu chứng bệnh lý và thời gian bệnh tồn tại, tiền sử kinh nguyệt và thai nghén, đã có lần nào tiết dịch âm đạo bệnh lý hay khí hư hoặc bị bệnh tương tự và các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục hay chưa, nếu có thì mấy lần; lần giao hợp cuối cùng, sự liên quan giữa triệu chứng bệnh lý và giao hợp gây đau hoặc có triệu chứng nặng lên; đã có chồng hay bạn tình thường xuyên chưa, số bạn tình và các loại bạn tình, nghề nghiệp…; chồng hoặc bạn tình có triệu chứng được chẩn đoán hoặc có nguy cơ viêm nhiễm đường sinh dục hay không; các loại thuốc và biện pháp điều trị đã hoặc đang sử dụng, tiền sử dị ứng thuốc; tiền sử hay hiện nay đang nghiện, chích ma túy, xăm trổ…

Trên cơ sở này, cần đánh giá nguy cơ viêm ống cổ tử cung do nhiễm lậu cầu khuẩn và Chlamydia thường chiếm tỉ lệ cao nếu phát hiện phụ nữ có một trong những yếu tố có liên quan như: bạn tình có các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, có hành vi tình dục không an toàn, có quan hệ tình dục hoặc bạn tình có quan hệ tình dục với nhóm người có hành vi tình dục nguy cơ cao với người mại dâm, sử dụng chất ma túy… hay có 2 trong 3 yếu tố như: thanh niên ở độ tuổi 20, chưa lập gia đình và đã có quan hệ tình dục; có trên một bạn tình hoặc bạn tình có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình khác; có bạn tình mới trong vòng 3 tháng gần đây.

2. QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Khám mỏ vịt:

Âm đạo màu sắc, u bướu, tổn thương, sùi, loét …

Cổ tử cung: cổ tử cung, kích thước, màu sắc, u bướu, tổn thương, dịch từ cổ tử cung.

Dịch âm đạo: lượng, màu sắc, mùi.

Khám tay:

Âm đạo dãn nở, thành âm đạo mềm hay xơ cứng, u bướu, đau, bất thường hay không.

Cổ tử cung mở hay khép, mềm, chắc, đau không.

Tử cung tư thế.

Các túi cùng có phồng hay không.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Khó chịu do khí hư nhiều.

2. Ngứa đau rát âm hộ do nấm.

3. Vệ sinh kém.

4. Lo lắng do khí hư nhiều.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Giúp bệnh nhân đỡ khó chịu do khí hư nhiều.

2. Giảm ngứa đau rát âm hộ do nấm.

3. Giúp bệnh nhân vệ sinh tốt hơn.

4. Giảm lo lắng cho bệnh nhân.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIÚP BỆNH NHÂN ĐỠ KHÓ CHỊU DO KHÍ HƯ NHIỀU

Giải thích vì bệnh này có nhiều khí hư, nếu dùng thuốc đúng sẽ giảm bệnh.

Hướng dẫn cách dùng thuốc.

Hướng dẫn bệnh nhân theo dõi những dấu hiệu trở nặng như khí hư nhiều hơn phải quay lại tái khám ngay.

2. GIẢM NGỨA ĐAU RÁT ÂM HỘ DO NẤM

Hướng dẫn sử dụng thuốc.

Hướng dẫn vệ sinh không nên thục rửa âm hộ.

Không nên rải khi ngứa, nếu rải sẽ dễ bị nhiễm trùng, nếu còn phải tái khám ngay hoặc ngứa nhiều hơn.

3. GIÚP BỆNH NHÂN VỆ SINH TỐT HƠN

Hướng dẫn bệnh vệ sinh hằng ngày bằng dung dịch rửa phụ khoa và mỗi lần đi tiêu tiểu phải thấm khô.

Nếu khí hư nhiều có thể đặt băng vệ sinh hằng ngày.

4. GIẢM LO LẮNG CHO BỆNH NHÂN

Hướng dẫn và giải thích cho bệnh nhân đỡ lo lắng như chị dùng thuốc đúng thì bệnh này sẽ khỏi chị đừng lo lắng quá vì cũng có nhiều người bệnh giống như chị vẫn điếu trị hết.

Hướng dẫn bệnh phải đi khám phụ khoa định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần để phát hiện bệnh sớm và điều trị.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sốt, đau vùng chậu, ra máu hoặc thai kèm dịch bất thường: báo bác sĩ; lấy mẫu đúng chỉ định, không tự thụt rửa âm đạo.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân đỡ khó chịu.

Bệnh hết ngứa và đau rát âm hộ.

Bệnh nhân vệ sinh tốt.

Bệnh nhân hết lo lắng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

41 Chăm sóc bệnh lạc nội mạc tử cung

Mã đề xuất QTCS-41. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhóm phụ nữ sau có nguy cơ cao bị LNMTC:

Phụ nữ chưa sinh đẻ, chu kì kinh nguyệt ngắn, hành kinh kéo dài, cường kinh, dậy thì sớm.

Tiền sử gia đình có người bị LNMTC.

Tắc nghẽn đường thoát máu kinh.

Môi trường, chế độ ăn: phơi nhiễm với các chất hóa học dẫn đến biến đổi nội tiết tố, thức ăn có cồn, caffeine, chất béo, thịt đỏ, thuốc lá…có thể là nguy cơ cao LNMTC.

2. KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM

Kinh nguyệt có điều không, vòng kinh dài hay ngắn.

Mỗi lần hành kinh có đau bụng không.

Kiểm tra vùng chậu đây là bước kiểm tra đầu tiên dùng tay khám để xác định cơn đau.

Siêu âm xác định hình dạng và những bất thường ở vòi trứng, tử cung, vùng chậu thông qua hình ảnh.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Lo lắng do bệnh lạc nội mạc tử cung.

Đau bụng kinh nhiều do lạc nội mạc tử cung.

Chảy máu ồ ạt bất thường khi đang có kinh nguyệt.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm lo lắng do bệnh lạc nội mạc tử cung.

Giảm đau bụng kinh nhiều do lạc nội mạc tử cung.

Đề phòng và phát hiện chảy máu ồ ạt bất thường khi đang có kinh nguyệt.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM LO LẮNG DO BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Trấn an và giải thích cho bệnh nhân hiểu, cũng có nhiều người giống như mình, nếu mình luyện tập thể dục đều mỗi ngày, giữ tinh thần thoải mái, chế độ dinh dưỡng ăn đầy đủ các chất.

2. GIẢM ĐAU BỤNG KINH NHIỀU DO LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Thực hiện thuốc giảm đau.

Tư thế nằm co chân để đỡ đau.

3. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN CHẢY MÁU Ồ ẠT BẤT THƯỜNG KHI ĐANG CÓ KINH NGUYỆT

Đặt vệ sinh để theo dõi nếu thấy trong 01 giờ thấm đẫm 02 băng vệ sinh thì đến bệnh viện liền hoặc báo ngay cho nhân viên y tế.

Dùng thuốc cầm máu.

Truyền dịch nâng thể trạng.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau đột ngột dữ dội, ngất hoặc chảy máu nhiều: báo bác sĩ, không quy mọi đau cấp cho lạc nội mạc tử cung.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân hết lo lắng về bệnh.

Bệnh đỡ đau.

Bệnh không chảy máu ồ ạt.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

42 Chăm sóc sản phụ chuyển dạ đình trệ

Mã đề xuất QTCS-42. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại khoa hiện có của thai phụ.

Tiền sử thai phụ có đẻ khó không?

Nhận định tình trạng tinh thần, dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, vệ sinh, nghỉ ngơi.

Nhận định về thời gian chuyển dạ.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Tổng trạng sản phụ.

Cơn go tử cung: cường độ, thời gian co, thời gian nghỉ.

Tim thai: Tim thai: tần số, cường độ nhịp tim thai.

Xóa mở cổ tử cung.

Tình trạng ối.

Sử phát triển của ngôi thai.

Phát hiện các dấu hiệu bất thường: cơn go tử cung tăng hoặc giảm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau do cơn go tử cung.

Mệt mỏi, kiệt sức do thời gian chuyển dạ kéo dài.

Chăm sóc vệ sinh cá nhân kém quá trình chuyển dạ.

Mất ngủ do lo lắng về quá trình chuyển dạ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Động viên và giải thích cho thai phụ hiểu vế cơn gò tử cung.

Giảm mệt mỏi và lo lắng cho thai phụ.

Đảm bảo vệ sinh cá nhân cho thai phụ.

Giáo dục sức khỏe cho thai phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. ĐỘNG VIÊN VÀ GIẢI THÍCH CHO THAI PHỤ HIỂU VỄ CƠN GÒ TỬ CUNG.

Động viên, trấn an tinh thần, cung cấp thông tin về tình trạng của mẹ và thai cho sản phụ hiểu và bớt lo lắng.

Hướng dẫn sản phụ khi thấy cơn go tử cung nhiều và đau, báo ngay nhân viên y tế.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi cơn gò trong 10 phút có 2-3 cơn go tử cung, mỗi cơn go kéo dài 20 giây.

2. GIẢM MỆT MỎI VÀ LO LẮNG CHO THAI PHỤ

Giải thích cho thai phụ về cơn đau của chuyển dạ.

Hướng dẫn thai phụ nghỉ ngơi khi chưa có cơn đau .

Hướng dẫn người nhà luôn động viên, chăm sóc quan tâm đến thai phụ.

Hướng dẫn thai phụ khi cò dấu hiệu đau bụng, ra huyết âm đạo, báo ngay cho nhân viên y tế.

3. HƯỚNG DẪN VỀ VỆ SINH CÁ NHÂN CHO THAI PHỤ

Hướng dẫn thai phụ giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài trước và sau mỗi lần thăm khám âm đạo.

Thay băng vệ sinh khi ra nước âm đạo nhiều.

4. GÍAO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn thai phụ nghỉ ngơi.

Hướng dẫn thai phụ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai.

Hướng dẫn thai phụ về vệ sinh cá nhân.

Trấn an tinh thấn để sản phụ an tâm theo dõi trong suốt quá trình chuyển dạ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đình trệ kèm tim thai bất thường hoặc nghi tắc nghẽn: báo bác sĩ khẩn, theo dõi cơn co, thuốc đang truyền và chuẩn bị can thiệp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Đánh giá là tốt khi:

Can thiệp có hiệu quả.

Tình trạng mẹ và bé tiến triển tốt.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

43 Quy trình chăm sóc sản phụ chuyển dạ ngôi mông

Mã đề xuất QTCS-43. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Sản phụ, tuổi, para….

Tiền sử các lần mang thai trước có sanh ngôi mông.

Tư thế của thai trong buồng tử cung.

2. KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Các triệu chứng cơ năng: dấu hiệu nghén, thai máy, mức độ phù, tình trạng mệt mỏi,…

Bề cao tử cung, vòng bụng.

Tình trạng ối: còn hay đã vỡ ối, màu sắc, mùi,…

Sản phụ và gia đình lo lắng cho cuộc sanh.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ sanh non.

Nguy cơ đờ tử cung sau sanh.

Mệt mỏi, khó ngủ, lo lắng về quá trình sanh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm nguy cơ sanh non:

Tránh nguy cơ đờ tử cung sau sanh.

Trấn an cho thai phụ và hướng dẫn vệ sinh cá nhân.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. GIẢM NGUY CƠ SANH NON

Chăm sóc về tinh thần cho sản phụ.

Chăm sóc về chế độ nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng cho sản phụ.

Thực hiện các loại thuốc được chỉ định.

Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm bổ sung chẩn đoán.

Theo dõi tình trạng sức khỏe và bệnh lý hiện tại của sản phụ.

2. TRÁNH NGUY CƠ ĐỜ TỬ CUNG SAU SANH

Theo dõi toàn trạng, DHST của sản phụ.

Theo dõi cơn go tử cung: tần số, cường độ, nhịp tim thai.

Theo dõi ngôi thế, kiểu thế và sự tiến triển của ngôi thai.

Theo dõi tình trạng xóa mở cổ TC.

Theo dõi tình trạng ối: đầu ối, màu sắc, mùi,…

3. TRẤN AN CHO THAI PHỤ VÀ HƯỚNG DẪN VỆ SINH CÁ NHÂN

Động viên về tinh thần cho sản phụ, giúp cho sản phụ chịu đựng được cơn đau của thai ngôi mông.

Vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài sạch sẽ qua mỗi lần thăm khám hay mỗi lần đi vệ sinh.

Theo dõi, đánh giá sự phát triển của thai kỳ, phát hiện sớm các nguy cơ cho thai và người mẹ.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Thực hiện đầy đủ y lệnh các loại thuốc, đúng giờ, đúng liều các thuốc tăng co, giảm co,…

Thực hiện nhanh chóng đầy đủ các xét nghiệm đánh giá tình trạng thai nhi.

Theo dõi cơn go tử cung: Khi thấy cơn go tử cung tăng bất thường về cường độ, tần số, hoặc trương lực cơ bản tăng thì phải báo ngay cho bác sĩ.

Theo dõi tim thai, báo ngay bác sĩ khi bất thường; đánh giá mẹ và xử trí theo phác đồ sản khoa. Không cho oxy thường quy chỉ vì tim thai bất thường nếu mẹ không thiếu oxy.

Theo dõi tình trạng xóa mở cổ TC.

Theo dõi sát sản phụ những giờ đầu sau sanh vì dễ xảy ra chảy máu do đờ tử cung thứ phát.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn sản phụ theo dõi cử động thai, thay bang vệ sinh 3 giờ/lần hoặc khi ướt.

Hướng dẫn ăn loãng, uống ít nước.

Hướng dẫn sản phụ khi ra nước âm đạo cần báo ngay cho nhân viên y tế.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Tim thai bất thường, sa dây rốn hoặc chuyển dạ ngôi mông cần gọi đội sản khoa; không thực hiện thao tác kéo hoặc xoay thai ngoài phân công và năng lực.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Sản phụ an tâm, tin tưởng vào chuyên môn và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tình trạng sức khỏe của sản phụ được cải thiện và hạn chế những tai biến co thể xảy ra.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

44 Chăm sóc sản phụ nhiễm khuẩn sau đẻ

Mã đề xuất QTCS-44. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Lúc chuyển dạ ối có vỡ non, vỡ sớm không.

Chuyển dạ kéo dài.

Suy nhược cơ thể.

Toàn thân: mạch, nhiệt độ, huyết áp, vẻ mặt...

Tình trạng vết khâu tầng sinh môn.

Tình trạng tử cung: chiều cao tử cung, sự co hồi, mật độ, di động, đau, cổ tử cung đóng hay mở.

Sản dịch: số lượng, màu sắc, mùi, tính chất.

Các dấu hiệu khác như rét run, buồn nôn.....

Ăn uống của sản phụ.

2. KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

2.1. Viêm nội mạc tử cung do sót nhau:

Toàn thân mệt mỏi, khó chịu, sốt 39 - 39,50C, mạch nhanh.

Sản dịch hôi, có thể ra máu đỏ tươi kéo dài, cổ tử cung hở, thân tử cung co hồi kém, mật độ mềm, ấn đau.

2.2. Nhiễm khuẩn tầng sinh môn:

Bệnh nhân sốt nhẹ 38 - 38,50C.

Tại chỗ vết may: sưng nóng, đỏ, đau.

Sản dịch bình thường, tử cung co tốt.

2.3. Bế sản dịch:

Sản dịch không ra hoặc ra rất ít.

Cổ tử cung khép.

Nong cổ tử cung và kích thích tử cung sẽ thấy sản dịch trào ra mùi hôi, lẫn máu mũ.

2.4. Lo lắng:

Khi thăm khám sản phụ lo lắng về bệnh.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ viêm nội mạc tử cung do sót nhau sau sanh.

Nguy cơ nhiễm khuẩn tầng sinh môn.

Nguy cơ bế sản dịch do vận động kém.

Lo lắng về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Đề phòng và phát hiện sớm sót nhau.

Đề phòng và phát hiện sớm nhiễm khuẩn tầng sinh môn.

Đề phòng và phát hiện sớm bế sản dịch do vận động kém.

Giảm lo lắng cho sản phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM SÓT NHAU

Khi nhau sổ phải kiểm tra bánh nhau, màng, múi , bánh nhau có trơn láng không.

2. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM NHIỄM KHUẨN TẦNG SINH MÔN

Lấy sinh hiệu.

Thực hiện rửa vệ sinh ngày 02 lần.

Hướng dẫn sản phụ thay băng vệ sinh 6 giờ lần và khi cần.

Vệ sinh mỗi lần đi tiêu tiểu phải thấm khô.

Khi thấy đau nhiều chỗ vết may, có dịch mũ báo nhân viên y tế.

3. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM BẾ SẢN DỊCH DO VẬN ĐỘNG KÉM

Hướng dẫn sản phụ vận động đi lại bình thường.

Lấy dấu hiệu sinh tồn.

Hướng dẫn cho trẻ bú mẹ hoàn toàn.

Theo dõi sản dịch, màu, mùi...

4. GIẢM LO LẮNG CHO SẢN PHỤ

Giải thích và trấn an cho sản phụ hiểu là sau khi sinh xong mình sẽ cảm thấy mệt mỏi vì trong cuộc chuyển dạ mình phải chịu nhiều đau đớn.

Hướng dẫn sản phụ cứ vận động bình thường để sản dịch tống ra ngoài.

Sau sanh có những cơn go làm đau bụng, có khối cứng là tử cung co hồi.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sốt sau đẻ kèm đau bụng, sản dịch hôi, tụt huyết áp hoặc tri giác thay đổi: báo khẩn, đánh giá nhiễm khuẩn và sốc; phối hợp kháng sinh, kiểm soát nguồn nhiễm.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Nhau màng múi đủ.

Tầng sinh môn khô tốt.

Sản dịch đỏ sậm.

Sản phụ không lo lắng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

45 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh

Mã đề xuất QTCS-45. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

1. KHAI THÁC TIỀN SỬ

Tuổi.

Công việc: Đang đi làm đã nghỉ hưu, làm gì sau nghỉ hưu, còn lao động không?

Thay đổi tính tình mức độ.

Thay đổi các chỉ số như chỉ số khối cơ thể, tim, mạch, huyết áp.

Các bệnh lý nếu có.

2. KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM

Kinh nguyệt có điều không?

Mất kinh mấy tháng rồi.

Xáo trộn trong thời kỳ mãn kinh: Bốc hỏa, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tâm lý, mệt mỏi, tê các đầu chi, tăng cân.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh lo lắng về sự thay đổi cơ thể sau khi mãn kinh.

Nguy co loãng xương và cao HA sau mãn kinh.

Nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm lo lắng cho bệnh nhân về sự thay đổi cơ thể sau mãn kinh.

Tư vấn các vấn đề dinh dưỡng và luyện tập, tự chăm sóc bản thân.

Tổ chức khám phụ khoa định kỳ cho phụ nữ mãn kinh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM LO LẮNG CHO BỆNH NHÂN

Trấn an và giải thích cho bệnh nhân hiểu về sự thay đổi cơ thể sau mãn kinh là sinh lý bình thường, bệnh yên tâm và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tư tưởng đón nhận sự thay đổi của lứa tuổi này.

NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG VÀ CAO HA SAU MÃN KINH

Hướng dẫn bệnh nhân tăng cường bổ sung các chất đạm có lợi cho cơ thể như: Cá thu, cá hồi, cá trích...Trong chế độ ăn hằng ngày, đều này giúp giảm lượng cholesterol xấu hấp thu vào máu, hạn chế nguy cơ các bệnh về tim mạch, cao HA.

Hướng dẫn thể dục, thể thao qua các bài tập như: Đi bộ, chạy bộ, ngồi thiền, yoga, đạp xe, bơi lội... giúp cơ thể dẻo dai, phòng ngừa loãng xương, giúp máu tuần hoàn, hạn chế tình trạng tăng cân.

NGUY CƠ MẮC MỘT SỐ BỆNH PHỤ KHOA

Tư vấn và hướng dẫn cách theo dõi, tự khám phát hiện một số bệnh như ung thư vú.

Tư vấn khám và tầm soát ung thư cổ tử cung theo tuổi, tiền sử và hướng dẫn; ra huyết sau mãn kinh cần khám, không coi siêu âm hoặc xét nghiệm nội mạc là tầm soát thường quy cho mọi người.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân ăn nhiều rau, trái cây, uống nước dừa tươi, nước ép hoa quả.

Hạn chế làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều, ngủ 8- 10 tiếng/ngày.

Khicó dấu hiệu bất thường như: sốt, ra huyết kéo dài, hôi, …. Thì đến ngay cơ sở y tế.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ra huyết sau mãn kinh phải được khám; không giải thích là thay đổi sinh lý bình thường.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bệnh nhân hết lo lắng về bệnh.

Phụ nữ mãn kinh đáp ứng tốt với sự thay đổi: Khỏe mạnh, tư tưởng vui vẻ, lạc quan.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy

trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

46 Quy trình chăm sóc sinh giác hút

Mã đề xuất QTCS-46. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Xác nhận người bệnh, hồ sơ thai kỳ, chỉ định sinh giác hút của bác sĩ, tuổi thai, tình trạng mẹ, tiến triển chuyển dạ và tim thai; ghi dữ liệu thực tế.

Nhận định đau, lo lắng, bàng quang, nguy cơ chảy máu, dị ứng và phương án dự phòng. Điều kiện, chống chỉ định và quyết định thực hiện thuộc bác sĩ sản khoa.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Lựa chọn theo thực tế: lo âu và đau trong cuộc đẻ; nguy cơ chảy máu, tổn thương đường sinh dục; nguy cơ trẻ cần hồi sức hoặc có tổn thương sau sinh hỗ trợ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Thống nhất mục tiêu an toàn mẹ và trẻ, giảm đau, theo dõi và phát hiện biến chứng; phân công hỗ trợ thủ thuật, chăm sóc mẹ và đón trẻ, sẵn sàng phương án can thiệp khác theo đội sản khoa.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Bước 1 Giải thích, hỗ trợ đồng thuận theo quy định; kiểm tra hồ sơ, y lệnh, phương tiện vô khuẩn và cấp cứu mẹ, trẻ.

Bước 2 Chuẩn bị tư thế, giảm đau và làm rỗng bàng quang khi được chỉ định; theo dõi sinh hiệu, cơn co và tim thai theo phác đồ.

Bước 3 Hỗ trợ bác sĩ thực hiện giác hút theo quy trình kỹ thuật riêng; hướng dẫn phối hợp của sản phụ và ghi diễn biến. Không tự lựa chọn lực kéo, số lần kéo hoặc tiếp tục thủ thuật khi đội sản khoa đã quyết định dừng.

Bước 4 Sau sinh, theo dõi chảy máu, co hồi tử cung, tổn thương tầng sinh môn, đau và tiểu tiện; chăm sóc theo chỉ định.

Bước 5 Đánh giá hô hấp và tình trạng trẻ, giữ ấm, hỗ trợ bú khi phù hợp; báo bác sĩ sơ sinh nếu trẻ bất thường, theo dõi dấu tổn thương và vàng da theo kế hoạch.

Bước 6 Hướng dẫn chăm sóc mẹ, trẻ, dấu cần khám ngay và hẹn theo dõi; bàn giao rõ thủ thuật và biến chứng nếu có.

5 Đánh giá

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Chảy máu nhiều hoặc đau tầng sinh môn tăng ở mẹ; trẻ bú kém, li bì, tái, khó thở hoặc khối sưng da đầu tăng: báo đội sản khoa hoặc sơ sinh ngay.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

Ghi kết quả thực tế của mẹ và trẻ, mức đau, lượng máu, tình trạng vết thương và đáp ứng; xác nhận khả năng người chăm sóc nhắc lại hướng dẫn và điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt.

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [17] RCOG Assisted vaginal birth ventouse or forceps patient information based on Green top Guideline 26. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

47 Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ

Mã đề xuất QTCS-47. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

NHẬN ĐỊNH BỆNH SỬ VÀ TIỀN SỬ

Thừa cân, béo phì.

Tiền sử đẻ con to trên hoặc bằng 4000 gram.

Tiền sử bất thường về dung nạp glucose, glucose niệu dương tính.

Tuổi càng cao thì nguy cơ càng tăng trên hặc bằng 35 tuổi.

Tiền sử sản khoa bất thường: thai chết lưu, sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân.

HẬU QUẢ CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ

Nguy cơ đối với mẹ.

Trong thời gian mang thai: có thể gây biến chứng tiền sản giật, sản giật, nhiễm khuẩn tiết niệu, đẻ non, đa ối.

Trong cuộc đẻ, thai to có thể làm tăng nguy cơ đẻ khó và mổ lấy thai; phối hợp đánh giá sản khoa.

Sau đẻ có nguy cơ chảy máu sau đẻ, nhiễm khuẩn sau đẻ.

Nguy cơ đối với thai.

Thai to gây đẻ khó.

Theo dõi tăng trưởng và nguy cơ theo chẩn đoán bác sĩ; không đồng nhất đái tháo đường thai kỳ với đái tháo đường có từ trước thai kỳ.

Hạ glucose máu sơ sinh.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ đẻ khó do thai to.

Nguy cơ thai chết lưu.

Nguy cơ nhiễm khuẩn đường sinh sản.

Thai phụ mệt mỏi, lo lắng về bệnh, thiếu kiến thức.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Đề phòng và phát hiện sớm đẻ khó thai to.

Đề phòng và phát hiện sớm thai chết lưu.

Đề phòng và phát hiện sớm nhiễm khuẩn đường sinh sản.

Giảm lo lắng, bổ sung kiến thức cho thai phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM ĐẺ KHÓ THAI TO

Theo dõi sự phát triển qua khám thai định kỳ.

Đo chiều cao tử cung, vòng bụng để tính cân nặng của thai.

Siêu âm lúc chuyển dạ để xác định cân nặng của thai.

ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM THAI CHẾT LƯU

Theo dõi tim thai, theo dõi tình trạng phát triển của thai, để phát hiện suy thai, báo cáo kịp thời diễn biến bất thường về thai cho bác sĩ biết.

Theo dõi tim thai qua monitor, theo dõi thai máy hoặc cử động của thai.

ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG SINH SẢN

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, màu sắc da, niêm mạc.

Hướng dẫn vệ sinh thân thể, vệ sinh răng miệng, vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, thay váy áo, băng vệ sinh vô khuẩn đề phòng nhiễm khuẩn.

Theo dõi sản dịch, sự co hồi tử cung ghi vào phiếu theo dõi.

GIẢM LO LẮNG, KIẾN THỨC CHO THAI PHỤ

Cung cấp thông tin về bệnh tiểu đường cho thai phụ, nguyên nhân, các dấu hiệu bất thường, động viên và giải thích cho thai phụ an tâm.

Theo dõi đường huyết vào các thời điểm được chỉ định, ghi giờ đo so với bữa ăn, thuốc và triệu chứng; không chỉ đo một lần mỗi ngày mặc định.

Bấm đường huyết mao mạch theo y lệnh của bác sĩ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Triệu chứng hạ đường huyết, tăng đường huyết kèm nôn hoặc giảm tri giác cần báo bác sĩ; kiểm tra đường huyết và xử trí theo phác đồ, theo dõi trẻ có nguy cơ hạ đường huyết sau sinh.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Đường huyết đáp ứng mục tiêu cá thể hóa, không có hạ đường huyết; mẹ và trẻ được theo dõi các nguy cơ liên quan.

Thai phụ biết cách phòng tránh được các biến chứng.

Thai phụ bớt lo lắng khi được y bác sĩ tư vấn chăm sóc nhiệt tình.

Theo dõi đường huyết và giáo dục bổ sung

Phối hợp khẩu phần với dinh dưỡng; dùng insulin hoặc thuốc đúng y lệnh, kiểm tra liều và hướng dẫn kỹ thuật riêng. Theo dõi đường huyết theo lịch so với bữa ăn, phát hiện hạ đường huyết và kiểm tra người bệnh thực hành. Phối hợp kế hoạch theo dõi trẻ sau sinh và hẹn kiểm tra chuyển hóa của mẹ theo bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

48 Quy trình chăm sóc thai phụ ối vỡ non

Mã đề xuất QTCS-48. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nhân có điều trị viêm nhiễm đường sinh dục hoặc nhiễm Saphilococcus nhóm B.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM

Ghi giờ vỡ ối, màu, mùi dịch và dấu nhiễm trùng; tránh thăm âm đạo bằng tay thường quy khi chưa chuyển dạ. Thăm khám sản khoa theo chỉ định, đúng phạm vi chuyên môn và vô khuẩn.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ nhiễm trùng ối.

Nguy cơ suy thai do ối vỡ non.

Nguy cơ mổ lấy thai.

Lo lắng về tình trạng bệnh.

LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC

Đề phòng và phát hiện sớm nhiễm trùng ối.

Đề phòng và phát hiện sớm suy thai do ối vỡ non.

Chuẩn bị bệnh nhân để phẫu thuật.

Giảm lo lắng cho bệnh nhân.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Cụ thể hóa mục tiêu theo vấn đề nhận định, chỉ số cần theo dõi, kết quả mong đợi, thời điểm đánh giá và nhân viên chịu trách nhiệm; ghi vào kế hoạch cá thể trước thực hiện.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN TRƯỚC MỔ

Chuẩn bị các phương tiện cấp cứu, hồi sức cho trẻ.

Chuẩn bị thai phụ làm vệ sinh vùng sinh dục ngoài, vệ sinh thân thể, vùng mổ.

Hướng dẫn ký cam đoan.

GIẢM LO LẮNG CHO THAI PHỤ

Giải thích cho thai phụ và gia đình hiểu rõ hơn về ối vỡ non.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi tiếp lượng nước ra âm đạo báo cho nhân viên y tế.

Trấn an và động viên thai phụ hãy an tâm điều trị vì cũng có người giống như mình cũng sẽ ổn.

VỀ PHÍA BÉ

Phòng và phát hiện sớm suy thai do ối vỡ non.

Theo dõi sát tim thai.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sốt, dịch ối hôi, đau tử cung, tim thai bất thường hoặc nghi sa dây rốn: báo bác sĩ khẩn; giảm thăm khám không cần thiết.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Thai phụ không nhiễm khuẩn ối.

Chuẩn bị trước mổ tốt.

Thai phụ đỡ lo lắng.

Về phía bé: Bé không bị suy thai.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

49 Chăm sóc thai phụ suy thai

Mã đề xuất QTCS-49. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại khoa hiện có của thai phụ.

Tiền sử thai phụ có đẻ khó không?

Nhận định tình trạng tinh thần, dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, vệ sinh, nghỉ ngơi.

Nhận định về thời gian chuyển dạ.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Tổng trạng mẹ: da niêm, dấu hiệu sinh tồn.

Tình trạng bệnh lý của mẹ: bệnh mãn tính, cấp tính?

Về thai: số lượng thai, cấu trúc bất thường của thai, nhịp tim thai…

Về phần phụ thai: màu sắc, số lượng và mùi của nước ối: đặc điểm dây rốn, bánh nhau có gì bất thường.

Về cơn co tử cung: cường độ và trương lực.

Tham khảo hồ sơ, cận lâm sàng: xét nghiệm máu mẹ, siêu âm.

Tâm lý sản phụ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau đớn, mất sức do cơn co tử cung mạnh và kéo dài.

Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng do cơn đau kéo dài.

Nguy cơ nhiễm trùng ối do vỡ ối kéo dài hay tình trạng vệ sinh kém.

Nguy cơ tai biến cho thai.

Tâm lý lo lắng của sản phụ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Chăm sóc cơ bản.

Thực hiện y lệnh.

Theo dõi.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. CHĂM SÓC CƠ BẢN

- Động viên trấn an tinh thần, cung cấp thông tin vế tình trạng của mẹ và thai cho sản phụ hiểu và bớt lo lắng.

Ăn uống theo tình trạng và kế hoạch sản khoa; nếu chuẩn bị mổ, thực hiện hướng dẫn nhịn ăn uống của gây mê, không mặc định cho uống nước đường.

- Chế độ nghỉ ngơi: cho sản phụ nằm nghiêng trái, nghỉ ngơi tùy theo tình trạng của mẹ.

- Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài sau mỗi lần thăm khám hay sau khi tiểu tiện.

2. THỰC HIỆN Y LỆNH

- Thực hiện đầy đủ các loại thuốc đúng chỉ định: thuốc giảm go, truyền dịch.

Cho oxy khi mẹ thiếu oxy hoặc có chỉ định phù hợp; theo dõi SpO2 và đáp ứng, không dùng oxy ngắt quãng thường quy để xử trí tim thai bất thường.

- Thực hiện nhanh chóng các xét nghiệm đánh giá tình trạng thai nhi và các bệnh lý bất thường của mẹ (nếu có).

3. THEO DÕI

- Theo dõi và đánh giá sức khỏe và bệnh lý cảu sản phụ như: quan sát vẻ mặt, dấu hiệu sinh tồn. Đối với từng sản phụ có những biểu hiện bệnh lý riêng sẽ có nhũng cách chăm sóc khác nhau.

- Theo dõi tim thai có thể nghe tim thai bằng ống nghe gỗ hoăc qua Monitoring sản khoa, nếu có bất thường báo cáo ngay.

- Theo dõi cơn co tử cung: thấy cơn co bất thường về cường độ, tần số và trương lực thì ngưng oxytocin (nếu có). Và phải báo cáo ngay với bác sĩ.

- Theo dõi tình trạng ối: màu sắc, có lẫn phân su hay không.

- Theo dõi các dấu hiệu khác nhau, độ xóa mở cổ tử cung, dây rốn, các triệu chứng tiến triển tốt lên hay xấu đi.

- Theo dõi và thực hiện đỡ sanh ngã âm đạo hay chuẩn bị mổ cấp cứu, chuẩn bị dụng cụ và thuốc hòi sức sơ sinh thật tích cực và nhanh chóng.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn thai phụ nghỉ ngơi.

Hướng dẫn thai phụ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai.

Hướng dẫn thai phụ về vệ sinh cá nhân.

Trấn an tinh thấn để sản phụ an tâm theo dõi trong suốt quá trình chuyển dạ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Tim thai bất thường kéo dài hoặc nặng lên: báo bác sĩ ngay, ghi diễn biến và thuốc tăng co; phối hợp biện pháp theo phác đồ và chuẩn bị can thiệp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Đánh giá là tốt khi:

Tổng trạng mẹ tốt, bệnh lý sẵn có ổn định.

Can thiệp có hiệu quả. Tình trạng mẹ và bé tiến triển tốt.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [15] ACOG Clinical Practice Guideline No 22 Intrapartum fetal heart rate monitoring 2025. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

50 Chăm sóc thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ

Mã đề xuất QTCS-50. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC BỆNH SỬ VÀ TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại khoa hiện có của thai phụ.

Tiền sử thai phụ có đẻ khó không?

Nhận định tình trạng tinh thần, dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, vệ sinh, nghỉ ngơi.

Nhận định về thời gian chuyển dạ.

Nhận định về tình trạng thai nhi: ngôi thai, tim thai.

Nhận định về tiến triển của các dấu hiệu chuyển dạ.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Các khối u tiền đạo, tình trạng chít hẹp âm đạo có không?

Ước lượng trọng lượng thai qua khám ngoài hoặc qua siêu âm (nếu có).

Đánh giá xem thai có cấu trúc bất thường không?

Thai đủ tháng.

Thai còn sống.

Ngôi chỏm.

Độ xóa mở cổ tử cung.

Ngôi thế, kiểu thế.

Tình trạng ối.

Cơn go tử cung phải tốt.

Thời gian chuyển dạ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Lo âu sắp đẻ.

Nguy cơ chuyển dạ kéo dài.

Đau do cơn co tử cung mạnh và dữ dội.

Chăm sóc cá nhân kém do bất động suốt quá trình sinh đẻ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm lo âu.

Đề phòng và phát hiện sớm chuyển dạ kéo dài.

Giảm đau do cơn go tử cung mạnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM LO ÂU

Giải thích tình trạng chuyển dạ, lựa chọn chăm sóc và giảm đau; tôn trọng nhu cầu, quyền riêng tư và sự đồng thuận của sản phụ.

Hướng dẫn thở, nghỉ và phối hợp rặn theo diễn biến, hỗ trợ giảm đau; không yêu cầu sản phụ im lặng hoặc coi biểu lộ đau là thiếu hợp tác.

ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM CHUYỂN DẠ KÉO DÀI

Theo dõi sự tiến triển của các dấu hiệu chuyển dạ:

Tình trạng sức khỏe của thai phụ thay đổi trong chuyển dạ.

Đo và đánh giá tiến triển cơn co tử cung bằng tay hay bằng máy.

Đo và theo dõi những biến động về tim thai và cử động của thai.

Khám đánh giá độ lọt, ngôi thai.

Theo dõi sự tiến triển xóa, mở cổ tử cung.

Theo dõi những thay đổi của loại hình đầu ối và màu sắc, mùi nước ối.

Ghi đầy đủ các số liệu vào biểu đồ chuyển dạ.

GIẢM ĐAU DO CƠN GO TỬ CUNG MẠNH

Thực hiện thuốc theo y lệnh nếu cơn co mạnh và nhiều.

Hỗ trợ vệ sinh thân thể, bộ phận sinh dục ngoài, quần áo sạch; không thụt tháo thường quy để phòng có phân khi sinh.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn cho thai phụ cách rặn đẻ.

Hướng dẫn sản phụ cho trẻ bú ngay sau khi sinh và hướng dẫn cách cho con bú.

Hướng dẫn sản phụ ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

Hướng dẫn sản phụ vệ sinh cá nhân sau khi đẻ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Theo dõi tiến triển, cơn co, tim thai và mẹ theo phác đồ; báo khẩn chảy máu, co giật, sốt, đau bất thường hoặc tim thai bất thường.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Thai phụ tốt lên khi được sanh ngã âm đạo.

Thai phụ không lo lắng khi hiểu được quá trình chuyển dạ.

Thai phụ biết tự theo dõi cử động thai.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018, [15] ACOG Clinical Practice Guideline No 22 Intrapartum fetal heart rate monitoring 2025. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

51 Quy trình chăm sóc băng huyết sau sanh

Mã đề xuất QTCS-51. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

- Bệnh nữ, tuổi, para,..

- Tổng trạng, da niêm mạc.

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM NGƯỜI BỆNH

- Máu chảy ra âm đạo, số lượng bao nhiêu, loãng hay cục, màu sắc…

- Tình trạng go tử cung.

- Chuẩn bị máu truyền (nếu có).

- Yếu tố tinh thần của thai phụ và gia đình.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Đờ tử cung do băng huyết sau sanh.

2. Sót nhau do băng huyết sau sanh.

3. Nguy cơ thiếu máu do băng huyết sau sanh.

4. Nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu.

5. Sản phụ lo lắng do băng huyết sau sanh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Sử dụng thuốc tăng go.

2. Kiểm tra lòng tử cung.

3. Đề phòng thiếu máu do băng huyết sau sanh.

4. Đề phòng và phát hiện sớm nhiễm trùng đường tiểu.

5. Lo lắng do băng huyết mất máu.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

SỬ DỤNG THUỐC TĂNG GO

Thực hiện thuốc tăng co.

Đánh giá co hồi tử cung; xoa bóp tử cung khi xử trí băng huyết do đờ tử cung theo phác đồ và năng lực được phân công, kết hợp các biện pháp cấp cứu, không trì hoãn vì chỉ xoa liên tục.

Ưu tiên hồi sức và cầm máu cho mẹ; phân công chăm sóc trẻ. Hỗ trợ bú mẹ khi tình trạng mẹ và trẻ cho phép.

KIỂM TRA LÒNG TỬ CUNG

Truyền dịch.

Lấy dấu hiệu sinh tồn.

Kiểm tra lòng tử cung còn sót màng, sót múi không.

Thực hiện thuốc theo y lệnh bác sĩ.

ĐỀ PHÒNG THIẾU MÁU DO BĂNG HUYẾT SAU SANH

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Đánh giá lượng máu mất qua túi đo máu.

Theo dõi lượng huyết ra âm đạo qua băng vệ sinh.

Hướng dẫn sản phụ nếu ra huyết âm đạo nhiều báo ngay cho nhân viên y tế.

ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU

Nữ hộ sinh vệ sinh bộ phận sinh dục và ống thông tiểu.

Hướng dẫn người nhà và sản phụ vệ sinh bộ phận sinh dục mỗi khi đi tiêu, tiểu và chậm khô.

Theo dõi ống thông tiểu có bị gập ống hay không.

Hướng dẫn sản phụ nếu thấy đau nơi đặt ống thông phải báo ngay cho nữ hộ sinh.

LO LẮNG DO BĂNG HUYẾT MẤT MÁU

Giải thích và trấn an cho người nhà và sản phụ hiểu.

Động viên sản phụ hãy an tâm và nêu ra những trường hợp giống như vậy đã điều trị ổn.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình.

Tư vấn cho sản phụ biết nếu có sanh lần sau phải khai với nhân viên y tế.

Hướng dẫn chế độ ăn: Thịt bò, sò huyết, canh rau dền, rau muống.....

Uống viên sắt hoặc tothema.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Kích hoạt cấp cứu băng huyết, gọi đội sản khoa và hồi sức, định lượng máu mất, chuẩn bị đường truyền, thuốc và máu; triển khai gói xử trí theo phác đồ, không đợi đủ một lượng máu mới gọi.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân tốt lên khi giảm chảy máu.

Tử cung co hồi tốt, sản dịch sậm ít.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [16] WHO Consolidated guidelines for prevention diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage 2025. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

52 Quy trình chăm sóc bệnh hút thai

Mã đề xuất QTCS-52. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Theo dõi dấu chứng sinh tồn, tình trạng bụng, huyết ra âm đạo. Tình trạng tri giác của người bệnh sau gây tê cổ tử cung. Dấu hiệu chảy máu âm đạo, tình trạng choáng sốc do đau, dấu hiệu sốt, run do dùng thuốc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Thai phụ lo lắng.

Nguy cơ sốc do đau.

Nguy cơ thủng tử cung.

Nguy cơ chảy máu do thai hút thai.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Hướng dẫn chế độ ăn canh rau ngót sau khi hút thai.

Hướng dẫn chế độ nghi ngơi, vận động nhẹ nhàng, ngừa thai sau hút.

Hướng dẫn nếu sau khi về nhà có ra huyết nhiều hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Tái khám sau 1 tuần làm thủ thuật.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Thai phụ lo lắng về tình trạng bệnh.

Giảm lo lắng an tâm điều trị.

Trấn an, giải thích, tư vấn rõ ràng tình trạng bệnh.

Hướng dẫn người nhà cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi yên tĩnh, tránh làm ồn.

Nguy cơ sốc do đau.

Phát hiện và xử trí kịp thời.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau.

Khi lamg thủ thuật cho bệnh nhân cần nói chuyện để phân tán sự chú ý của bệnh nhân.

Nguy cơ thủng tử cung do hút thai.

Đề phòng và phát hiện sớm.

Lấy dấu hiệu sinh tồn, quan sát da niêm.

Theo dõi tình trạng đau bụng và chướng.

Chuẩn bị phương tiện cấp cứu đầy đủ: oxytocin, thuốc cầm máu, dịch truyền…

Phát hiện sớm nguy cơ báo bác sĩ.

Nguy cơ chảy máu do hút thai.

Thực hiện thuốc cầm máu theo y lệnh.

Hướng dẫn đặt băng vệ sinh theo dõi máu ra: số lượng, màu sắc...

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn thực hiện tốt nội qui khoa phòng và bệnh viện.

Tuân thủ theo chế độ điều trị, chế độ dinh dưỡng của bệnh viện.

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, bộ phận sinh dục.

Động viên tinh thần bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Chảy máu nhiều, đau tăng, sốt, ngất hoặc giảm tưới máu sau hút thai: báo bác sĩ khẩn, chuẩn bị xử trí biến chứng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân giảm đau bụng, không chảy máu sau hút thai.

Bệnh nhân không choáng, không lạnh run, giảm lo lắng an tâm điều trị.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

53 Quy trình chăm sóc các bước tiên lượng cuộc đẻ

Mã đề xuất QTCS-53. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC QUA HỎI BỆNH

Thai đã đúng tháng chưa, bao nhiêu tuần?

Đã đi khám thai lần nào chưa?

Có nhận thấy thai máy không?

NHẬN ĐỊNH QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Khám ngoài: xác định ngôi thế của thai nhi.

Khám trong: xác định kiểu thế và độ lọt của thai nhi.

Đánh giá nhịp tim thai.

Ngôi thế, kiểu thế và độ lọt.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ suy thai.

Nguy cơ chuyển dạ kéo dài.

Mổ lấy thai đối với nhũng ngôi thế bất thường

Lo lắng do thiếu kiến thức về thai.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Phòng và phát hiện sớm suy thai.

Phòng và phát hiện sớm chuyển dạ kéo dài.

Chuẩn bị bệnh trước mổ.

Giảm lo lắng.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM SUY THAI

Theo dõi tim thai qua Monitor.

Hướng dẫn bà mẹ theo dõi cử động thai.

PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM CHUYỂN DẠ KÉO DÀI

Theo dõi bằng cách vẽ biểu đồ chuyển dạ.

Khám và theo dõi độ xóa mở cổ tử cung, độ lọt của ngôi, xác định kiểu thế xử lý kịp thời.

CHUẨN BỊ BỆNH TRƯỚC MỔ

Chuẩn bị phẫu thuật khi có chỉ định, thực hiện nhịn ăn uống theo gây mê và tháo tư trang theo quy định; không yêu cầu nhịn ăn cho mọi cuộc đẻ.

Truyền dịch.

Ký cam đoan.

Làm vệ sinh bộ phận sinh dục.

GIẢM LO LẮNG

Trấn an và giải thích cho thai phụ biết.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn thai phụ cách theo dõi thai máy.

Hướng dẫn thai phụ ăn loãng dễ tiêu, uống nước ấm.

Hướng dẫn thai phụ vệ sinh cá nhân.

Hướng dẫn đặt băng vệ sinh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Nhận định lại khi diễn biến khác dự kiến; kết luận tiên lượng và lựa chọn can thiệp do người có thẩm quyền chuyên môn, không dùng một dấu hiệu đơn độc để quyết định cách đẻ.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Thai phụ chăm sóc tốt khi thai máy bình thường.

Thai phụ được sanh ngã âm đạo.

Thai phụ giảm lo lắng và hiểu được cuộc chuyển dạ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

54 Quy trình chăm sóc sản phụ mổ lấy thai

Mã đề xuất QTCS-54. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Thai phụ bao nhiêu tuổi, mang thai lần mấy, nghề nghiệp…

Theo dõi dấu chứng sinh tồn, nước xuất nhập.

Theo dõi tình trạng của bé dấu hạ thân nhiệt, mức độ vàng da, tình trạng tiêu tiểu, tình trạng rốn và bú mẹ.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Quan sát vết mổ, băng thấm dịch, dẫn lưu ra máu không.

Tình trạng tri giác sau mổ nếu người bệnh gây mê.

Tình trạng cảm giác vận động, vận động chi nếu gây tê tủy sống.

Tình trạng bụng như đau, tình trạng nhu động ruột, nghe nhu động ruột.

Dấu hiệu chảy máu qua vết mổ, dẫn lưu ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Về phía mẹ:

Đau vết mổ và cơn co tử cung.

Nguy cơ bế sản dịch.

Nguy cơ chảy máu và đờ tử cung.

Nguy cơ tắc ruột sau mổ.

Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, áp xe vú, nhiễm trùng cơ quan sinh dục.

Nguy cơ táo bón.

Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng do ăn kiêng sau sinh.

Về phía bé:

Nguy cơ hạ thân nhiệt.

Vàng da sau sinh.

Nguy cơ nhiễm trùng rốn và da.

Nguy cơ suy dinh dưỡng do sữa ít.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Thống nhất mục tiêu cho các vấn đề bên dưới, chỉ số theo dõi, mốc đánh giá và người phụ trách; ghi kế hoạch riêng của mẹ và trẻ khi có cả hai đối tượng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

ĐAU VẾT MỔ VÀ ĐAU DO CƠN CO TỬ CUNG

Giải thích trấn an sau khi mổ sẽ đau và tử cung sẽ co lại tống sản dịch ra ngoài.

Thực hiện y lệnh giảm đau.

Tư thế giảm đau khi ho hoặc nằm.

Nếu đau nhiều hơn, mệt hơn người nhà phải báo ngay.

NGUY CƠ BẾ SẢN DỊCH

Sau mổ sản dịch sẽ ra lượng vừa nếu không ra phải báo ngay cho hộ sinh.

Hỗ trợ vận động sớm từng bước khi huyết động ổn định, hết ảnh hưởng gây mê hoặc gây tê và có chỉ định; đánh giá đau, chóng mặt và nguy cơ ngã trước khi đứng dậy.

NGUY CƠ CHẢY MÁU VÀ ĐỜ TỬ CUNG

Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, da niêm tình trạng vết mổ máu chảy có thấm băng không. Hướng dẫn người nhà nếu bệnh than mệt, tay chân lạnh lơ mơ sản dịch ra nhiều phải báo ngay.

Sờ tử cung qua thành bụng xem tử cung chắc hay mềm. Nếu bất thường phải báo ngay BS xử trí.

NGUY CƠ TẮC RUỘT SAU MỔ

Kiểm tra bụng có chướng không, bệnh có nhu động ruột không, trung tiện không.

Hướng dẫn người bệnh xoay trở thường xuyên. Ngồi dậy và đi lại những ngày sau.

NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ, ÁP XE VÚ, CƠ QUAN SINH DỤC

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Thực hiện y lệnh thuốc đúng giờ, thay băng đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo vô khuẩn. Thay băng khi rỉ dịch.

Không sờ tay vào vết mổ.

Giữ vệ sinh tránh làm ướt vết mổ.

Vệ sinh vú sạch bằng nước ấm, cho bé bú thường xuyên, nếu bé bú không hết hút bỏ phần sữa thừa, không mặc nịt ngực quá chặt.

Vệ sinh cơ quan sinh dục ngày 2 lần bằng dung dịch sát khuẩn Gynofar và vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần đi vệ sinh, thấm khô.

Thay băng vệ sinh mỗi 4 giờ hoặc khi ướt băng.

NGUY CƠ TÁO BÓN

Theo dõi bụng có chướng không.

Sau khi trung tiện hoặc có y lệnh cho uống nước và ăn thì khuyên người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, ăn nhiều rau quả như: nho, cam, chuối, rau dền, mồng tơi…...

Nếu người sản phụ sau hai ngày không đi tiêu phải báo bác sĩ ngay tránh để bón làm người bệnh đi cầu gắng sức gây bục chỉ vết mổ.

NGUY CƠ THIẾU HỤT DINH DƯỠNG DO ĂN KIÊNG VÀ ĂN KHÔNG NGON DO VỆ SINH RĂNG MIỆNG KÉM

Hướng dẫn người bệnh ăn uống bình thường không kiêng cử ảnh hưởng đến sự tiết sữa, uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận.

Hướng dẫn sản phụ tắm rửa hằng ngày bằng nước ấm, tránh gió lùa.

Vệ sinh răng miệng sạch sẽ hằng ngày.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Nằm viện:

Thực hiện tốt nội quy khoa phòng.

Phát phiếu tóm tắt.

Hướng dẫn mẹ cách vệ sinh vú và cho bé bú.

Xuất viện:

Uống thuốc theo toa, tái khám khi hết thuốc.

Hướng dẫn vận động và hạn chế gắng sức theo phẫu thuật, tình trạng hồi phục và tư vấn bác sĩ; không áp dụng một mức tải cho mọi sản phụ.

Chế độ dinh dưỡng mẹ ăn uống bình thường không kiêng cử.

Cách tắm bé và vệ sinh rốn phát quyển sổ hướng dẫn.

Tránh giao hợp trong 2 tháng đầu sau mổ.

Quần áo sản phụ và bé phải thoáng mát.

Hướng dẫn liên hệ trạm Y Tế tiêm chủng cho bé khi về.

Hướng mẹ khi về có những dấu hiệu bất thường như: sưng, nóng, đỏ, đau quay lại tái khám ngay.

LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CHO BÉ

NGUY CƠ HẠ THÂN NHIỆT

Theo dõi nhiệt độ, nếu hạ phải ủ ấm, sưởi đèn.

Bé nằm phòng kín tránh gió lùa vì bé chưa thích nghi môi trường bên ngoài.

VÀNG DA SAU SINH

Theo dõi màu da niêm mạc nếu thấy vàng da, vàng mắt báo bác sĩ xử trí kịp thời.

NHIỄM TRÙNG RỐN VÀ DA

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vệ sinh rốn bé hằng ngày đúng qui trình kỹ thuật, theo dõi có dịch rốn không, chân rốn có đỏ không, sau khi tắm làm khô rốn, vệ sinh rốn hằng ngày.

Phải tắm bé sạch sẽ, quần áo chăn quấn bé phải sạch sẽ vì da bé rất nhạy cảm.

Bé không hạ thân nhiệt trời nóng phải bỏ bớt chăn, nằm phòng thoáng.

NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG DO SỮA ÍT

Khuyên mẹ nên cho bé bú thường xuyên để kích thích tuyến sữa tiết ra nhiều.

Khuyên mẹ nên ăn uống không kiêng cử vì kiêng cử sẽ ảnh hưởng tiết sữa, vì thiếu hụt sữa sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng bé.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Chảy máu, giảm tri giác, khó thở, đau tăng hoặc dấu nhiễm trùng sau mổ: báo bác sĩ; tách theo dõi mẹ và trẻ, phối hợp chăm sóc sơ sinh.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Bà mẹ được chăm sóc tốt, vết mổ khô không chảy máu,tránh được nguy cơ tắc ruột và táo bón. Hiểu được chế độ dinh dưỡng đúng cách không kiêng khem.

Bé bú mẹ hoàn toàn, tránh nguy cơ hạ thân nhiệt, rốn khô và không vàng da sơ sinh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018, [19] NICE CG179 Pressure ulcers prevention and management. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

55 Quy trình chăm sóc sản phụ dọa sanh non

Mã đề xuất QTCS-55. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại và phụ khoa hiện có của thai phụ.

Tiền sử thai phụ có đẻ non không?

Tiền sử sản khoa (PARA).

Nhận định tình trạng dinh dưỡng, nghỉ ngơi.

Quan sát tổng trạng chung: màu sắc da, niêm mạc.

Dáng vóc, cân nặng của thai phụ.

Tình trạng tinh thần của sản phụ, hiểu biết của sản phụ về dọa sanh non.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM THAI PHỤ

Xác định tuổi thai: dựa vào kinh chót hoặc kết quả siêu âm đầu tiên hoặc 3 tháng đầu.

Ghi nhận quá trình mang thai, khám thai và những bất thường trong quá tình mang thai.

Điều kiện sống của mẹ, tình trạng bệnh lý của mẹ, bất thường tại tử cung.

Triệu chứng chính: tính chất dịch ra âm đạo: nhớt hồng, nước ối. Tính chất đau bụng: tần số cơn co (trong 10 phút), cường độ.

Khám âm đạo: ngôi thai, độ xóa mở cổ tử cung, độ lọt.

Kiểm tra tình trạng thai: qua siêu âm hoặc qua monitor sản khoa, số lượng thai, vị trí bánh nhau, chỉ số ối, tim thai còn hay mất, thai máy,…

Các thuốc đã dùng: thuốc trưởng thành phổi (đã tiêm trước đây chưa, hiện tại đã tiêm bao nhiêu lần), kháng sinh, giảm co,…

Tham khảo kết quả cận lâm sàng.

Những thay đổi khác…

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau do cơn go tử cung kéo dài.

Nguy cơ bị các tác dụng phụ của thuốc giảm co.

Nguy cơ cho trẻ và mẹ nếu phải sanh sớm hoặc mổ lấy thai.

Tình trạng dinh dưỡng chưa đầy đủ.

Tâm lý sản phụ lo lắng.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau do co thắt tử cung co sản phụ.

Hạn chế các tác dụng phụ khi dùng thuốc.

Chuẩn bị tốt cho cuộc chuyển dạ sanh non nhằm hạn chế các biến chứng cho mẹ và thai sau sinh.

Nâng cao thể trạng.

Trấn an tâm lý sản phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU DO CO THẮT TỬ CUNG CHO SẢN PHỤ.

Cho sản phụ nằm nghỉ ngơi tại giường.

Theo dõi và đánh giá sức khỏe sản phụ như: đánh giá mức độ đau qua quan sát vẻ mặt, lấy dấu hiệu sinh tồn.

Theo dõi cơn co tử cung: bắt cơn go tử cung bằng tay hoặc monitor sản khoa.

Thực hiện y lệnh thuốc giảm co.

Hướng dẫn sản phụ tập thở, các tư thế giảm đau cơ năng, tự theo dõi cơn đau để báo cho nhân viên chăm sóc nếu có đau nhiều hoặc mạnh.

HẠN CHẾ CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHI DÙNG THUỐC:

Điều dương – hộ sinh phải nắm được chống chỉ định và tác dụng bất lợi có thể có của thuốc trước khi sử dụng.

Đối với Nifedipine: chú ý đo huyết áp trước trong và sau khi dung, tránh tụt huyết áp mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Đối với MgSO4: tiêm mạch thật chậm theo chị định, đồng thời luôn theo dõi sát, chú ý đề phòng ngộ độc thuốc như giảm/mất phản xạ gân xương bánh chè, yếu cơ, làm chậm, ngưng thở… Phải chuẩn bị sẵn Calci gluconat trong trường hợp cấp cứu xảy ra.

Báo bác sĩ khi có bất thường xảy ra.

CHUẨN BỊ TỐT CHO CUỘC CHO CUỘC CHUYỂN DẠ SANH NON NHẰM HẠN CHẾ CÁC BIẾN CHỨNG CHO MẸ VÀ THAI SAU SINH.

Theo dõi sát và đánh giá đúng tiến triển cuộc chuyển dạ.

Theo dõi và đánh giá sức khỏe của thai qua monitor sản khoa.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện hồi sức và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh.

Y lệnh thuốc trưởng thành phổi, ít nhất 24 giờ trước khi chấm dứt thai kỳ.

Vệ sinh sạch bộ phận sinh dục ngoài, lau rữa bụng, núm vú chuẩn bị cho quá trình thực hiện da kề da và bú mẹ sau sinh trong trường hợp bé sinh ra khỏe mạnh và không cần hồi sức.

Phối hợp đội sản khoa và sơ sinh; các thao tác xoay thai hoặc thủ thuật chỉ do người đủ năng lực, được phân công thực hiện khi có chỉ định, không là thao tác chăm sóc thường quy.

Sau sinh: theo dõi mẹ, co hồi tử cung và chảy máu; không kiểm soát tử cung hoặc dùng kháng sinh dự phòng mặc định nếu không có chỉ định. Trẻ được giữ ấm, đánh giá hô hấp, hỗ trợ bú khi phù hợp và thực hiện vitamin K theo quy trình sơ sinh.

NÂNG CAO THỂ TRẠNG

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng tránh táo bón.

Chú ý: nên ăn loãng và chia nhiều lần, nếu có khả năng phẫu thuật thì nhịn ăn uống.

TRẤN AN TÂM LÝ SẢN PHỤ

Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh hiện tại, điều dưỡng – hộ sinh động viên trấn an tinh thần, cung cấp thông tin về tình trạng của mẹ và thai cho thai phụ hiểu.

Thường xuyên trao đổi, tạo tâm lý thoải mái, giảm lo lắng cho sản phụ.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Trấn an và giải thích cho thai phụ biết dọa sanh non là gì, để thai phụ an tâm điều trị.

Hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi.

Hướng dẫn chế độ ăn uống.

Hương dẫn vệ sinh cá nhân.

Theo dõi thai máy.

Theo dõi cơn go tử cung.

Theo dõi huyết ra âm đạo.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Theo dõi cơn co, ối, tim thai và tuổi thai; báo bác sĩ khi chuyển dạ tiến triển, nhiễm trùng hoặc suy thai, chuẩn bị đội sơ sinh phù hợp tuổi thai.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Tùy theo diễn biến lâm sang và đánh giá, nhận định lại để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chăm sóc cho phù hợp, báo cáo ngay với bác sĩ những dấu hiệu bất thường.

Chăm sóc tốt khi:

Tổng trạng mẹ tốt, tránh được cuộc chuyển dạ sanh non xảy ra.

Nếu có sanh non: sức khỏe mẹ ổn định, bé được theo dõi sanh ngã âm đạo hay mổ lấy thai an toàn, được hồi sức tốt, hay tổng trạng bé tốt, hạn chế tối đa được các tai biến do sanh non (chấn thương, tử vong).

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

56 Quy trình chăm sóc đẻ thường ngôi đầu

Mã đề xuất QTCS-56. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Sức khỏe người mẹ: toàn trạng, dấu hiệu sinh tồn, sức rặn.

Tình trạng tinh thần của sản phụ, hiểu biết của sản phụ về cuộc chuyển dạ.

Tiền sử sản khoa (PARA).

Xác định tuổi thai, ghi nhận quá trình mang thai, khám thai và những bất thường trong quá trình mang thai.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Bước chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 để chuẩn bị đỡ sanh.

Thai nhi: nghe tim thai và cơn go tử cung.

khám xem kiểu thế, độ lọt, ngôi, ối.

Tiến độ và các biến chứng có thể gặp trong giai đoạn sổ nhau.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Sản phụ đau do cơn go tử cung.

Nguy cơ và biến chứng cho cuộc sanh thường.

Nguy cơ suy thai vì không đủ sức rặn trong chuyển dạ.

Nguy cơ thiếu dinh dưỡng trong chuyển dạ.

Sản phụ lo lắng cuộc chuyển dạ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Hướng dẫn thai phụ về cơn go tử cung.

Giảm nguy cơ và biến chứng.

Động viên và khuyến khích thai phụ.

Nâng cao thể trạng cho thai phụ.

Trấn an tâm lý thai phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

HƯỚNG DẪN THAI PHỤ VỀ CƠN GO TỬ CUNG

Thai phụ sẽ cảm thấy cơn co thắt đau lan từ lưng ra bụng và ngược lại trong vòng 20 - 30 phút.

Các cơn đau sẽ không đều nhau, khi vào chuyển dạ 10 phút có khoảng 3 cơn đau, mỗi cơn đau kéo dài trên 20 giây và nghỉ trên 3 phút đó là dấu hiệu tốt cho cuộc chuyển dạ nên thai phụ cứ an tâm.

GIẢM NGUY CƠ VÀ BIẾN CHỨNG

Khi thai phụ sắp sanh dìu thai phụ sang phòng sanh hoặc chuyển bằng cán nếu cần.

Tổ chức kíp đỡ sanh: tối thiểu 2 người trong đó, vai trò từng người phải được quy định cụ thể và người phụ phải biết giúp đỡ người chính những việc gì? Nhân viên đỡ sanh phải rửa tay, mặc áo mũ y tế và mang khẩu trang khi các hộp vô khuẩn.

Chuẩn bị dụng cụ sanh như phương tiện đỡ sanh đặt đúng vị trí, dễ tìm, kiểm tra các phương tiện ủ ấm sơ sinh, hơ ấm tả lót trước khi trời lạnh và sự vận hành thử các phương tiện chữa ngạt sơ sinh.

Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài trước và sau thăm khám. Thay vải hoặc nilong sau mỗi lần rửa.

Theo dõi thể trạng người mẹ, các dấu hiệu sinh tồn: tri giác, mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, lượng nước tiểu.

Có cần hỗ trợ sức rặn (khi rặn yếu).

Cần giảm đau (khi cắt tần sinh môn).

Người đỡ: rữa tay, mang gant nhưng chú ý quan sát tránh sanh rớt.

Đối với chuyển sản phụ vào phòng sanh tùy mức độ, có thể sản phụ tự đi, dìu bế, cáng,… Khi đỡ cần có ít nhất nhân viên đỡ sanh và người nhà (nếu cần).

Sau đó thực hiện theo thường quy. Tùy trường hợp phân công cho người phụ giúp.

Nếu chỉ có một người, phải thường xuyên quan sát nét mặt, hô hấp. Nếu có thể sanh thường mà không cắt may tầng sinh môn hoặc sản phụ rặn được nên theo dõi bình thường.

Người đỡ sanh là người hộ sinh phải có mặt đúng lúc để có thể rữa tay đúng quy cách, tránh trường hợp đi găng để đỡ bé.

ĐỘNG VIÊN VÀ KHUYẾN KHÍCH THAI PHỤ

Hướng dẫn thai phụ biết cách rặn có hiệu quả, không rặn sốm quá hay rặn không đúng sẽ làm cho cuộc chuyển dạ kéo dài, gây nguy hiểm cho mẹ và con.

Hướng dẫn cách thở cho thai phụ khi cơn go tử cung gây đau nhiều thì hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, cơn đau càng tăng thì thở càng nhanh và nông hơn, đến khi cảm nhận bớt đau thì thở chậm lại và sâu hơn.

Theo dõi sức khỏe người mẹ: tần số mạch, huyết áp, thân nhiệt,…

Theo dõi cơn co tử cung: thời gian, khoảng cách, cường độ của mỗi cơn co.

Theo dõi sự tiến triển của ngôi thai.

Theo dõi sức khỏe con: tần suất nghe tim thai.

NÂNG CAO THỂ TRẠNG CHO THAI PHỤ

Thai phụ vượt cạn sẽ tốn rất nhiều năng lượng, nếu thai phụ đói sẽ rất dễ mất sức và không có sức để rặn sanh.

Tuy nhiên thai phụ cũng không quá ăn nhiều hoặc quá no, sẽ khiến thai phụ bị đầy hơi khó tiêu.

Thai phụ nên chia nhỏ bữa ăn, nhấm nháp chúng khi mỗi cơn co thắt xuất hiện, vừa giúp thai phụ quên đi đau đớn và giúp có thêm năng lượng cho cuộc vượt cạn thành công.

TRẤN AN TÂM LÝ THAI PHỤ

Bác sĩ giải thích tình trạng bệnh hiện tại, điều dưỡng – hộ sinh động viên trấn an tinh thần, cung cấp thông tin về tình trạng của mẹ và thai cho thai phụ hiểu.

Thường xuyên trao đổi, tạo tâm lý thoải mái, giảm lo lắng cho sản phụ.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Ăn uống không kiên cử: ăn nhiều chất đạm, rau dền, rau bồ ngót, chuối, cam nho....

Hướng dẫn vận động đi tới lui trong phòng.

Hướng dẫn thay băng mỗi 4 giờ hoặc khi ướt băng.

Hướng dẫn mỗi lần đi tiêu tiểu rửa sạch và chậm khô.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Báo khẩn bất thường tim thai, chảy máu, đình trệ hoặc trẻ không thở hiệu quả; thực hiện đỡ đẻ và hồi sức sơ sinh theo kỹ thuật được phê duyệt, đúng năng lực.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Chăm sóc tốt: Cuộc sanh an toàn cho cả mẹ và con, đảm bảo vô khuẩn.

Chăm sóc chưa tốt: Khi mẹ bị chấn thương đường sinh dục gây chảy máu nhiều hoặc con suy hô hấp.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

57 Chăm sóc thai phụ dọa sẩy thai

Mã đề xuất QTCS-57. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại và phụ khoa hiện có của người bệnh.

Tiền sử sản khoa (PARA).

xác định tuổi thai, ghi nhận quá trình mang thai, điều kiện sống của người bệnh.

Toàn thân: mệt mỏi, lo lắng, mất ngủ, thiếu máu, mạch nhanh, huyết áp hạ nếu máu chảy nhiều.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Đau tức nặng vùng hạ vị, đau mỏi lưng hoặc đau bụng từng cơn.

Ra huyết từ tử cung: huyết ra ít hoặc nhiều, đỏ sẫm hoặc đỏ tươi.

Có hoặc không có cơn co tử cung.

Cổ tử cung còn dài, đóng kín hoặc đã xóa mở.

Tử cung to tương đương với tuổi thai.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Người bệnh mệt mỏi, mất ngủ do lo lắng về tình trạng thai nghén bất thường.

Nguy cơ sẩy thai do ra huyết âm đạo.

Người bệnh thiếu máu hoặc suy tuần hoàn do chảy máu.

Nguy cơ nhiễm khuẩn buồng tử cung do sót rau hoặc can thiệp thủ thuật không đảm bảo vô khuẩn...

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm lo lắng, mệt mỏi và mất ngủ.

Giảm nguy cơ sẩy thai.

Giảm mức độ chảy máu khi thai đang sẩy hoặc đã sẩy.

Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn sau nạo.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM LO LẮNG, MỆT MỎI VÀ MẤT NGỦ

Quan tâm động viên người bệnh.

Giúp đỡ người bệnh trong các sinh hoạt thường ngày, cho người bệnh ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thức ăn dễ tiêu.

Theo dõi mạch, huyết áp, da – niêm mạc, sắc mặt.

Thực hiện thuốc an thân theo y lệnh.

GIẢM NGUY CƠ SẨY THAI

Hướng dẫn người bệnh nghỉ tuyệt đối tại giường khi còn đau bụng và ra huyết.

Hướng dẫn người bện ăn uống đủ chất, thức ăn dễ tiêu và phòng chống táo bón.

Theo dõi dấu hiệu đau bụng, ra huyết và các rối loạn kèm theo.

Tránh kích thích tình dục, đặc biệt là giao hợp.

Thực hiện thuốc giảm co, thuốc nội tiết theo y lệnh.

GIẢM MỨC ĐỘ CHẢY MÁU KHI THAI ĐANG SẨY HOẶC ĐÃ SẨY

Chuẩn bị người bệnh và dụng cụ kịp thời, phụ giúp thầy thuốc làm thủ thuật.

Phối hợp xử trí chảy máu và dùng thuốc theo chẩn đoán, y lệnh sản khoa cụ thể; không mặc định dùng thuốc tăng co trong dọa sảy thai khi thai còn được bảo tồn.

Theo dõi số lượng – màu sắc máu trong và sau nạo.

GIẢM NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN SAU NẠO

Theo dõi nhiệt độ, số lượng – màu sắc – mùi của sản dịch.

Hướng dẫn, trợ giúp bệnh nhân vệ sinh bộ phân sinh dục ngoài hàng ngày.

Thực hiện kháng sinh theo y lệnh

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn chế độ ăn: không nên ăn hoặc uống những chất kích thích như: tiêu ớt, cà phê, đu đủ sống, rau ngót, khóm.....

Nằm nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường.

Không nên làm những việc nặng.

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân....

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ra máu tăng, đau tăng, ngất hoặc giảm tưới máu: báo bác sĩ, đánh giá lại chẩn đoán và không tự dùng thuốc tăng co khi bảo tồn thai.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Chăm sóc có hiệu quả khi:

Người bệnh thoải mái, ăn ngủ được, đỡ mệt mỏi, đỡ thiếu máu, đỡ đau bụng và chảy máu giảm dần, thai được bảo tồn.

Người bệnh được can thiệp thủ thuật kịp thời, không sảy ra biến chứng trong và sau nạo.

Chăm sóc chưa có hiệu quả khi:

Người bệnh còn lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi, thiếu máu, thai bị sảy.

Xảy ra biến chứng trong và sau nạo.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

58 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ sa sinh dục

Mã đề xuất QTCS-58. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng hô hấp của người bệnh: Nhịp thở, tần số thở, độ căng giãn của lồng ngực thế nào? Có dấu hiệu khó thở khò khè hay không? Người bệnh tự thở được hay phải hỗ trợ máy thở?

Nhận định tình trạng tâm lý người bệnh: có lo lắng, kích động không? Hay thoải mái không?

Nhận định tình trạng tim mạch: Chỉ số nhịp tim, huyết áp là bao nhiêu, có ổn định không? Chỉ số của máy đo điện tim.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Nhận định tình trạng vết mổ, vết may tầng sinh môn: Vị trí, kích thước, mỏm cắt, băng có thấm máu không, bao lâu thay băng một lần…

Nhận đình tình trạng thân nhiệt: Thông thường cơ thể người bệnh có thể sẽ sốt nhẹ sau mổ do mất nước. Nhưng nếu sốt cao có thể là do nhiễm trùng, cần chú ý quan sát.

Nhận định tình trạng tiết niệu: Theo dõi số lượng, màu sắc nước tiểu, có dấu hiệu thiếu nước khó bài tiết hay không.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Người bệnh đau vết mổ.

Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng sau mổ.

Nguy cơ tắc ruột do vận động kém.

Nguy cơ chảy máu vết mổ, nhiễm trùng vết mổ.

Người bệnh lo lắng về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau sau mổ.

Chế độ dinh dưỡng thích hợp.

Phòng ngừa tắc ruột.

Phòng ngừa chảy máu vết mổ và nhiễm trùng vết mổ.

Cung cấp kiến thức và giảm lo lắng cho người bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU SAU MỔ

Tư thế nằm của người bệnh ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng hô hấp người bệnh. Nên để người bệnh nằm thẳng, cằm duỗi ra, hơi nghiêng mặt sang một bên, kê gối giữa hai chân. Đặc biệt cần nhẹ nhàng khi di chuyển tư thế cho người bệnh, theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Giảm đau sau mổ là vấn đề lớn trong chăm sóc sau mổ, nếu lạm dụng, không sử dụng đúng liều lượng có thể sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh.

Thuốc giảm đau phải sử dụng theo giờ với liều lượng cố định, không được đợi đến lúc đau mới sử dụng, cũng không tùy tiện cho bệnh nhân sử dụng khi họ yêu cầu, mà cần làm theo chỉ định của bác sỹ.

Bệnh nhân sau mổ phải chú ý theo dõi sát hô hấp, các chỉ số như nhịp thở, tần số thở của người bệnh trình với bác sỹ phụ trách.

Các dấu hiệu bất thường, màu da tím tái, mồ hôi chảy bất thường, co giật, vết thương chảy máu…

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP

Truyền dịch sau mổ là điều cần thiết để bổ sung nước và chất dinh dưỡng trong quá trình mổ và điều trị, cung cấp năng lượng để bệnh nhân mau chóng hồi phục sức khỏe. Ngày đầu tiên sau khi mổ cần chú ý duy trì đầy đủ các chất dinh dưỡng qua dịch truyền và ăn uống bằng miệng. Chỉ nên ăn những món ăn lỏng, nhạt, ăn chia làm nhiều bữa.

Cho ăn uống theo khả năng dung nạp, loại phẫu thuật và chỉ định; cá thể hóa dịch, không áp dụng cố định 2 lít/ngày.

Ăn thêm hoa quả trái cây tránh táo bón.

PHÒNG NGỪA TẮC RUỘT

Việc vận động sau mổ cần chú ý nhẹ nhàng, tránh vận động quá mạnh gây rách vết thương. Hướng dẫn bệnh nhân sau mổ cần phải được xoay người khi còn nằm trên giường. Sau 24 giờ rút sonde tiểu hoặc lưu sonde tiểu lâu hơn theo chỉ định của của bác sĩ.

Nếu rút sonde hướng dẫn bệnh nhân tập ngồi dậy,đi nhẹ nhàng quanh giường, hướng dẫn cách thở sâu, cách ho, cách tập luyện các bài tập nhẹ nhàng khi nằm trên giường bệnh để máu lưu thông tránh các biến chứng sau này.

PHÒNG NGỪA CHẢY MÁU VẾT MỔ VÀ NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ

Vấn đề chảy máu vết mổ hoặc chảy máu mỏm cắt có thể xảy ra trong lúc mổ, trong những giờ đầu sau mổ hoặc vài ngày sau mổ. Triệu chứng thường là huyết áp giảm,

nhiệt độ cơ thể hạ thấp, da lạnh, lúc này cần tìm nơi chảy máu và cầm máu ngay lập tức và báo ngay cho bác sĩ.

Nguy cơ nhiễm trùng chỉ cần chú ý tránh các tác động mạnh lên vết mổ, vệ sinh mỏm cắt bằng betadin 5% pha loãng.

Với các vết mổ hở thì cần chú ý nhiều hơn, màu sắc vết mổ, tình trạng liền da, tình trạng chảy máu thấm băng đều cần phải chú ý quan sát hàng ngày.

Thông thường sẽ cắt chỉ sau 5 – 7 ngày. Nếu vết mổ nặng có thể chậm hơn.

Khuyến khích người bệnh ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để sớm hồi phục các chức năng tiêu hóa, dạ dày và ruột.

Cần có đánh giá chi tiết năng lượng cần thiết phải nạp vào cơ thể người bệnh mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh.

Phát hiện và ngăn ngừa biến chứng sau mổ như vết mổ sưng, đỏ, chảy dịch vết mổ, người bệnh sốt thì báo ngay bác sĩ.

Thực hiện y lệnh thuốc đầy đủ.

CUNG CẤP KIẾN THỨC VÀ GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH.

Người bệnh không kiêng ăn, ăn đủ chất dinh dưỡng sau mổ.

Hướng dẫn người bệnh vận động, đi lại, tập thể dục. Hướng dẫn người bệnh các dấu hiệu tắc ruột như đau bụng từng cơn, bí trung đại tiện. Khi có các dấu hiệu trên, người bệnh nhịn ăn uống hoàn toàn và đến bệnh viện ngay.

Hướng dẫn phát hiện chảy dịch âm đạo hoặc ra huyết âm đạo thì đến cơ sở y tế ngay.

Chăm sóc vết mổ tại nhà.

Trong trường hợp người bệnh bị đỏ vết mổ nên đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, đảm bảo dinh dưỡng tốt.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Tư vấn cho người bệnh về chế độ dinh dưỡng.

Hướng dẫn người bệnh vệ sinh cá nhân.

Giải thích cho người bệnh hiểu về tình trạng bệnh và cách chăm sóc.

Hướng dẫn dùng thuốc, tái khám theo hẹn.

Hướng dẫn phát hiện chảy dịch âm đạo hoặc ra huyết âm đạo thì đến cơ sở y tế ngay.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Chảy máu, bí tiểu, đau tăng, sốt hoặc dịch vết mổ bất thường: báo bác sĩ; bảo đảm dẫn lưu, vệ sinh và vận động an toàn.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu

hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Tình trạng người bệnh tốt dần lên, ăn uống tốt, tinh thần thoải mái, đi lại tốt, tình trạng vết mổ tốt, không có chảy máu hoặc nhiễm khuẩn là tiến triển tốt.

Người bệnh có biểu hiện liệt ruột kéo dài, bí tiểu, chảy máu, sốt hoặc có bất kỳ bất thường nào cần báo cáo ngay bác sĩ có chế độ điều chỉnh phù hợp.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

59 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sẩy thai

Mã đề xuất QTCS-59. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Cần nhận định đầy đủ về tiền sử, bệnh sử, quá trình diễn biến của bệnh, tình trạng hiện tại của người bệnh.

Tiền sử bệnh tật: bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh nhiễm khuẩn (đặc biệt là các bệnh nhiễm khuẩn đặc hiệu: giang mai, toxoplasma,…).

Nhận định về ăn uống, vệ sinh cá nhân.

Nhận định về tinh thần tâm lý của thai phụ đối với thai kỳ.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Tiền sử sản phụ khoa: có tiền sử sẩy thai, thai lưu, … hoặc khối u và dị dạng bộ phận sinh dục.

Tình trạng hiện tại của người bệnh có dấu hiệu dọa sẩy hoặc sẩy thai: toàn thân, tuổi thai, đau bụng, ra huyết, cơn go tử cung, tình trạng cổ tử cung,…

Nhận định nhu cầu chuẩn bị hồi sức và cầm máu cho thai phụ, chuẩn bị thuốc và dụng cụ nạo sẩy thai.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau bụng do cơn co tử cung.

Người bệnh thiếu máu hoặc suy tuần hoàn do chảy máu (khi đang sẩy hoặc đã sẩy thai).

Nguy cơ nhiễn khuẩn buồng tử cung do sót nhau hoặc can thiệp thủ thuật không đảm bảo vô khuẩn…

Nguy cơ sẩy thai do không được chăm sóc và điều trị tốt.

Người bệnh mệt mỏi do lo lắng về tình trạng thai nghén bất thường, do mất ngủ.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau bụng cho sản phụ.

Người bệnh thiếu máu hoặc suy tuần hoàn do chảy máu (khi đang sẩy hoặc đã sẩy thai).

Nguy cơ nhiễn khuẩn buồng tử cung do sót nhau hoặc can thiệp thủ thuật không đảm bảo vô khuẩn…

Nguy cơ sẩy thai do không được chăm sóc và điều trị tốt.

Người bệnh mệt mỏi do lo lắng về tình trạng thai nghén bất thường, do mất ngủ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU BỤNG CHO SẢN PHỤ

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

Thực hiện thuốc y lệnh giảm co, thuốc nội tiết,…

Giảm mức độ chảy máu khi thai đang sẩy hoặc đã sẩy.

Theo dõi toàn trạng, sắt mặt. nếu thấy thể trạng mệt mỏi, da và niêm mạc ngày càng trở nên xanh nhợt kèm theo mạch nhanh, huyết áp giảm thì phải báo ngay với bác sĩ.

NGƯỜI BỆNH THIẾU MÁU HOẶC SUY TUẦN HOÀN DO CHẢY MÁU (KHI ĐANG SẨY HOẶC ĐÃ SẨY THAI)

Hướng dẫn theo dõi biểu hiện đau bụng và ra huyết âm đạo,… thay đổi tăng giảm như thế nào thì cần báo bác sĩ.

Đặt người bệnh nằm bằng đầu sau khi nạo. thực hiện y lệnh thuốc giảm đau, tăng co, chống rối loạn đông máu, chống thiếu máu và suy tuần hoàn.

Theo dõi các triệu chứng như đau bụng, ra huyết,…

NGUY CƠ NHIỄN KHUẨN BUỒNG TỬ CUNG DO SÓT NHAU HOẶC CAN THIỆP THỦ THUẬT KHÔNG ĐẢM BẢO VÔ KHUẨN…

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn và lập bảng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn trước, trong và sau nạo thai.

Thực hiện y lệnh thuốc và máu cho hồi sức và chuẩn bị dụng cụ nạo sẩy thai, phụ giúp bác sĩ làm thủ thuật.

Người bệnh nằm trên bàn sanh, vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, thong tiểu, trải sang, giảm đau, chuẩn bị bộ dụng cụ nạo, giúp thầy thuốc làm thủ thuật.

Theo dõi tình trạng ra huyết: số lượng, màu sắc máu chảy rau từ âm đạo.

Thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ.

Kế hoạch theo dõi sau nạo sẩy thai.

NGUY CƠ SẨY THAI DO KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT.

Lập kế hoạch chăm sóc về tinh thần, tâm lý theo tình huống hoặc cụ thể.

Tư vấn chế độ dinh dưỡng và vệ sinh phù hợp cho thai phụ.

Theo dõi sự co hồi tử cung: nếu thấy máu ra bất thường, máu ra ngà càng nhiều càng nguy hiểm, máu ra không có máu cục càng nguy hiểm hơn vì bình thường tử cung phải co hồi tốt và không ra máu.

NGƯỜI BỆNH MỆT MỎI DO LO LẮNG VỀ TÌNH TRẠNG THAI NGHÉN BẤT THƯỜNG, DO MẤT NGỦ

Hỏi thăm về gia đình, sức khỏe và bệnh tật của người bệnh. Nói về khả năng chuyên môn để người bệnh yên tâm tin tưởng.

Giúp đỡ người bệnh trong các sinh hoạt thường ngày, vệ sinh thân thể, giúp người bênh đi lại, ăn uống.

Người bệnh nằm nghỉ tuyệt đối tại giường, hướng dẫn hoặc trợ giúp người bệnh vận động nhẹ nhàng khi cần thiết, không nên quan hệ vợ chồng ít nhất là 2 tuần kể từ khi ngừng ra máu.

GIÁO DỤC SỨ KHỎE

Hướng dẫn cho người bệnh về ăn uống, nghỉ ngơi, vận động nhẹ khi đang ra huyết âm đạo.

Vệ sinh cá nhân, thay băng vệ sinh khi ướt.

Uống thuốc theo toa của bác sĩ.

Tái khám theo lịch hẹn.

Khi có các vấn đề bất thường như ra huyết âm đạo nhiều, mệt mõi, sốt, ... thì đến cơ sở y tế gần nhất.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Định lượng chảy máu, nhận định đau và tưới máu; báo khẩn dấu sốc hoặc nhiễm trùng, hỗ trợ tâm lý sau mất thai.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Chăm sóc có hiệu quả khi:

Người bệnh thoải mái, ăn ngủ được, đỡ mệt mõi, đỡ thiếu máu, đau bụng và chảy máu giảm dần, thai được bảo tồn.

Người bệnh được can thiệp thủ thuật kịp thời, không xảy ra biến chứng trong và sau nạo.

Chăm sóc không có hiệu quả khi:

Người bệnh còn lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi, thiếu máu, thai bị sẩy.

Xảy ra biến chứng trong và sau nạo.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

60 Quy trình chăm sóc bệnh nhân thai ngoài tử cung

Mã đề xuất QTCS-60. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Nhận định tình trạng bệnh lý nội, ngoại và phụ khoa hiện có của người bệnh.

Tiền sử sản khoa (PARA).

xác định tuổi thai, ghi nhận quá trình mang thai, điều kiện sống của người bệnh.

Toàn thân: mệt mỏi, lo lắng, mất ngủ, thiếu máu, mạch nhanh, huyết áp hạ nếu máu chảy nhiều

Theo dõi dấu chứng sinh tồn, nước xuất nhập.

Dấu hiệu sốt, tình trạng mất nước, điện giải.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Tình trạng bụng: Quan sát băng thấm dịch, dẫn lưu ra máu không, tình trạng tri giác sau mổ nếu người bệnh gây mê. Tình trạng cảm giác vận động, vận động chi nếu gây tê tủy sống. Tùy tình trạng bụng như đau, tình trạng nhu động ruột, nghe nhu động ruột.

Dấu hiệu chảy máu qua vết mổ, dẫn lưu ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Thiếu hụt thể tích dịch do ăn uống kém và mất máu trong khi mổ.

Nguy cơ đau vết mổ, chảy máu sau mổ.

Nguy cơ nhiễm trùng.

Nguy cơ tắc ruột.

Nguy cơ bí tiểu và táo bón.

Bệnh nhân và thân nhân lo lắng vế tình trạng bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho người bệnh.

Giảm đau sau mổ.

Phòng ngừa nhiễm trùng vết mổ.

Phòng nguy cơ tắc ruột.

Phòng nguy cơ bí tiểu và táo bón.

Giải thích cho người bệnh và thân nhân bớt lo lắng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ CHO NGƯỜI BỆNH

Theo dõi bệnh nhân tỉnh táo da niêm hồng hào là bình thường.

Nếu bị thiếu hụt thể tích là môi khô, lưỡi bẩn, vẻ mặt mệt mỏi cần bù thêm dịch khi người bệnh chưa ăn được.

Nếu mất máu thì vẻ mặt lo âu, da, niêm nhợt nhạt.

Lấy dấu hiệu sinh tồn ngày 02 lần.

Hướng dẫn bệnh nhân thấy có những dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, vả mồ hồi thì báo ngay cho nhân viên y tế.

GIẢM ĐAU SAU MỔ

Giảm đau cho người bệnh.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng và tính chất cơn đau của vết mổ.

Theo dõi ống dẫn lưu số lượng, màu sắc như dịch hồng ít là bình thường.

Lượng,màu sắc như dịch hồng ít là bình thường.

Nếu ống dẫn lưu ra dịch đỏ tươi lượng nhiểu báo ngay BS.

Hướng dẫn bệnh nhân nghiên phải, nghiên trái vận động nhẹ nhàng tại giường.

PHÒNG NGỪA NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ

Hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, phát hiện sớm nhiễm trùng.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng vết mổ.

Phát hiện sớm nhiễm trùng vết mổ khi có các triệu chứng viêm, vết mổ có dịch hoặc sưng đỏ đau.

Thay băng nhận định vết mổ.

Hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân hàng ngày bằng nước ấm tránh làm ướt vết mổ.

PHÒNG NGUY CƠ TẮC RUỘT

Hướng dẫn bệnh nhân vận động nhẹ nhàng.

Hướng dẫn bệnh nhân tập đi lại nhẹ nhàng trong phòng.

Theo dõi nhu động ruột để phát hiện sớm biến chứng tắc ruột.

Theo dõi dấu hiệu đau bụng từng cơn, có dấu hiệu rắn bò báo nhân viên y tế biết.

Hướng dẫn ăn thức ăn từ lõng đến đặc (Uống sữa, súp, cháo, cơm).

PHÒNG NGUY CƠ BÍ TIỂU VÀ TÁO BÓN

Hạn chế nguy cơ bí tiểu và táo bón.

Đánh giá bí tiểu, lượng nước tiểu và căng bàng quang; hỗ trợ tư thế an toàn và báo bác sĩ. Không để chườm nóng làm chậm xử trí hoặc gây bỏng.

uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận, ăn nhiều chất xơ.

GIẢI THÍCH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN BỚT LO LẮNG

Trấn an tinh thần, giảm lo lắng, an tâm điều trị.

Giải thích những thắc mắc của bệnh nhân và thân nhân trong giới hạn có thể với thái độ ân cần và tôn trọng người nghe.

Phát phiếu tóm tắt bệnh.

Luôn tỏ ra quan tâm với bệnh nhân thái độ nhẹ nhàng khi giao tiếp, chăm sóc, làm thủ thuật.

Thường xuyên theo dõi, lắng nghe ý kiến của người bệnh, làm giảm lo lắng và an tâm hợp tác điều trị.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Khi nằm viện:

Hướng dẫn thực hiện tốt nội qui khoa phòng và bệnh viện.

Tuân thủ theo chế độ điều trị, chế độ dinh dưỡng của bệnh viện.

Bổ sung thêm thức ăn giàu vitamin và khoáng chất (Cam, nho, táo, đu đủ).

Hướng dẫn giữ vết mổ luôn khô ráo, tránh ẩm ướt.

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, bộ phận sinh dục.

Động viên tinh thần bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Khi xuất viện:

Uống thuốc theo toa, tái khám khi hết thuốc.

Hạn chế mang vác và gắng sức theo tư vấn sau phẫu thuật; tăng hoạt động từ từ khi hồi phục, không dùng hướng dẫn mâu thuẫn về mức dưới 5 kg.

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, ăn thức ăn nhiều chất đạm, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi, uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận (Thịt, trứng, cá, cam, nho,rau dền, rau muống….).

Áp dụng các biện pháp tránh thai (cấy que ngừa thai, uống thuốc ngừa thai, bao cao su….. …).

Hướng dẫn bệnh nhân theo dõi vết mổ tại nhà nếu có sưng, đỏ, đau trở lại tái khám ngay.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau bụng tăng, đau vai, ngất, tái hoặc tụt huyết áp có thể là cấp cứu chảy máu trong; báo ngay, chuẩn bị hồi sức và phẫu thuật, không chờ thấy nhiều máu âm đạo.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân giảm đau vết mổ, không chảy máu sau mổ.

Chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhân vận động được không xảy ra biến chứng, bệnh nhân tiểu tiểu được, an tâm điều trị.

TÀI LIỂU THAM KHẢO

1. Bệnh viện Từ Dũ (2019), Thai ngoài tử cung, “Phác đồ bệnh viện Từ Dũ”, trang 209-215.

2. Hướng dẫn quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản 2009, trang 182.

3. Sản phụ khoa - bách khoa y học năm 2010, trang 232.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

61 Quy trình chăm sóc thai phụ nôn nặng do thai nghén

Mã đề xuất QTCS-61. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Thai phụ tuổi, nghề nghiệp, para.

Theo dõi DHST: mạch, nhiệt độ, HA, nhịp thở.

Tình trạng nôn của thai phụ: thời điểm xuất hiện, số lần nôn, chất nôn, mức độ nôn.

Mức độ khó chịu của thai phụ khi nôn: đau họng, có mùi khó chịu ở miệng, đau thượng vị, mệt mỏi.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Màu sắc da, các dấu hiệu mất nước ở da.

Theo dõi lượng nước tiểu, tỷ trọng, aceton trong nước tiểu.

Theo dõi điện giải đồ và các kết quả cận lâm sàng khác.

Các yếu tố ảnh hưởng làm tình trạng nôn nặng lên; đối với hội chứng nôn nặng mức độ lo lắng và không thoải mái của thai phụ.

Tình trạng qua thăm khám lâm sang: chiều cao tử cung,đánh giá tuổi thai, khám trong qua thăm dò, siêu âm, test thử thai.

Các dấu hiệu bất thường: đau bụng, ra máu, chế độ ăn, nghỉ ngơi, vệ sinh cùa thai phụ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Rối loạn nước và điện giải do nôn nhiều.

Nguy cơ cho thai và mẹ do rối loạn nước điện giải chất dinh dưỡng.

Thiếu kiến thức về bệnh do lo lắng về tình trạng bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Bù dịch và điện giải, giảm nôn cho thai phụ.

Giảm nguy cơ cho thai và thai phụ.

Giảm lo lắng cho thai phụ và người nhà.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

BÙ DỊCH VÀ ĐIỆN GIẢI, GIẢM NÔN CHO THAI PHỤ

Thuốc chống nôn là chìa khóa để điều trị thành công chứng nghén nặng. Nhiều nghiên cứu về tính an toàn và hiệu quả còn thiếu, nhưng vẫn có nhiều kinh nghiệm sử dụng các thuốc này trong thai kỳ.

Những dịch truyền có thể lựa chọn gồm natri clorid 0,9% và dung dịch sodium lactate.

Đánh giá nguy cơ thiếu thiamine khi nôn kéo dài; phối hợp dùng thiamine trước dịch chứa glucose khi có chỉ định. Không trì hoãn xử trí hạ đường huyết cấp để chờ thiamine.

Cân bằng chất lỏng và điện giải nên được đánh giá thường xuyên và hiệu chỉnh khi thích hợp.

Theo dõi màu sắc da, các dấu hiệu mất nước, các dấu hiệu sinh tồn; mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, số lượng nước tiểu trong 24 giờ và ghi vào phiếu chăm sóc.

GIẢM LO LẮNG CHO THAI PHỤ VÀ NGƯỜI NHÀ

Hướng dẫn thai phụ nghỉ ngơi hợp lý, theo dõi dịch truyền, tình trạng nghén của thai phụ.

Động viên thai phụ, hướng dẫn vận động, vệ sinh cá nhân,thực hiện y lệnh đầy đủ.

Áp dụng các phương pháp không dùng thuốc có tác dụng giảm nôn cho thai phụ: tư thế nằm, thư giản, cách thở, chườm lạnh lên trán, cổ, gáy.

Vệ sinh răng miệng thường xuyên, vệ sinh thân thể, vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài cho thai phụ.

Động viên, giải thích cho thai phụ để thai phụ yên tâm.

Tập cho thai phụ ăn trở lại dần dần bằng phương pháp ăn lạnh.

Cung cấp thông tin về bệnh cho thai phụ: nguyên nhân, dấu hiệu, diễn biến, các điều trị có thể áp dụng.

Giúp đỡ bác sĩ trong thăm khám và điều trị, thông báo kết quả thăm khám và điều trị cho thai phụ.

Thông báo cho bác sĩ mọi thay đổi và bất thường của thai trên lâm sàng và cận lâm sàng.

Cho thai phụ nằm nghiên trái, nằm nghỉ tại giường, vận động nhẹ nhàng tại giường.

Cho thai phụ thở oxy qua mặt nạ hoặc sonde mũi khi có chỉ định của bác sĩ.

Giải thích về tình trạng nghén của thai phụ cho người nhà hiểu và thai phụ yên tâm điều trị.

GIẢM NGUY CƠ CHO THAI VÀ THAI PHỤ

Cho thai phụ nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và thư giãn càng nhiều càng tốt, tránh căng thẳng về tinh thần….

Uống nước thường xuyên để tránh mất nước ngoài ra có thể uống them sữa và các loại nước trái cây.

Tránh các đồ uống lạnh, chua hay ngọt, đồ ăn nhiều gia vị, chất béo đồ chiên xào án, thức ăn cay nóng, rươụ, cà phê, thức ăn có mùi gây khó chịu.

Chia nhỏ bữa ăn và ăn những thực phẩm dễ tiêu nên ăn ít tránh gây đầy bụng hạn chế để dạ dày trống vì có thể làm bạn cảm thấy buồn nôn hơn.

Tăng cường ăn rau xanh, các loại hoa quả chin, các loại đậu…

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn ăn hoặc uống những chất dễ tiêu, chia ra ăn ít nhiều lần trong ngày.

Ngậm xí muội hoặc kẹo (đối vối những thai phụ không cao huyết áp hoặc không bị tiểu đường).

Hướng dẫn vệ sinh răng miệng.

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Không giữ được nước, tiểu ít, rối loạn tri giác hoặc dấu mất nước nặng: báo bác sĩ; theo dõi điện giải, dịch và nguy cơ thiếu thiamine.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Chăm sóc có hiệu quả khi: người bệnh thoải mái, ăn uống được, tăng cân, hết nôn, không xảy ra biến chứng trong khi điều trị, thai nhi phát triển bình thường.

Chăm sóc chưa có hiệu quả: người bệnh mệt mỏi, không ăn được, sụt cân, xuất hiện biến chứng nôn nhiều, thai nhi không phát triển.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

62 Quy trình chăm sóc người bệnh mổ u nang buồng trứng

Mã đề xuất QTCS-62. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nữ, tuổi, nghề nghiệp, para...

Cần nhận định về tình trạng của người bệnh, mổ cắt khối u qua nội soi hay mở bụng, thời gian phẫu thuật bao lâu, gây mê hay gây tê.

Hô hấp: tần số thở, tình trạng thông khí, biên độ hô hấp, độ bão hòa oxy theo mạch đập, dấu hiệu thiếu oxy, tình trạng khó thở.

Tuần hoàn: mạch, nhịp tim, huyết áp, dấu hiệu thiếu nước, tình trạng choáng, áp lực tĩnh mạch trung ương.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Bệnh nhân tỉnh hay mê.

Dẫn lưu: loại, vị trí, màu sắc, số lượng, tình trạng hoạt động.

Vết mổ: vị trí, kích thước, thấm dịch, chảy máu, đau, nhiễm trùng…

Tâm lý người bệnh: lo lắng hay thoải mái.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Người bệnh đau vết mổ.

Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ.

Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng sau mổ.

Người bệnh vận động kém sau mổ.

Nguy cơ nhiễm trùng dẫn lưu và thông tiểu.

Người bệnh lo lắng do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau sau mổ.

Giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh.

Vận động sớm sau mổ.

Phòng nhiễm trùng dẫn lưu và thông tiểu.

Cung cấp kiến thức, giảm lo lắng cho người bênh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU SAU MỔ

Tùy theo mức độ đau, điều dưỡng viên có thể áp dụng các kỹ thuật giảm đau khác nhau. Trong đó, sử dụng thuốc là một phương pháp phổ biến nhất.

Điều dưỡng viên cho bệnh nhân sử dụng thuốc theo y lệnh của bác sĩ. Trong trường hợp quá đau có thể xin chỉ thị dùng Morphine.

Thuốc giảm đau nên được sử dụng theo giờ, tránh việc chỉ dùng khi xuất hiện cảm giác đau.

GIẢM NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ

Vết mổ không nhiễm trùng hoặc khâu dưới da không cần thay băng và cắt chỉ. Đối với vết mổ hở, điều dưỡng viên cần lưu ý những điều sau:

Khâu kín da: Đối với vết mổ vô khuẩn sẽ không cần thay băng và có thể cắt chỉ sau mổ 5–7 ngày. Tuy nhiên nếu người bệnh lớn tuổi, tình trạng người bệnh suy kiệt nhiều hoặc vết mổ quá dài, vết mổ ở vị trí thiếu máu thì nên cắt chỉ khoảng 10 ngày sau mổ.

Khâu thưa hay để hở da: Trong trường hợp giải phẫu có nguy cơ nhiễm trùng, bác sĩ phẫu thuật thường để hở da giúp thoát dịch. Bởi vậy với những người bệnh này, điều dưỡng viên cần phải chăm sóc vết mổ mỗi ngày, thấm ướt dịch và theo dõi tình trạng vết thương, báo cáo ngay cho bác sĩ khi có các dấu hiệu bất thường xảy ra.

Vết mổ chảy máu: Nếu vết mổ chảy máu ít có thể băng ép vết mổ. Nếu vết mổ chảy máu nhiều điều dưỡng viên phải băng ép tạm thời. Sau đấy hãy báo cáo bác sĩ để khâu lại vết thương.

Nếu nghi nhiễm trùng vết mổ: nhận định, ghi dịch và dấu viêm, báo bác sĩ; lấy mẫu, tháo chỉ hoặc dẫn lưu theo chỉ định và phạm vi chuyên môn. Không nặn mủ thường quy.

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI BỆNH

Lượng dịch được chỉ định theo huyết động, mất dịch, khả năng ăn uống, chức năng tim thận và cân bằng vào ra; không mặc định tăng lên 3 lít khi nóng hoặc sốt.

Một số loại dịch thường được áp dụng sau mổ trong điều kiện hiện nay đó là dung dịch Ringer Lactate, dung dịch NaCl 0,9% hoặc dung dịch Glucose 5%, 10%. Chú ý không nên cung cấp quá nhiều dung dịch NaCl 0,9% và dung dịch Glucose để tránh nguy hiểm cho bệnh nhân.

Sau mổ, cho ăn uống theo mức tỉnh táo, nguy cơ sặc, khả năng dung nạp và chỉ định phẫu thuật, gây mê; không bắt buộc nhịn ăn nhiều ngày hoặc một mốc 6 giờ cho mọi trường hợp.

Trường hợp mổ đường tiêu hóa cần chờ đến khi trung tiện mới có thể ăn.

NGƯỜI BỆNH VẬN ĐỘNG KÉM SAU MỔ

Thay đổi tư thế theo tình trạng, khả năng chịu đựng, vết mổ và nguy cơ tổn thương tì đè; bảo vệ đường thở, không mặc định xoay mỗi 30 phút cho mọi người sau gây mê.

Trong quá trình chăm sóc, điều dưỡng viên cần giúp bệnh nhân tập thở sâu. Bệnh nhân cần tập cử động chân tay để tránh các nguy cơ như viêm phổi, tắc ruột hay thuyên tắc mạch.

Khi vết thương đã lành, nên cho bệnh nhân vận động đi lại nhẹ nhàng trong phạm vị phòng bệnh.

NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG DẪN LƯU VÀ THÔNG TIỂU

Nếu bệnh nhân phải đặt ống thông tiểu, điều dưỡng viên cần chăm sóc bộ phận sinh dục. Đồng thời nên cho bệnh nhân uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận (nếu được) và rút ống thông tiểu sớm. Tuy nhiên nên hạn chế việc thông tiểu.

Điều dưỡng viên nên áp dụng các phương pháp giúp người bệnh tiểu bình thường. Ví dụ như đắp ấm vùng bụng dưới (chú ý tránh gây bỏng cho người già, người bệnh gây tê tuỷ sống, người bệnh liệt mất cảm giác), tiểu kín đáo, duy trì tình trạng ống dẫn lưu vô khuẩn trong suốt thời gian người bệnh có dẫn lưu.

Giữ hệ thống dẫn lưu đúng vị trí, tránh kéo, gập và chảy ngược; không kẹp ống thường quy khi di chuyển, chỉ kẹp theo chỉ định hoặc hướng dẫn của loại hệ thống.

Chăm sóc da xung quanh chân dẫn lưu mỗi ngày hoặc khi thấm dịch. Hoạt động này nhằm phòng ngừa tình trạng lở loét da.

Báo cáo bác sĩ rút dẫn lưu sớm khi dẫn lưu hết dịch.

Phòng ngừa biến chứng do dẫn lưu như tắc ruột, chảy máu, nhiễm trùng vết thương.

Bên cạnh đó, phải theo dõi và ghi chép đầy đủ số lượng, màu sắc nước tiểu vào hồ sơ mỗi ngày.

CUNG CẤP KIẾN THỨC, GIẢM LO LẮNG CHO NGƯỜI BỆNH

Trấn an tinh thần, giảm lo lắng, an tâm điều trị.

Giải thích những thắc mắc của bệnh nhân và thân nhân trong giới hạn có thể với thái độ ân cần và tôn trọng người nghe.

Phát phiếu tóm tắt bệnh.

Luôn tỏ ra quan tâm với bệnh nhân thái độ nhẹ nhàng khi giao tiếp, chăm sóc, làm thủ thuật.

Thường xuyên theo dõi, lắng nghe ý kiến của người bệnh, làm giảm lo lắng và an tâm hợp tác điều trị.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân xoay trở tại giường.

Hướng dẫn ăn uống đủ chất.

Hướng dẫn tư thế nằm đỡ đau vết mổ.

Hướng dẫn vận động nhẹ nhàng.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Sau mổ: chảy máu, đau tăng, bụng chướng, giảm tưới máu, sốt hoặc bí tiểu cần báo bác sĩ; ghi tình trạng dẫn lưu, không tự kẹp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Tình trạng người bệnh tốt dần lên, ăn uống tốt, tinh thần thoải mái, đi lại tốt, tình trạng vết mổ tốt không có chảy máu hoặc nhiễm khuẩn là tiến triển tốt.

Người bệnh có biểu hiện sốt, bí tiểu, chảy máu hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cần báo ngay cho bác sĩ có chế độ điều chỉnh phù hợp.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

63 Quy trình chăm sóc người bệnh u xơ tử cung

Mã đề xuất QTCS-63. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nữ, tuổi, nghề nghiệp, para…

Hoàn cảnh phát hiện bệnh.

Toàn trạng bệnh: thể trạng, tình trạng thiếu máu, cân nặng.

Dấu hiệu sinh tồn, hệ thống hạch bạch huyết.

KHÁM CÁC HỆ THỐNG CỦA CƠ THỂ

Tình trạng khối u: vị trí, mật độ, thể tích, sự di động,… các cơ quan lân cận xem khối u có ảnh hưởng không như chèn ép gây đau, khó tiểu tiện, bán tắt ruột…

Dinh dưỡng ăn uống bình thường hay bất thường (nếu bất thường thì hiện tại người bệnh ăn bằng đường nào, có phù hợp với tình trạng người bệnh không,…). Vận động (khả năng tự vận động, tự chăm sóc như thế nào).

Có đau vết mổ, sốt, dịch âm đạo, ra máu âm đạo,…

Y lệnh về các xét nghiệm cận lâm sàng.

Y lệnh về thuốc.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau do chèn ép.

Ra máu âm đạo liên quan bệnh lý u xơ và mức độ được bác sĩ xác định; không đồng nhất u xơ với ung thư cổ tử cung.

Chăm sóc tinh thần.

Chăm sóc vệ sinh, ăn, uống, ngủ.

Chăm sóc đặc hiệu liên quan đến chỉ định phẫu thuật.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Lập mục tiêu trước mổ về giảm lo âu, kiểm soát chảy máu, an toàn chuẩn bị phẫu thuật và thời điểm đánh giá; sau mổ cập nhật kế hoạch theo phần riêng bên dưới.

CAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG

Trao đổi để người bệnh hiểu tình trạng, kế hoạch điều trị và chuẩn bị mổ; nhận định lo lắng, thể trạng và nhu cầu hỗ trợ thực tế.

Hỗ trợ gia đình hiểu kế hoạch chăm sóc, lắng nghe nhu cầu; không gán u xơ là khối u ác tính khi chưa có chẩn đoán.

Theo dõi toàn trạng, dấu hiệu cơ năng, đại, tiểu tiện.

Động viên người bệnh và người nhà bớt lo âu.

Hỗ trợ người bệnh trong các vấn đề: ăn uống, vận động, vệ sinh,… chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Theo dõi đại tiểu tiện: khối u chèn ép ảnh hưởng đến đại, tiểu tiện, nếu thụt tháo hoặc thông tiểu, tránh nhiễm khuẩn ngược dòng.

Thực hiện y lệnh của bác sĩ về chế độ thuốc và thủ thuật.

Giải thích tác dụng và bất lợi của thuốc thực tế được chỉ định; không đưa hóa trị vào chăm sóc u xơ thường quy.

Hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm, thực hiện quy tắc lấy mẫu bệnh phẩm đến chẩn đoán và theo dõi bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Chăm sóc về tinh thần: trấn an để bệnh nhân an tâm, tin tưởng vào cuộc phẫu thuật.

Vệ sinh thân thể và vùng phẫu thuật; không cạo lông bằng dao hoặc thụt tháo thường quy. Nếu cần loại bỏ lông, thực hiện theo quy trình chuẩn bị phẫu thuật; thông tiểu khi có chỉ định.

Hướng dẫn nhịn ăn uống theo chỉ định gây mê, phân biệt loại thức ăn và dịch uống; không quy định đồng loạt 6 giờ cho tất cả.

Thực hiện đầy đủ hồ sơ, bệnh án, xét nghiệm.

Thực hiện nghiêm túc y lệnh về thuốc trước mổ; dịch truyền, kháng sinh.

Thực hiện đúng quy tắc lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán và theo dõi bệnh.

Theo dõi sự tiến triển của các triệu chứng lâm sàng.

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC NGƯỜI BỆNH

Nhận định loại phẫu thuật: đại phẫu hay tiểu phẫu, đơn giản hay phức tạp, có biến chứng hay không biến chứng, cắt tử cung bán phần hoặc cắt tử cung hoàn toàn… mổ nội soi hay mở bụng?

Thời gian phẫu thuật kéo dài bao lâu? Gây mê hay gây tê?

Thời gian nhận bệnh giờ thứ mấy hoặc ngày thứ mấy sau phẫu thuật?

Toàn trạng của người bệnh: toàn trạng, tri giác và dấu hiệu sinh tồn.

KHÁM CƠ THỂ NGƯỜI BỆNH

Tình trạng vết mổ: khô hay có dịch, có máu…

Khám bụng: bụng mềm hay chướng, có phản ứng, có điểm đau…

Ra máu âm đạo: nếu có cần xác định vị trí, số lượng, màu sắc…

Khả năng vận động: tùy theo thời gian sau mổ, toàn trạng người bệnh để đánh giá vận động phù hợp hay chưa.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp chưa.

Các xét nghiệm cần làm.

Y lệnh của bác sĩ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ rối loạn hô hấp sau gây mê nội khí quản.

Nguy cơ liệt ruột do vận động kém.

Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng.

Nguy cơ xảy ra biến chứng.

Người bệnh lo lắng về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Theo dõi tổng trạng, tri giác và dấu hiệu sinh tồn.

Vận động sớm sau mổ.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh.

Phòng ngừa xảy ra biến chứng.

Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

THEO DÕI TỔNG TRẠNG, TRI GIAC VA DẤU HIỆU SINH TỒN

Theo dõi tình trạng chướng bụng, buồn nôn, nôn, trung tiện, đại tiện; chế độ dinh dưỡng, nước, điện giải phù hợp bệnh; đảm bảo thông đường thở tốt, hút đàm dãi (nếu có).

Theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp.

VẬN DỘNG SỚM SAU MỔ

Chế độ vận động sớm: vận động ngay khi tỉnh bằng cách thay đổi tư thế, co chân duỗi tay.

Ngồi dậy, đi lại tùy thuộc từng người bệnh hoặc từng phẩu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

CHẾ DỘ DINH DƯỠNG PHU HỢP CHO NGƯỜI BỆNH

Cho người bệnh uống nước đường hoặc nước có gas.

Khi trung tiện được cho người ăn cháo.

Ăn uống tăng dần theo khả năng dung nạp và y lệnh; cá thể hóa lượng dịch và biện pháp phòng táo bón.

PHÒNG NGỪA XẢY RA BIẾN CHỨNG

Chế độ vệ sinh phù hợp với thời gian sau mổ; vệ sinh toàn thân, vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, làm thuốc âm đạo (nếu có chỉ định). Chăm sóc tiết niệu: có tắt ống thông không, nước tiểu, số lượng, màu sắc. Nếu không có ống thông tiểu theo dõi tình trạng tiểu tiện, số lần đi tiểu, số lượng, màu sắc…

Thực hiện y lệnh cụ thể.

Theo dõi các biến chứng sau mổ: bệnh có biến chứng liên quan đến vô cảm như rối loạn hô hấp, tụt huyết áp hay phẩu thuật: chảy máu, nhiễm trùng.

NGƯỜI BỆNH THIẾU KIẾN THỨC VỀ BỆNH

Động viên người bệnh, tránh lo lắng quá mức, trao đổi với người bệnh về tiến triển của người bệnh hằng ngày để người bệnh an tâm điều trị.

Trao đổi với người bệnh về công việc người điều dưỡng, sự phối hợp của người bệnh hoặc người thân của họ.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Hướng dẫn bệnh nhân xoay trở tại giường, vận động sớm khi giảm đau vết mổ.

Hướng dẫn ăn uống đủ chất, nâng dỡ thể trạng.

Hướng dẫn tư thế nằm đỡ đau vết mổ.

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, theo dõi dịch ra âm đạo.

Tái hám theo lịch hẹn.

Hướng dẫn ngươi bệnh khi có chảy máu âm đạo, sốt, dịch hôi thì phải đến cơ sở y tế ngay.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ra máu nhiều, dấu thiếu máu hoặc giảm tưới máu; sau mổ có đau tăng, bí tiểu hoặc nhiễm trùng cần báo bác sĩ và nhận định lại.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu

hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Tình trạng người bệnh tốt dần lên, ăn uống tốt, tinh thần thoải mái, đi lại tốt, tình trạng vết mổ tốt, không có chảy máu hoặc nhiễm khuẩn là tiến triển tốt.

Người bệnh có biểu hiện liệt ruột kéo dài, bí tiểu, chảy máu, sốt hoặc có bất kỳ bất thường nào cần báo cáo ngay bác sĩ có chế độ điều chỉnh phù hợp.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

64 Quy trình chăm sóc nhau tiền đạo

Mã đề xuất QTCS-64. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Yếu tố tinh thần của thai phụ và gia đình.

Điều kiện sống, sinh hoạt hàng ngày, phong tục tập quán như đẻ nhiều lần, đẻ dày, nạo hút thai nhiều lần.

Nhận định toàn trạng: da niêm mạc, dấu hiệu sinh tồn....

Tính chất chất chảy máu của nhau tiền đạo và hậu quả của nó đối với mẹ và con.

Tình trạng thai nhi trong tử cung và sự phát triển của thai nhi.

Tình trạng dinh dưỡng của thai phụ để nâng cao và duy trì sức khỏe của thai phụ và thai nhi.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM BỆNH NHÂN

Nghi hoặc xác định nhau tiền đạo: không thăm âm đạo bằng tay; báo bác sĩ sản khoa đánh giá và siêu âm theo chỉ định. Không dùng thăm khám để xác định vị trí nhau.

Thực hiện y lệnh trong chăm sóc và điều trị thai phụ bị rau tiền đạo.

Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm.

Vấn đề vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài.

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu chảy máu và mổ lấy thai để cầm máu.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Lo lắng do ra huyết, thiếu máu do rau bám không đúng vị trí.

Nguy cơ thai kém phát triển, đẻ non do mất máu.

Nguy cơ nhiễm khuẩn do chảy máu.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Trấn an, giải thích cho thai phụ an tâm, nêu ra những trường hợp giống như thai phụ.

Đề phòng và phát hiện sớm thai kém phát triển, đẻ non do mất máu.

Đề phòng và phát hiện sớm chảy máu do nhiễm khuẩn.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. TRẤN AN, GIẢI THÍCH CHO THAI PHỤ AN TÂM, NÊU RA NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIỐNG NHƯ THAI PHỤ

Trấn an, giải thích cho thai phụ an tâm, giải thích trấn an cho thai phụ biết cũng có nhiều trường hợp giống như chị, chị hãy an tâm điều trị rồi cũng sẽ ổn.

2. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM THAI KÉM PHÁT TRIỂN, ĐẺ NON DO MẤT MÁU

Hướng dẫn khám thai định kỳ, cân nặng, đo chiều cao tử cung và vòng bụng để phát hiện sớm thai kém phát triển.

Theo dõi hiện tượng chảy máu bằng cách hướng dẫn đóng băng vệ sinh để theo dõi lượng máu mất.

Hướng dẫn chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng, chống táo bón, bù đủ các yếu tố vi lượng như: Thịt, trứng, cá ba sa, cam, nho, rau muống.....

Theo dõi dấu hiệu đau bụng, cơn go tử cung.

Thực hiện thuốc theo y lệnh.

3. ĐỀ PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM CHẢY MÁU DO NHIỄM KHUẨN

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Hướng dẫn thay băng vệ sinh ngày 02 lần và khi cần.

Nếu thấy huyết ra âm đạo hôi báo nhân viên y tế.

Hướng dẫn vệ sinh bộ phận sinh dục ngày 02 lần và mỗi khi đi tiểu phải rửa và lau khô.

4. GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Không làm việc nặng.

Uống những thức ăn có màu đỏ: thịt bò, thịt heo.....

Uống viên sắt.

Khi có bất thường phải đi khám ngay như: đau bụng, ra huyết.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Chảy máu thai kỳ khi nghi nhau tiền đạo: gọi đội sản khoa, chuẩn bị hồi sức và máu; không thăm âm đạo bằng tay.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Thai phụ đỡ lo lắng, ăn ngủ được.

Thai phát triển tốt.

Thai phụ không thiếu máu, không bị nhiễm khuẩn.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

65 Quy trình chăm sóc vỡ tử cung

Mã đề xuất QTCS-65. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Bệnh nữ, tuổi, para,…

Tổng trạng, da niêm mạc.

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM NGƯỜI BỆNH

Không nghe thấy tim thai và các cử động của thai…

Tình trạng mất máu và dấu hiệu sốc mất máu và hiện tượng chảy máu ra ngoài và chảy vào trong ổ bụng.

Khả năng cấp cứu của bệnh viện để có biện pháp thích ứng nhằm cứu sống và ổn định tư tưởng cho gia đình và thai phụ.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Choáng do đau và mất máu.

Tin thần thai phụ và gia đình lo lắng.

Nguy cơ tử vong do không cấp cứu kịp thời.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau và mất máu.

Trấn an cho thai phụ và gia đình.

Tránh các nguy cơ cho thai phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

GIẢM ĐAU VÀ MẤT MÁU

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn và đánh giá mức độ mất máu, mức độ tổn thương do vỡ tử cung.

Thực hiện hồi sức tích cực và theo dõi tình trạng mất máu và khả năng đáp ứng hồi sức và dự trù máu.

TRẤN AN CHO THAI PHỤ VÀ GIA ĐÌNH

Thông báo cho người nhà biết tình trạng nặng của thai phụ để phối hợp cứu chữa kịp thời.

Thông báo với gia đình thai phụ về sự cần thiết phải phẫu thuật, động viên thai phụ và người nhà phối hợp trong quá trình chăm sóc thai phụ trước và sau phẫu thuật.

TRÁNH CÁC NGUY CƠ CHO THAI PHỤ

Chuyển mổ ngay sau khi đã làm đầy đủ phần phẫu thuật.

Di chuyển thai phụ đang trong tình trạng sốc mất máu.

Thực hiện y lệnh khẩn trương chính xác.

Thông báo ngay cho khoa gây mê hồi sức để tiếp đón bệnh kịp thời, nhanh chống.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Ăn những thức ăn, thức uống dễ tiêu như: cháo, trà đường ấm...

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân và đặt băng vệ sinh.

Nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường.

Hướng dẫn theo dõi lượng huyết ra âm đạo nhiều báo nhân viên y tế.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Nghi vỡ tử cung là cấp cứu: gọi đội sản khoa, hồi sức và gây mê, chuẩn bị phẫu thuật; không chờ hoàn tất mọi xét nghiệm.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Kết quả tốt hay xấu tùy thuộc vào:

Khả năng chẩn đoán vỡ tử cung.

Khả năng xử trí khẩn trương.

Khả năng hồi sức và chăm sóc trước, trong và sau khi mổ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy

trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

66 Quy trình chăm sóc thai phụ nhau bong non

Mã đề xuất QTCS-66. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

KHAI THÁC TIỀN SỬ

Tiền sử: tiền sử bệnh tật, điều kiện sống, điều kiện lao động. Tiền sử thai nghén.

Sự hiểu biết của thai phụ về nhau bong non.

Mức độ lo lắng, mức độ khó chịu của thai phụ.

Toàn trạng thai phụ: màu sắc da, niêm mạc, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng ra máu âm đạo.

KHAI THÁC QUA THĂM KHÁM BỆNH NHÂN

Tính chất đau bụng: thời gian đau, tần số cơn đau, mức độ đau, vị trí đau.

Cơn go tử cung: thời gian, tần số, cường độ, trương lực của cơ tử cung ngoài cơn go.

Nhịp tim thai: sự thay đổi nhịp tim thai.

Sự thay đổi chiều cao tử cung, vòng bụng.

Thực hiện y lệnh trong chăm sóc và điều trị thai phụ nhau bong non.

Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm.

Vấn đề vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài.

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu chảy máu và mổ lấy thai để cầm máu.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ choáng do mất máu nhiều.

Đau go nhau bong non gây ra.

Nguy cơ mổ lấy thai.

Lo lắng về tình trạng bệnh.

Nguy cơ suy thai do nhau bong non.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Phòng và phát hiện sớm mất máu.

Giảm đau do nhau bong non gây ra.

Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ.

Giảm lo lắng cho thai phụ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

PHÒNG VÀ PHÁT HIỆN SỚM MẤT MÁU

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, màu sắc da, niêm mạc.

Theo dõi lượng huyết ra âm đạo, số lượng, màu sắc, tính chất.

Thực hiện thuốc theo y lệnh.

Truyền dịch.

Báo bác sĩ nếu có sự thay đổi toàn trạng.

GIẢM ĐAU DO NHAU BONG NON GÂY RA

Thực hiện thuốc theo y lệnh.

Hướng dẫn thai phụ các phương pháp giảm đau như thay đổi tư thế, thư giãn, cách thở.

Theo dõi cơn go tử cung, nếu thấy cơn go nhiều và co cứng của tử cung thì báo ngay cho bác sĩ để giải quyết kịp thời.

CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN TRƯỚC MỔ

Chuẩn bị thai phụ làm vệ sinh vùng sinh dục ngoài, vệ sinh thân thể, vùng mổ.

Hướng dẫn ký cam đoan.

Chuẩn bị các phương tiện cấp cứu, hồi sức cho trẻ.

GIẢM LO LẮNG CHO THAI PHỤ

Giải thích cho thai phụ và gia đình hiểu rõ hơn về nhau bong non.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi tiếp cơn đau bụng và huyết ra âm đạo báo cho nhân viên y tế.

Trấn an và động viên thai phụ hãy an tâm điều trị vì cũng có người giống như mình cũng sẽ ổn.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Ăn những thức ăn, thức uống dễ tiêu như: cháo, trà đường ấm...

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân và đặt băng vệ sinh.

Nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường.

Hướng dẫn theo dõi cơn go tử cung đau nhiều ngày một tăng dần bụng cứng đờ như gỗ.

Hướng dẫn theo dõi lượng huyết ra âm đạo nhiều báo nhân viên y tế.

Về phía bé:

Phòng và phát hiện sớm suy thai do nhau bong non.

Theo dõi sát tim thai.

Hướng dẫn thai phụ theo dõi cử động thai.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau bụng, tử cung tăng trương lực, bất thường tim thai hoặc dấu sốc: gọi cấp cứu; lượng máu ngoài có thể ít, không dùng để loại trừ mất máu nặng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Chăm sóc tốt:

Thai phụ không mất máu.

Thai phụ đỡ đau.

Chuẩn bị trước mổ tốt.

Thai phụ đỡ lo lắng.

Chăm sóc không tốt:

Thai phụ mất máu.

Thai phụ không đỡ đau.

Chưa chuẩn bị bệnh tốt.

Thai phụ còn lo lắng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Chăm sóc hồi sức và cấp cứu

67 Quy trình chăm sóc bệnh đau thắt ngực

Mã đề xuất QTCS-67. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau ngực do mất cân bằng cung - cầu oxy cơ tim.

Lo lắng do thay đổi tình trạng sức khoẻ.

Người bệnh không biết cách ngăn ngừa cơn đau do thiếu kiến thức về bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Làm mất cơn đau ngực.

Giảm lo lắng cho người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh cách ngăn ngừa cơn đau.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Nhanh chóng làm mất cơn đau.

Ngay lập tức có mặt bên người bệnh để người bệnh yên lòng, góp phần làm giảm cơn đau.

Để người bệnh nằm nghỉ nhằm làm giảm tiêu thụ oxy cơ tim, góp phần làm giảm cơn đau.

Thực hiện thuốc theo y lệnh.

Theo dõi huyết áp (vì các thuốc cắt cơn đau có thể gây hạ huyết áp).

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc (nếu có thì giải thích để người bệnh yên tâm).

Theo hiệu quả của thuốc cắt cơn đau (sau khi dùng thuốc bao lâu thì cơn đau mất, nếu cơn đau không mất hoặc mất rồi lại xuất hiện thì phải báo ngay cho thầy thuốc).

Ghi điện tâm đồ hoặc theo dõi điện tâm đồ trên monitor và thực hiện một số xét nghiệm theo y lệnh.

Làm giảm lo lắng cho người bệnh.

Có mặt bên người bệnh càng nhiều càng tốt đặc biệt trong lúc có cơn đau, giúp người bệnh an tâm bớt lo lắng.

Cung cấp một số thông tin về bệnh trên cơ sở đó giải thích cho người bệnh an tâm.

Thực hiện thuốc an thần theo y lệnh (nếu có).

Thực hiện đầy đủ nhanh chóng các xét nghiệm hoặc thăm dò cận lâm sàng theo y lệnh.

Hướng dẫn người bệnh cách ngừa cơn đau.

Phát hiện các yếu tố làm khởi phát cơn đau để loại bỏ.

Loại bỏ hoặc hạn chế các yếu tố nguy cơ như: kiềm chế trọng lượng không để thừa cân, bỏ thuốc lá, điều trị tăng huyết áp nếu có, tránh các sang chấn tâm lý, tránh các sang chấn tâm lý.

Uống thuốc ngừa cơn đau theo y lệnh của thầy thuốc.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau ngực mới hoặc kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, ngất hoặc huyết động bất ổn: gọi bác sĩ, ghi thời điểm và ECG theo phác đồ, chuẩn bị cấp cứu.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hết đau ngực, hết lo lắng.

Biết cách ngăn ngừa cơn đau.

Biết cách đối phó với cơn đau khi nó xảy ra.

Biết thay đổi lối sống cho phù hợp với bệnh.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

68 Quy trình chăm sóc bệnh nhịp nhanh trên thất

Mã đề xuất QTCS-68. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân lo lắng, hồi hộp do rối loạn nhịp tim.

Đau đầu chóng mặt do thiếu máu.

Nguy cơ tử vong do điều trị không có hiệu quả.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Chăm sóc về tinh thần.

Tư thế nằm của bệnh nhân.

Chuẩn bị các loại thuốc chống loạn nhịp tim thông thường.

Chuẩn bị máy ghi điện tim: máy điện tim, giấy ghi, kem bôi.

Chuẩn bị truyền dịch.

Chuẩn bị máy làm sốc điện, máy tạo nhịp tim, ống nghe, máy đo huyết áp, máy monitor.

Chuẩn bị các dụng cụ bảo đảm thông khí: oxy, ống thông mũi, bóng ambu, máy hô hấp nhân tạo, ống nội khí quản.

Thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.

Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.

Giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Chăm sóc cơ bản:

Động viên, trấn an bệnh nhân vì bệnh nhân bị thường hay lo sợ, hốt hoảng.

Đặt bệnh nhân nằm trên giường, mặc áo không cài khuy hoặc cởi áo, nằm đầu cao.

Đánh giá SpO2, khó thở và chỉ định oxy; chọn dụng cụ, lưu lượng và mục tiêu theo phác đồ, theo dõi đáp ứng, không cố định 4–6 lít/phút.

Chuẩn bị tấm ván cứng để khi cần làm ép tim ngoài lồng ngực.

Đếm nhịp tim trong 1 phút, bắt mạch so sánh với nhịp tim.

Đo huyết áp, đếm nhịp thở, tính lượng nước tiểu.

Ghi điện tim.

Sau đó nối máy theo dõi điện tim (monitor).

Thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi:

+ Ăn nhẹ, ăn nhạt (súp nóng, cháo đường, sữa...).

+ Chăm sóc tại giường toàn diện.

2. Thực hiện y lệnh của bác sĩ:

Làm các xét nghiệm máu: urê, đường, điện giải, pH máu và các khí trong máu.

Chuẩn bị máy làm sốc điện, máy tạo nhịp tim.

Dụng cụ thở oxy.

Bóng ambu, máy hô hấp nhân tạo, ống nội khí quản.

Thuốc chống loạn nhịp tim.

3. Theo dõi:

Các dấu hiệu sinh tồn, chú ý nhịp tim về tần số và biên độ.

Tình trạng tinh thần của bệnh nhân.

Số lượng nước tiểu.

Các biến chứng hay các diễn biến mới xuất hiện.

4. Giáo dục sức khoẻ:

Giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân và gia đình biết về tình trạng bệnh tật, tiến triển và các biến chứng có thể xảy ra cũng như cách phòng bệnh.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Nhịp nhanh kèm tụt huyết áp, đau ngực, khó thở hoặc giảm tri giác: gọi đội cấp cứu, chuẩn bị monitor và xử trí rối loạn nhịp theo chỉ định.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Kết quả tốt nếu:

Nhịp tim đang nhanh hay chậm nay trở về bình thường khi ngừng điều trị.

Huyết áp trở lại bình thường.

Bệnh nhân tỉnh táo, bớt lo sợ, hết vật vã và hốt hoảng.

Nhịp thở chậm lại.

Số lượng nước tiểu tăng lên.

Kết quả xấu cần tăng cường chăm sóc.

Nhịp tim vẫn nhanh, chậm hay không trở về bình thường sau khi ngừng điều trị.

Huyết áp không lên hay không ổn định.

Ý thức xấu.

Tình trạng vô niệu.

Rối loạn nhịp thở hoặc thở Cheynes Stoke.

Cần lập lại kế hoạch chăm sóc và báo ngay cho bác sĩ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

69 Quy trình chăm sóc bệnh nhồi máu cơ tim cấp

Mã đề xuất QTCS-69. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau ngực do tổn thương cơ tim.

Giảm lượng máu từ tim đến cơ quan tổ chức .

Giảm trao đổi khí do ứ huyết ở phổi.

Người bệnh lo lắng do thay đổi tình trạng sức khỏe.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Nhanh chóng làm mất cơn đau.

Cải thiện được tưới máu tổ chức.

Người bệnh sẽ hết khó thở.

Người bệnh hiểu biết về bệnh và tuân thủ trình tự chăm sóc.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Nhanh chóng làm mất cơn đau.

Giữ người bệnh nằm bất động.

Dùng giảm đau theo y lệnh sau đánh giá huyết áp, hô hấp và chống chỉ định; không dùng morphin mặc định.

Thực hiện y lệnh thuốc một số thuốc có tác dụng giãn động mạch vành để cung cấp oxy cho cơ tim như Nitroglycerin.

Cho oxy khi thiếu oxy hoặc có chỉ định lâm sàng phù hợp; theo dõi đáp ứng, không dùng oxy thường quy chỉ để giảm đau ngực khi không thiếu oxy.

Theo dõi cơn đau ngực và điện tâm đồ liên tục.

Cải thiện tưới máu tổ chức.

Nghỉ ngơi thỏa đáng nhằm làm giảm tần số tim và gián tiếp cải thiện lưu lượng tim.

Theo dõi các dấu hiệu cải thiện lưu lượng máu từ tim tới tổ chức:

Tần số tim trở về bình thường.

Hết hoặc không có loạn nhịp.

Huyết áp tâm thu đạt mức bình thường.

Lượng nước tiểu tăng đạt mức bình thường.

Người bệnh hết đau ngực.

Đỡ mệt nhọc.

Cải thiện trao đổi khí ở phổi:

Cho người bệnh nằm ở tư thế nửa ngồi .

Cho người bệnh thở oxy theo y lệnh.

Khi hết đau ngực, hướng dẫn người bệnh tập thở sâu và thường xuyên thay đổi tư thế để cải thiện thông phổi khí.

Tăng cường hiểu biết cho người bệnh và giáo dục sức khỏe.

Hướng dẫn người bệnh cách tập luyện tập để phục hồi sau nhồi máu cơ tim.

Loại bỏ tất cả hoạt động gây đau ngực: gắng sức, lạnh đột ngột, ăn quá no, ăn bữa lớn, xúc cảm đột ngột.

Khuyên người bệnh ngủ đầy đủ, ăn chận rãi, ăn bữa nhỏ, nghỉ ngơi thỏa đáng sau bữa ăn, tránh các chất kích thích tim mạch.

Hạn chế đến mức tối đa hoặc loại bỏ tất cả các yếu tố nguy cơ: kiểm soát huyết áp, kiểm soát trọng lượng, bỏ thuốc lá, điều chỉnh lipid máu.

Mang theo nigtroglycerin và ngậm ngay một viên dưới lưỡi để cắt cơn đau.

Đưa thầy thuốc ngay nếu có một trong các biểu hiện như cơn đau không mất sau ngậm thuốc, xuất hiện khó thở, mạch quá nhanh hay quá chậm.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ghi giờ khởi phát đau và báo đội cấp cứu ngay; phối hợp ECG, xét nghiệm và kế hoạch tái tưới máu, không để chăm sóc thường quy trì hoãn xử trí.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Hết đau ngực và cơn đau không tái diễn.

Cải thiện được tưới máu tổ chức.

Hết khó thở.

Tăng dần được hoạt động mà không mệt và đau ngực.

Hết lo lắng.

Biết tự chăm sóc sau khi ra viện.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

70 Quy trình chăm sóc bệnh nhồi máu não

Mã đề xuất QTCS-70. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

1. Mất khả năng vận động do liệt.

2. Khả năng giao tiếp bằng lời giảm do nhồi máu não.

3. Nguy cơ tổn thương do tì đè liên quan giảm vận động và các yếu tố thực tế được nhận định.

4. Nguy cơ nhiễm trùng hô hấp do nằm lâu.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Chăm sóc cơ bản:

Để bệnh nhân nghỉ ngơi, nằm ở tư thế đầu cao, nằm nghiêng về một bên.

Giải thích cho bệnh nhân và gia đình về tình trạng bệnh tật.

Lập kế hoạch dinh dưỡng theo khả năng nuốt và chỉ định, chưa cho ăn uống trước sàng lọc nuốt.

Vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

Hướng dẫn gia đình tự theo dõi các tác dụng phụ của thuốc, biểu hiện bất thường.

2. Thực hiện các y lệnh:

Dùng thuốc theo y lệnh; đường uống chỉ khi nuốt an toàn đã được đánh giá, phối hợp bác sĩ chọn đường dùng khác khi cần.

Làm các xét nghiệm cơ bản.

3. Theo dõi:

Tình trạng tai biến mạch máu não: tinh thần, vận động...

Theo dõi các nguyên nhân gây tai biến mạch máu não.

Theo dõi một số xét nghiệm như: bilan lipid máu, điện tim, siêu âm, soi đáy mắt.

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc.

Theo dõi các biến chứng.

4. Giáo dục sức khoẻ.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Thực hiện chăm sóc cơ bản:

Đặt bệnh nhân nằm nghỉ ngơi đầu cao và nghiêng về một bên.

Tránh lao động trí óc căng thẳng, lo lắng quá độ.

Phối hợp phục hồi chức năng theo tình trạng ổn định và chỉ định; không xoa bóp vùng da đỏ hoặc vùng có nguy cơ tổn thương tì đè.

Thay đổi tư thế mỗi 2 giờ/lần.

Động viên, trấn an bệnh nhân để bệnh nhân an tâm điều trị.

Theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, đặc biệt là tình trạng tăng huyết áp. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể để theo dõi có thể từ 15 phút cho đến 2 giờ đo một lần.

Hút đờm dãi khi có ứ đọng đờm dãi.

Luôn giữ ấm cơ thể bệnh nhân.

Trước bất kỳ thức ăn, nước hoặc thuốc đường miệng: sàng lọc nuốt bởi nhân viên được đào tạo. Nếu không an toàn, báo bác sĩ và áp dụng phương án dinh dưỡng, đường dùng thuốc được chỉ định; kiểm tra vị trí ống trước sử dụng theo quy trình.

Tránh các yếu tố kích thích cho bệnh nhân.

Vệ sinh sạch sẽ: hàng ngày vệ sinh răng miệng và da để tránh các ổ nhiễm khuẩn, phát hiện sớm các ổ nhiễm trùng để có hướng điều trị cho bệnh nhân. áo quần, vải trải giường và các vật dụng khác phải luôn được sạch sẽ.

Đánh giá nguy cơ tì đè, dùng bề mặt hỗ trợ và đổi tư thế cá thể hóa; không xoa bóp để phòng loét. Chăm sóc miệng, giảm nguy cơ sặc và quản lý ống thông; vỗ rung chỉ khi có chỉ định phù hợp.

2. Thực hiện các y lệnh:

Thuốc dùng: thực hiện đầy đủ các y lệnh khi dùng thuốc, như: các thuốc tiêm, thuốc uống. Trong quá trình dùng thuốc nếu có bất thường phải báo bác sĩ biết.

Thực hiện các xét nghiệm: công thức máu, đường máu, ure và creatinin máu, điện tim, protein niệu, soi đáy mắt và chụp X quang tim phổi.

3. Theo dõi:

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở phải được theo dõi kỹ.

Theo dõi tình trạng liệt.

Theo dõi tình trạng thông khí.

Theo dõi tình trạng loét ép do nằm lâu.

Tình trạng tổn thương mắt, thận và tim mạch.

Tình trạng sử dụng thuốc và các biến chứng do thuốc gây ra, đặc biệt chú ý các thuốc có thể gây hạ huyết áp mạnh.

Các di chứng của nhồi máu não.

4. Giáo dục sức khoẻ:

Bệnh nhân và gia đình cần phải biết các nguyên nhân, các yếu tố thuận lợi gây nhồi mạch máu não cũng như cách phát hiện các hiệu dấu nhồi máu não, cách phòng, điều trị và theo dõi bệnh nhân .

Phòng bệnh cấp 0:

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ, song đáng chú ý nhất là tăng huyết áp và xơ vữa động mạch, rất thường gặp ở lứa tuổi từ 50 trở lên, nên có thông tin rộng rãi để các đối tượng trên theo dõi huyết áp đều đặn và áp dụng các biện pháp phòng tăng huyết áp như tránh ăn mặn, hạn chế những căng thẳng về mặt tinh thần, tránh ăn nhiều gây mập phì, tránh các chất kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá, tránh gió lùa, mặc ấm khi thay đổi thời tiết, nhất là từ nóng chuyển sang lạnh, đang nằm trong chăn ấm tránh ra lạnh đột ngột.

Ngoài ra cần phòng thấp tim một cách hiệu quả nhưtránh ở nơi ẩm thấp, giữ ấm khi trời lạnh để tránh viêm họng, khi bị thấp tim phải được theo dõi và điều trị đúng để tránh tổn thương van tim.

Phòng bệnh cấp 1:

Điều trị dự phòng tái phát theo nguyên nhân và y lệnh bác sĩ. Không tự dùng aspirin hoặc chống đông trước khi loại trừ xuất huyết não, hoặc chỉ vì có xơ vữa; ghi thuốc và theo dõi nguy cơ chảy máu.

Phòng bệnh cấp 2:

Khi đã xảy ra tai biến nhất là tai biến thoáng qua phải tìm các yếu tố nguy cơ trên để can thiệp tránh xảy ra tai biến hình thành. Nếu đã xảy ra tai biến hình thành thì tránh tái phát bằng cách điều trị các bệnh nguyên cụ thể cho từng cá thể.

Phòng bệnh cấp 3:

Phối hợp phục hồi chức năng, đổi tư thế và bề mặt giảm áp phù hợp; hướng dẫn gia đình thực hành an toàn. Không xoa bóp da để phòng tổn thương do tì đè.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ghi giờ cuối còn bình thường và giờ phát hiện triệu chứng; báo đội đột quỵ, kiểm tra đường huyết, không cho đường miệng trước sàng lọc nuốt.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Tình trạng bệnh nhân sau khi đã thực hiện y lệnh, thực hiện kế hoạch chăm sóc so với lúc ban đầu của người bệnh để đánh giá tình hình bệnh tật:

Đánh giá công tác chăm sóc và thực hiện các y lệnh đối với bệnh nhân.

Đánh giá tình trạng liệt có cải thiện không.

Đánh giá tình trạng ý thức.

Đánh giá tình trạng huyết áp.

Đánh giá các di chứng của tai biến mạch máu não.

Đánh giá về tinh thần, vận động.

Đánh giá tình trạng thông khí.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [18] NICE NG128 Stroke and transient ischaemic attack in over 16s recommendations, [19] NICE CG179 Pressure ulcers prevention and management, [24] NICE CG32 Nutrition support for adults recommendations. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

71 Quy trình chăm sóc bệnh phù phổi cấp

Mã đề xuất QTCS-71. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Khó thở dữ dội do giảm trao đổi khí.

Da xanh tái, vã mồ hôi, vạt vã do thiếu oxy.

Ho, khạc bọt hồng do phù phổi cấp.

Vô niệu và thiểu niệu do giảm thể tích tuần hoàn.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Thống nhất mục tiêu cho các vấn đề bên dưới, chỉ số theo dõi, mốc đánh giá và người phụ trách; ghi kế hoạch riêng của mẹ và trẻ khi có cả hai đối tượng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Làm giảm nguy cơ thiếu oxy máu:

- Tư thế người bệnh: cho bệnh ngồi buông thong hai chân hoặc nằm đầu giường nâng cao >450 Mục đích là làm giảm lượng máu tĩnh mạch về tim, giảm ứ trệ ở phổi. Tuy nhiên không nên thực hiện điều này nếu người bệnh tụt huyết áp do sẽ giảm lượng máu tới não.

- Thường xuyên theo dõi các dấu hiệu như khó thở, tím, PaCO2, SaO2 máu động mạch, các triệu chứng thần kinh để báo bác sĩ kịp thời.

- Cho thở oxy theo y lệnh. Hút đàm khi có tăng tiết.

- Nghỉ ngơi thỏa đáng. Tránh di chuyển người bệnh trong giai đoạn cấp tính.

Thực hiện thuốc theo nguyên nhân, huyết áp, chức năng thận và y lệnh; không đưa morphin thành điều trị thường quy phù phổi cấp. Theo dõi huyết động, hô hấp và đáp ứng sau thuốc.

2. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng:

- Khi đã qua cơn khó thở cho bệnh ăn nhẹ, thức ăn dễ tiêu: sữa, nước ép trái cây, súp,…

- Cho bệnh ăn đủ calo, tăng đạm, tăng vitamin, hạn chế muối khi có suy tim.

- Động viện người bệnh tăng cường bữa ăn.

- Chế biến thức ăn hợp khẩu vị.

- Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, tạo cảm giác ngon miệng.

- Nếu khó thở chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa để tránh căng dạ dày.

3. Giảm kích thích và lo lắng cho người bệnh:

- Chú ý theo dõi và phát hiện kịp thời tình trạng lo lắng của người bệnh. Người bệnh lo lắng sẽ kém hợp tác với điều trị và càng dễ khó thở, suy hô hấp nặng hơn.

- Điều dưỡng phải giữ thái độ bình tĩnh, tác phong nhanh nhẹn, thao tác chính xác và luôn có mặt để người bệnh yên tâm.

Giải thích, hỗ trợ tâm lý; thuốc an thần chỉ dùng theo chỉ định, theo dõi nguy cơ giảm hô hấp và tụt huyết áp.

4. Tư vấn giáo dục sức khỏe:

- Hạn chế đến mức tối đa các yếu tố nguy cơ: môi trường, thuốc lá, thói quen, lối sống tiêu cực hàng ngày.

- Hướng dẫn người bệnh điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn đường hô hấp.

- Khuyên người bệnh ăn uống, bồi dưỡng, tập luyện đúng mức để nâng cao thể trạng và tăn sức đề kháng.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay nếu có các biểu hiện như: khó thở, mệt, ho nhiều …

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở tăng, SpO2 giảm hoặc tụt huyết áp: gọi cấp cứu, chuẩn bị hỗ trợ thông khí theo chỉ định và theo dõi đáp ứng; không để thuốc an thần làm che lấp suy hô hấp.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh được đánh giá là điều trị và chăm sóc tốt khi:

- Tình trạng hô hấp được cải thiện.

- Không bị các biến chứng,cải thiện được dinh dưỡng.

- Biết thay đổi lối sống cho phù hợp với bệnh.

- Người bệnh được chăm sóc chu đáo cả về thể chất và tinh thần.

- Các dấu hiệu sinh tồn, xét nghiệm được theo dõi và ghi chép đầy đủ.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [23] AARC Management of adult patients with oxygen in the acute care setting 2022. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

72 Quy trình chăm sóc sốc nhiễm khuẩn

Mã đề xuất QTCS-72. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Tụt huyết áp (huyết áp tối đa dưới 90 mmHg).

Dấu hiệu thiếu oxy tổ chức do sốc:

Tình trạng giảm tuần hoàn não: vật vã, giãy giụa.

Tình trạng giảm tuần hoàn thận: đái ít.

Tình trạng giảm tuần hoàn ngoại biên: đầu chi lạnh.

Tình trạng lo lắng, sợ hãi do sốc.

Tình trạng suy hô hấp.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Tăng cường tuần hoàn tới các cơ quan.

Làm thông thoáng đường hô hấp.

Thực hiện y lệnh.

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Chăm sóc toàn thân, nuôi dưỡng và giáo dục sức khoẻ.

Giảm lo lắng, sợ hãi.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

Tăng cường tuần hoàn tới các cơ quan:

Cầm máu (nếu chảy máu).

Chọn tư thế theo huyết động, hô hấp và nguy cơ sặc; không đặt đầu thấp thường quy để hồi sức sốc.

Thiết lập đường truyền, truyền dịch theo y lệnh và đánh giá lại đáp ứng, dấu quá tải sau can thiệp. Chuẩn bị hỗ trợ đường truyền trung tâm khi có chỉ định; không trì hoãn hồi sức để chờ đặt catheter.

Làm thông thoáng đường hô hấp:

Hút đờm dãi, đặt canuyn để phòng tụt lưỡi.

Cho thở oxy.

Phụ bác sĩ đặt nội khí quản, thở máy trong các trường hợp sốc nặng.

Thực hiện y lệnh.

Thuốc và các xét nghiệm đầy đủ và chính xác.

Đặt sonde bàng quang để theo dõi lượng nước tiểu, tiên lượng sốc.

Ống thông dạ dày chỉ đặt khi có chỉ định phù hợp, cân nhắc nguy cơ và xác nhận vị trí; không dùng thường quy để chẩn đoán chảy máu hoặc xử trí sốc.

Theo dõi liên tục các thông số:

Huyết áp, mạch.

Theo dõi tưới máu, tri giác, huyết áp, nước tiểu, lactate khi được chỉ định và đáp ứng dịch; không lấy áp lực tĩnh mạch trung tâm đơn độc để quyết định bù dịch.

Theo dõi nước tiểu từng giờ.

Đo thân nhiệt 2 đến 3 giờ/lần.

Chăm sóc toàn thân, nuôi dưỡng và giáo dục sức khoẻ:

Chăm sóc về tinh thần: nhẹ nhàng, ân cần để bệnh nhân yên tâm.

Vệ sinh thân thể cho bệnh nhân tại giường.

Phối hợp dinh dưỡng khi ổn định theo chỉ định; ưu tiên đường tiêu hóa khi khả thi, không mặc định nuôi dưỡng tĩnh mạch cho mọi người bệnh sốc.

Hướng dẫn bệnh nhân và người nhà những chăm sóc khi về gia đình.

Giảm lo lắng và sợ hãi:

Để bệnh nhân nằm nơi yên tĩnh, thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông.

Điều dưỡng luôn có mặt để theo dõi, động viên bệnh nhân.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Kích hoạt xử trí nhiễm khuẩn nặng và sốc; phối hợp lấy mẫu khi không làm chậm kháng sinh, theo dõi tưới máu và đáp ứng dịch, chuẩn bị kiểm soát nguồn nhiễm theo chỉ định.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở về bình thường.

Lượng nước tiểu và dấu tưới máu cải thiện theo cân nặng, bệnh nền và mục tiêu điều trị; không lấy 1,5 lít/24 giờ làm chuẩn cho mọi người bệnh.

Các y lệnh và xét nghiệm thực hiện đầy đủ, chính xác.

Theo dõi sát, phát hiện kịp thời các biến chứng.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [20] SCCM ESICM Surviving Sepsis Campaign adult guidelines 2026. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

73 Quy trình chăm sóc bệnh sốc phản vệ

Mã đề xuất QTCS-73. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Nguy cơ suy tuần hoàn cấp liên quan đến giãn mạch ngoại vi.

Nguy cơ suy hô hấp liên quan đến co thắt phế quản và thiếu oxy.

Người bệnh lo sợ, hoảng hốt liên quan đến các phản ứng của dị nguyên gây ra.

Nguy cơ suy thận liên quan đến tụt HA làm giảm tưới máu thận .

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Tăng cường tuần hoàn tới các cơ quan.

2. Làm thông thoáng đường hô hấp.

3. Giảm lo lắng và sợ hãi.

4. Ngăn ngừa biến chứng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Tăng cường tuần hoàn tới các cơ quan:

Chọn tư thế theo phác đồ phản vệ và biểu hiện: nằm tại chỗ, không để đứng hoặc đi lại đột ngột; điều chỉnh khi khó thở, nôn hoặc mang thai, bảo vệ đường thở.

Adrenalin là thuốc ưu tiên. Điều dưỡng, hộ sinh xử trí ban đầu và tiêm bắp ngay khi chẩn đoán phản vệ từ độ II theo phác đồ Thông tư 51/2017/TT-BYT, đồng thời gọi bác sĩ; không chờ y lệnh mới tiêm. Kiểm tra nồng độ, liều theo tuổi/cân nặng, đường tiêm và ghi giờ dùng; các đường dùng hồi sức chuyên sâu do đội cấp cứu thực hiện theo phác đồ.

Thực hiện y lệnh thuốc: thuốc chống dị ứng và các thuốc khác.

Đặt đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch theo y lệnh.

Chuẩn bị đường truyền nâng cao khi bác sĩ chỉ định; không để thủ thuật làm chậm adrenalin tiêm bắp và hỗ trợ hô hấp.

2. Làm thông thoáng đường hô hấp:

Tư thế nằm nghiêng an toàn nếu người bệnh nôn, hôn mê.

Hút đờm dãi, đặt canuyl miệng nếu người bệnh tụt lưỡi.

Bóp bóng Ambu nếu người bệnh ngừng thở hoặc thở yếu.

Cho oxy và hỗ trợ thông khí theo mức độ phản vệ, dụng cụ phù hợp và phác đồ; theo dõi SpO2, không cố định oxy mũi 4 lít/phút.

Hỗ trợ đặt nội khí quản và thở máy nếu suy hô hấp hoặc sốc nặng: chuẩn bị dụng cụ đặt nội khí quản, chuẩn bị máy thở.

3. Giảm lo lắng và sợ hãi:

Để BN nằm nơi yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông.

ĐD luôn có mặt để theo dõi, động viên BN.

Giải thích và trấn an BN.

Giữ ấm hoặc hạ nhiệt cho BN.

4. Ngăn ngừa biến chứng:

- Thực hiện y lệnh:

Thuốc và các xét nghiệm đầy đủ và chính xác.

Đặt sonde tiểu để theo dõi lưu lượng nước tiểu, tiên lượng sốc.

Đặt ống thông dạ dày chỉ khi có chỉ định phù hợp và bảo đảm an toàn, không thực hiện thường quy trong phản vệ.

- Theo dõi liên tục các thông số sau:

Theo dõi liên tục trong giai đoạn cấp, tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi thay đổi; tần suất đo cụ thể theo phác đồ phản vệ, không giảm xuống 3 giờ/lần chỉ vì huyết áp đạt 90/60.

Theo dõi đáp ứng hồi sức và tưới máu; theo dõi xâm lấn khi được chỉ định, không đo áp lực tĩnh mạch trung tâm thường quy cho mọi phản vệ.

- Theo dõi đề phòng trụy mạch:

Nhịp thở: để phát hiện và xử lý suy hô hấp kịp thời.

Đo thân nhiệt 2 – 3 giờ/lần.

Theo dõi nước tiểu từng giờ. Nếu có nước tiểu và nước tiểu tăng dần là tốt.

Chăm sóc toàn thân, nuôi dưỡng và giáo dục sức khỏe.

Chăm sóc về tinh thần: nhẹ nhàng, ân cần để BN yên tâm.

Vệ sinh thân thể cho BN tại giường.

Hướng dẫn BN và người nhà những chăm sóc khi về gia đình.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Ngừng tiếp xúc tác nhân nếu đang sử dụng, gọi hỗ trợ và tiêm bắp adrenalin theo phác đồ phản vệ; theo dõi tái diễn tại cơ sở ít nhất 24 giờ sau khi huyết áp ổn định theo Thông tư 51.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Người bệnh sốc phản vệ được chăm sóc tốt khi tình trạng lâm sàng của người bệnh được cải thiện, kiểm soát.

Phát hiện sớm các dị nguyên, cách ly hiệu quả các dị nguyên.

Người bệnh được theo dõi chặt chẽ không để xảy ra các biến chứng.

Người bệnh và gia đình yên tâm hợp tác điều trị.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [3] Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

74 Quy trình chăm sóc suy thận mạn

Mã đề xuất QTCS-74. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

3.1. Rối loạn dịch và điện giải do suy chức năng thận.

3.2. Rối loạn dinh dưỡng do chán ăn, rối loạn chức năng dạ dày ruột do chế độ ăn hạn chế.

3.3. Thay đổi trạng thái tâm lý như lo lắng, bi quan do mắc bệnh nghiêm trọng và cuộc sống bị

phụ thuộc.

3.4. Bệnh nhân thiếu hụt kiến thức về bệnh và chế độ điều trị lâu dài.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Duy trì cân bằng dịch và điện giải cho bệnh nhân.

2. Duy trì dinh dưỡng thoả đáng cho người bệnh.

3. Cải thiện trạng thái tâm lý cho bệnh nhân.

4. Tăng thêm sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh và chế độ điều trị.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Duy trì cần bằng dịch và điện giải cho bệnh nhân:

Thường xuyên đánh giá tình trạng dịch và điện giải dựa vào: xét nghiệm điện giải trong máu.

Cân nặng bệnh hàng ngày. Theo dõi, kiểm tra chế độ ăn, và lượng dịch điện giải vào bằng đường ăn uống. Theo dõi mạch, huyết áp, tần số thở.

Kiểm soát dịch và điện giải theo y lệnh, nước tiểu, phù, huyết áp, xét nghiệm và tình trạng lọc máu; không tự hạn chế tất cả người bệnh như nhau.

2. Duy trì dinh dưỡng thoả đáng cho người bệnh:

Giải thích cho bệnh hiểu tầm quan trọng của chế độ ăn trong điều trị suy thận mạn tính: hạn chế tăng các sản phẩm nitơ phi protein (urê, acid uric, creatinin). Làm chậm bước tiến của quá trình suy thận.

Phối hợp dinh dưỡng cá thể hóa theo giai đoạn bệnh, tình trạng lọc máu, suy dinh dưỡng và bệnh kèm. Không dùng khẩu phần protein 0,5 g/kg/ngày hoặc năng lượng 35–40 calo/ngày cho mọi người; bác sĩ và dinh dưỡng xác định mục tiêu và theo dõi đáp ứng.

Điều chỉnh natri theo chỉ định, phù và huyết áp; giải thích lượng muối trong khẩu phần, không đặt một mức cho mọi người bệnh.

Tổng dịch gồm uống, thức ăn và dịch truyền theo chỉ định, mất dịch, nước tiểu và lọc máu; không chỉ lấy lượng nước tiểu làm công thức uống.

Bổ sung vitamin, sắt hoặc acid folic khi có chỉ định; lựa chọn trái cây theo kali, đường huyết và khẩu phần, không khuyến khích một danh sách quả cho mọi người.

Hướng dẫn kiểm soát kali theo xét nghiệm và khẩu phần thực tế với chuyên viên dinh dưỡng; không chỉ dựa tên trái cây để xác định an toàn.

Hướng dẫn thời điểm thuốc so với bữa ăn theo từng thuốc, không tránh ăn sau mọi loại thuốc.

Vệ sinh răng miệng trước khi ăn để tăng thêm cảm giác ngon miệng,tạo không khí thoải mái vui vẻ trong bữa ăn.

Hàng ngày đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân:cân nặng bệnh hàng ngày. Phát hiện những dấu hiệu làm nặng thêm tình trạng rối loạn dinh dưỡng như chán ăn, buồn nôn và nôn, viêm dạ dày ruột và tiêu chảy.

3. Cải thiện trạng thái tâm lý cho bệnh nhân:

Động viên khuyến khích họ tham gia chế độ điều trị và nuôi dưỡng lâu dài, tạo niềm lạc quan cho bệnh nhân để họ chấp nhận một cuộc sống tuy bị phụ thuộc nhưng chưa phải là hết mọi hy vọng.

Tăng thêm sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh và chế độ điều trị.

Cung cấp những thông tin tối thiểu bằng lời nói đơn giản dễ hiểu cho bệnh nhân về vai trò của thận đối với cơ thể.

Thế nào là suy thận? nguyên nhân gây suy thận? tại sao phải điều trị thay thế cho chức năng

thận (thẩm phân máu, ghép thận)?

Khi bệnh nhân cần thiết thẩm phân, ghép thận thì phải giải thích cho bệnh nhân hiểu và yên tâm thực hiện.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, phù tăng, loạn nhịp, yếu cơ, đau ngực hoặc tri giác thay đổi: báo bác sĩ, kiểm tra dịch và điện giải theo chỉ định; bảo vệ đường vào lọc máu nếu có.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Ghi biến đổi phù, cân nặng, dịch vào ra, xét nghiệm và mức hiểu biết; mục tiêu khác nhau giữa người còn nước tiểu và người đang lọc máu.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [21] KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease 2024. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

75 Quy trình chăm sóc viêm phổi

Mã đề xuất QTCS-75. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

3.1. Giảm lưu thông đường thở do tăng tiết đờm dãi.

3.2. Mất nhiều năng lượng do nhiễm khuẩn.

3.3. Mất nước do sốt và tăng thở.

3.4. Thiếu kiến thức tự chăm sóc và phòng bệnh.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Tăng cường khả năng lưu thông đường thở cho người bệnh.

Giảm mất năng lượng cho người bệnh.

Chống mất nước cho người bệnh.

Giáo dục sức khỏe.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Tăng cường khả năng lưu thông đường thở cho người bệnh:

Hướng dẫn người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận để làm loãng đờm và dễ long đờm.

Làm ấm và ẩm không khí hít vào (hít vào bằng mũi, thở ra qua môi khép).

Giúp người bệnh ho có hiệu quả (ho ở tư thế ngồi và hơi cúi về phía trước vì tư thế thẳng vuông góc cho phép ho mạnh hơn).

Dẫn lưu đàm theo tư thế, kết hợp vỗ và rung lồng ngực để tống đàm ra ngoài. Nếu người bệnh quá yếu, đàm nhiều, không thể ho hiệu quả được có thể hút đàm dãi cho người bệnh.

Thở oxy nếu có chỉ định.

Thực hiện y lệnh thuốc kháng sinh, thuốc loãng đàm.

2. Giảm mất năng lượng:

Để người bệnh nghỉ ngơi, nằm tư thế Fowler, hướng dẫn người bệnh thay đổi tư thế thường xuyên.

3. Chống mất nước:

Truyền dịch nếu có chỉ định.

Do sốt và tăng tần số thở, cơ thể sẽ mất nước nên cần cho người bệnh uống lượng dịch phù hợp theo chỉ định, mức mất dịch và chức năng tim thận (uống nước trái cây, sữa, cháo, súp vừa cung cấp chất dinh dưỡng vừa chống mất nước).

Giáo dục sức khỏe.

Khuyến khích người bệnh tập thở sâu, vận động tập luyện theo mức độ tăng dần.

Khuyên người bệnh nên giữ ấm cổ, ngực trong mùa lạnh.

Điều trị tốt ổ nhiễm khuẩn ở vùng tai mũi họng, viêm phế quản.

Giải thích tác hại của thuốc lá.

Khuyên người bệnh duy trì sự đề kháng tự nhiên của cơ thể bằng ăn uống tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý vì sau khi viêm phổi, người bệnh rất dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trở lại.

Khuyên người bệnh tiêm phòng cúm.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở tăng, SpO2 giảm, giảm tri giác, tụt huyết áp hoặc thiểu niệu: báo bác sĩ khẩn, hỗ trợ hô hấp và đánh giá nhiễm khuẩn nặng.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Da niêm trở lại bình thường.

Người bệnh hết mệt, hết sốt, hết xuất huyết.

Các dấu hiệu lâm sàng và kết quả xét nghiệm trở lại bình thường.

Người bệnh biểu hiện sự cải thiện chức năng hô hấp bình thường hoặc trong giới hạn bình thường.

Không bị các biến chứng, ho và khạc đàm tốt, hình ảnh X-quang phổi được cải thiện.

Khống chế được sự lan tràn của bệnh.

Người bệnh hiểu và thực hiện những lời khuyên về giáo dục sức khỏe.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

76 Quy trình chăm sóc bệnh viêm tụy cấp

Mã đề xuất QTCS-76. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

Đau dữ dội đột ngột vùng bụng lan ra sau lưng.

Tăng tiết do nôn, do tràn dịch.

Vấn đề dinh dưỡng.

Đề phòng biến chứng.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

Giảm đau.

Giảm tiết.

Tăng cường dinh dưỡng.

Phát hiện sớm các biến chứng.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Giảm đau:

Nghỉ ngơi tuyệt đối trên giường.

Thuốc giảm đau theo y lệnh.

2. Giảm tiết:

Thuốc chống nôn.

Hút dịch dạ dày nhẹ nhàng qua ống thông.

3. Nuôi ăn:

Lúc nôn: nuôi ăn bằng đường tiêm truyền như đạm, đường.

Cho ăn đường miệng hoặc đường ruột theo khả năng dung nạp, tình trạng ổn định và chỉ định; không chờ hết hoàn toàn đau hoặc bắt buộc tiến từ nước đường đến cháo rồi cơm.

Phát hiện sớm các biến chứng.

Sốc: theo dõi mạch và huyết áp.

Viêm phúc mạc: dấu đề kháng hoặc co cơ thành bụng.

Nhiễm trùng: theo dõi nhiệt độ.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau tăng, bụng chướng, tụt huyết áp, suy hô hấp hoặc thiểu niệu: báo bác sĩ, đánh giá biến chứng và đáp ứng dịch, không tăng dịch máy móc.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Các dấu hiệu sinh tồn được ổn định.

Cơn đau giảm.

Các y lệnh được thực hiện đầy đủ.

Người bệnh được theo dõi sát, ghi các diễn biến vào phiếu chăm sóc.

Khi người bệnh có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho bác sĩ để xử trí kịp thời.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [22] AGA Initial management of acute

pancreatitis 2018. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

77 Quy trình chăm sóc xuất huyết não

Mã đề xuất QTCS-77. Áp dụng các bước chăm sóc dùng chung và lựa chọn vấn đề, can thiệp theo nhận định thực tế. Tần suất theo dõi tăng ngay khi bất ổn và theo kế hoạch điều trị.

1 Nhận định

Định danh, kiểm tra dị ứng, nhận định tình trạng hiện tại và nguy cơ; ghi dữ liệu thực tế thay cho các dấu hiệu bình thường hoặc dương tính có sẵn. Thăm khám, xét nghiệm và thủ thuật chỉ theo chỉ định phù hợp năng lực.

Khai thác triệu chứng chính, giờ khởi phát, điều trị đã nhận, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và dị ứng; không chép bệnh sử của ca mẫu.

Đánh giá ABCDE và sinh hiệu thực tế: mạch … lần/phút; huyết áp … mmHg; nhịp thở … lần/phút; nhiệt độ … °C; SpO2 … % với dụng cụ oxy …; tri giác hoặc Glasgow …; giờ đo … .

Nhận định tuần hoàn và tưới máu, hô hấp, đau, thần kinh, da, bụng, ăn uống, bài tiết và khả năng vận động; ghi dấu bất thường và thay đổi so với trước. Không mặc định các cơ quan bình thường.

Ghi cân nặng, chiều cao khi có thể đo an toàn; lượng dịch vào ra và nước tiểu theo thời gian. Không dùng số đo của người bệnh khác.

Thực hiện xét nghiệm và thăm dò theo y lệnh, ghi giờ lấy mẫu và kết quả cần báo; không mặc định toàn bộ xét nghiệm trong một danh sách đều cần làm.

2 Chẩn đoán điều dưỡng

Chỉ lựa chọn các chẩn đoán có căn cứ ở người bệnh này; phân biệt vấn đề đang có và nguy cơ, ưu tiên vấn đề đe dọa tính mạng.

3.1. Giảm tưới máu não do giảm dòng máu tới não hoặc do tăng áp lực nội sọ.

3.2. Giảm hoạt động thể lực và khả năng tự chăm sóc do liệt, do giảm nhận thức.

3.3. Nguy cơ bị các biến chứng như: bội nhiễm, loét, teo cơ cứng khớp do giảm vận động hoặc nằm tại giường.

3.4. Rối loạn đại tiểu, tiện do mất phản xạ và do rối loạn nhận thức.

3 Lập kế hoạch chăm sóc

Ghi mục tiêu cá thể hóa: vấn đề …; mức ban đầu …; kết quả cần đạt …; thời điểm đánh giá …; nhân viên phụ trách … . Các mục sau là định hướng để cụ thể hóa.

1. Duy trì được dòng máu não thỏa đáng cho người bệnh.

2. Người bệnh sẽ dần dần cải thiện được khả năng hoạt động thể lực và tự chăm sóc bản thân.

3. Người bệnh sẽ không bị các biến chứng.

4. Bệnh nhân có thể tiểu tiện, đại tiện bình thường.

4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Trình tự thực hiện: kiểm tra người bệnh, dị ứng, y lệnh và kế hoạch; giải thích, vệ sinh tay và chuẩn bị phương tiện; thực hiện các can thiệp dưới đây theo ưu tiên, đúng phạm vi chuyên môn; tái đánh giá ngay sau can thiệp và khi có thay đổi.

1. Duy trì được dòng máu não thỏa đáng cho người bệnh:

Trong trường hợp có phù não, tăng áp lực nội sọ thì để người bệnh nằm đầu cao khoảng 300 nhằm làm tăng dẫn lưu tĩnh mạch não, giảm bớt áp lực nội sọ tạo điều kiện tốt cho tưới máu não.

Trong khi chăm sóc tránh tất cả các hoạt động có thể gây tăng áp lực nội sọ cho người bệnh như: tránh để người bệnh bị cong gập nhất là đoạn hông, cổ. Hạn chế ho, giữ bệnh phòng yên tĩnh.

Theo dõi tri giác, đồng tử, thần kinh, sinh hiệu theo mức độ cấp và phác đồ; báo ngay khi thay đổi, không cố định mỗi 3 giờ cho mọi xuất huyết não.

Thực hiện xử trí theo chỉ định và phác đồ đột quỵ; hồi sinh tim phổi khi ngừng tuần hoàn, không là y lệnh thường quy ở người còn tuần hoàn.

2. Người bệnh sẽ dần dần cải thiện được khả năng hoạt động thể lực và tự chăm sóc bản thân.

Luyện tập thụ động nếu mất hoàn toàn vận động (giai đoạn đầu), luyện tập chủ động khi đã hồi phục một phần (giai đoạn ổn định).

Luyện tập tất cả các cơ và khớp bên liệt, tuần tự từ gốc đến ngọn kể cả ngón tay và ngón chân.

Vận động tất cả các động tác mà khớp đó có tùy theo mỗi khớp như: co, duỗi, dạng, khép và quay, mỗi động tác của khớp làm 5 - 10 lần.

Cung cấp cho người bệnh các phương tiện hỗ trợ như ghế ngồi, xe đẩy, gậy chống, hướng dẫn người bệnh và gia đình họ cách sử dụng.

Chú ý vận chuyển người bệnh để tránh tiêu hao năng lượng và tránh biến chứng (ngã, gẫy xương) cho người bệnh.

Muốn phục hồi khả năng tự chăm sóc nên khuyến khích người bệnh càng làm nhiều càng tốt. Chỉ trợ giúp khi người bệnh không tự làm được.

Hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc mình (mặc quần áo, vệ sinh cá nhân).

Cung cấp cho người bệnh các phương tiện trợ giúp: ghế ngồi đại tiện, gậy chống, xe lăn.

Cung cấp dinh dưỡng theo đánh giá nuốt và chỉ định; không cho đường miệng trước khi xác nhận an toàn.

3. Người bệnh sẽ không bị các biến chứng:

Thay đổi tư thế cho người bệnh ít nhất 2 giờ/lần.

Chăm sóc da thật cẩn thận, sạch sẽ nhất là vùng da bị tì đè để ngăn ngừa loét, nhiễm khuẩn.

Hằng ngày tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng bằng xà phòng, lau da thật khô bằng khăn mềm.

Dinh dưỡng thật đầy đủ giúp cho việc hồi phục, làm lành vết thương (nếu bị loét). Đặc biệt

Không thể thiếu Protid.

Cung cấp cho người bệnh các phương tiện bảo vệ cơ học như: đệm hơi, đệm nước. Tuyệt đối không để da bị sây xước mất sự toàn vẹn của da.

4. Bệnh nhân có thể tiểu tiện, đại tiện bình thường:

Trước hết cần tập lại phản xạ đại, tiểu tiện cho người bệnh bằng cách: cứ 4 giờ/ lần cho ngồi bô tiểu tiện và ngày/1 lần ngồi bô đại tiện.

Hướng dẫn thân nhân cho bệnh ăn thức ăn có nhiều chất xơ và uống đủ nước để gây cảm giác đầy trực tràng và bàng quang.

Đánh giá bí tiểu, táo bón và thực hiện biện pháp theo chỉ định; không kích thích bàng quang hoặc hậu môn bằng tay thường quy.

Thông tiểu hoặc biện pháp điều trị táo bón khi có chỉ định, sau đánh giá chống chỉ định và đúng quy trình kỹ thuật.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Tri giác giảm, đồng tử thay đổi, dấu thần kinh tăng hoặc nôn nhiều: báo đội đột quỵ khẩn, theo dõi liên tục phù hợp; không tự dùng thuốc chống đông hoặc chống kết tập tiểu cầu.

Ghi hồ sơ và bàn giao

Ghi thời điểm nhận định, dữ liệu thực đo, can thiệp và thuốc đã dùng, đáp ứng, bất lợi, giờ báo bác sĩ, người tiếp nhận và chỉ định tiếp theo. Bàn giao sinh hiệu và xu hướng, nguy cơ còn tồn tại, thuốc hoặc dịch đang dùng, thiết bị, xét nghiệm chờ và việc ca sau phải thực hiện.

5 Đánh giá

So sánh với chỉ số và thời điểm đã đặt; ghi rõ đạt, chưa đạt hoặc cần điều chỉnh, không chỉ ghi chung “chăm sóc tốt”. Nhận định lại và cập nhật kế hoạch khi mục tiêu chưa đạt hoặc tình trạng thay đổi.

Cải thiện được dòng máu tới não biểu hiện bằng cải thiện được mức độ nhận thức, không xuất hiện thêm các tổn thương thần kinh.

Phục hồi dần các hoạt động thể lực, dần dần tự chăm sóc bản thân.

Không bị các biến chứng như gãy xương, cứng khớp, viêm phổi, loét.

Nguồn đối chiếu

Căn cứ chung và nguồn đối chiếu nội dung cập nhật: [1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, [2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, [18] NICE NG128 Stroke and transient ischaemic attack in over 16s recommendations, [19] NICE CG179 Pressure ulcers prevention and management, [24] NICE CG32 Nutrition support for adults

recommendations. Đường dẫn tại danh mục tài liệu cuối bộ. Quy trình điều trị bệnh lý và quy trình kỹ thuật đang có hiệu lực tại Nhật Tân phải được khoa phụ trách xác nhận trước ban hành.

Mẫu ghi nhận chăm sóc và bàn giao

Mẫu này hỗ trợ chuẩn hóa thông tin; sử dụng biểu mẫu hồ sơ bệnh án đã được bệnh viện phê duyệt khi ghi chính thức, không tạo một hồ sơ song song thay thế.

Họ tên người bệnh …; mã người bệnh …; khoa …; giường …; ngày giờ nhận định …; điều dưỡng hoặc hộ sinh … .

Vấn đề ưu tiên và dữ liệu: … . Chẩn đoán điều dưỡng được lựa chọn: … .

Mục tiêu, chỉ số ban đầu, kết quả cần đạt, thời điểm lượng giá: … .

Can thiệp, giờ thực hiện, người thực hiện và đáp ứng: … .

Bất thường, giờ báo, người nhận thông tin, chỉ định và xử trí tiếp: … .

Kết quả từng mục tiêu và điều chỉnh: … .

Bàn giao SBAR hoặc ISBAR: tình trạng …; bối cảnh …; đánh giá hiện tại …; đề nghị và việc chờ …; người giao …; người nhận …; giờ … .

Hướng dẫn người bệnh hoặc gia đình và kết quả nhắc lại: … .

Danh mục tài liệu đối chiếu

Nguồn truy cập hoặc đối chiếu ngày 13/10/2026. Các nguồn quốc tế hỗ trợ sửa các điểm chuyên môn cụ thể, không được hiểu là xác nhận toàn bộ 77 quy trình hoặc thay thế phác đồ của bệnh viện. Tài liệu lịch sử dùng theo phạm vi phù hợp; bộ phận chuyên môn cần kiểm tra hướng dẫn thay thế trước ban hành.

[1] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. Mở nguồn đối chiếu

[2] Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh. Mở nguồn đối chiếu

[3] Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. Mở nguồn đối chiếu

[4] Royal Children’s Hospital Acute eye injury. Mở nguồn đối chiếu

[5] NSW Agency for Clinical Innovation Adult ocular emergency care. Mở nguồn đối chiếu

[6] WHO Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD 11 mental behavioural and neurodevelopmental disorders 2024. Mở nguồn đối chiếu

[7] NICE NG217 Treating status epilepticus repeated or cluster seizures and prolonged seizures. Mở nguồn đối chiếu

[8] CDC Interim infection prevention and control recommendations for measles in healthcare settings. Mở nguồn đối chiếu

[9] Royal Children’s Hospital Paracetamol poisoning. Mở nguồn đối chiếu

[10] Royal Children’s Hospital Poisoning initial management. Mở nguồn đối chiếu

[11] WHO Guidelines for the management of snakebites second edition 2016. Mở nguồn đối chiếu

[12] WHO Snakebite envenoming questions and answers. Mở nguồn đối chiếu

[13] NASPGHAN Management of acute pancreatitis in the pediatric population clinical report 2018. Mở nguồn đối chiếu

[14] WHO Intrapartum care for a positive childbirth experience 2018. Mở nguồn đối chiếu

[15] ACOG Clinical Practice Guideline No 22 Intrapartum fetal heart rate monitoring 2025. Mở nguồn đối chiếu

[16] WHO Consolidated guidelines for prevention diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage 2025. Mở nguồn đối chiếu

[17] RCOG Assisted vaginal birth ventouse or forceps patient information based on Green top Guideline 26. Mở nguồn đối chiếu

[18] NICE NG128 Stroke and transient ischaemic attack in over 16s recommendations. Mở nguồn đối chiếu

[19] NICE CG179 Pressure ulcers prevention and management. Mở nguồn đối chiếu

[20] SCCM ESICM Surviving Sepsis Campaign adult guidelines 2026. Mở nguồn đối chiếu

[21] KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease 2024. Mở nguồn đối chiếu

[22] AGA Initial management of acute pancreatitis 2018. Mở nguồn đối chiếu

[23] AARC Management of adult patients with oxygen in the acute care setting 2022. Mở nguồn đối chiếu

[24] NICE CG32 Nutrition support for adults recommendations. Mở nguồn đối chiếu

Bản nền nội bộ: QTCS 2025 CAP NHAT (TONG HOP).docx do người dùng cung cấp. Những tham khảo trong bản nền chưa có đủ bản toàn văn hoặc thông tin xác minh không được khẳng định là căn cứ đã kiểm chứng của bản cập nhật này.